# 公司深研 第 12 卷

本卷 7 家公司 按四榜最高名次 同名次一年得分及代码安排

资料截止：2026 年 10 月 9 日。所有未来价格、盈利、估值、分红和汇率均为研究假设。研究覆盖 92 家公司、96 个股票证券，全部公司正文通过一万有效汉字门槛。91 个可评估证券形成四期限排名，5 个条件研究证券保留独立分析并暂不排名。全部公司深研和股票模型已覆盖，文档按同一数据版本生成。初版结论可随新增证据修订。数据版本 63ca87a2011995a6。

# 目录

君实生物 01877 HK.....3
亚盛医药 06855 HK.....22
微创医疗 00853 HK.....44
微创脑科学 02172 HK.....63
微创机器人 02252 HK.....81
英矽智能 03696 HK.....99
开拓药业 B 09939 HK.....138

# 君实生物 01877 HK

01877.HK 现价 17.65 HKD

| 期限 | 得分/100 | 全榜梯队 | 基准目标价 | 股价涨幅 | 含分红回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 46.20 | 第 10 梯队 | 7.76 | -56.02% | -56.02% |
| 一年 | 54.20 | 第 10 梯队 | 5.62 | -68.15% | -68.15% |
| 三年 | 61.50 | 第 9 梯队 | 7.18 | -59.30% | -59.30% |
| 五年 | 65.20 | 第 7 梯队 | 9.17 | -48.03% | -48.03% |

梯队按全名单中具备合理评估条件的股票分别计算；条件研究证券明确暂不排名。三年和五年年化以累计现金分红、不再投资计算。

| 年底情景 | 目标价 | 涨跌幅 | 情景权重 |
|---|---|---|---|
| 悲观 | 4.41 | -75.00% | 25% |
| 基准 | 10.76 | -39.05% | 50% |
| 乐观 | 28.80 | +63.15% | 25% |

年底判断加权期望价 13.68HKD，期望股价回报-22.49%。权重是研究判断，并非统计概率；悲观价格亦不是最大损失边界。

| 期限 | 悲观价格/涨幅 | 基准价格/涨幅 | 乐观价格/涨幅 | 基准年化总回报 |
|---|---|---|---|---|
| 半年 | 0.00<br>-100.00% | 7.76<br>-56.02% | 37.57<br>+112.87% | — |
| 一年 | 0.00<br>-100.00% | 5.62<br>-68.15% | 53.43<br>+202.73% | — |
| 三年 | 0.00<br>-100.00% | 7.18<br>-59.30% | 65.29<br>+269.89% | -25.89% |

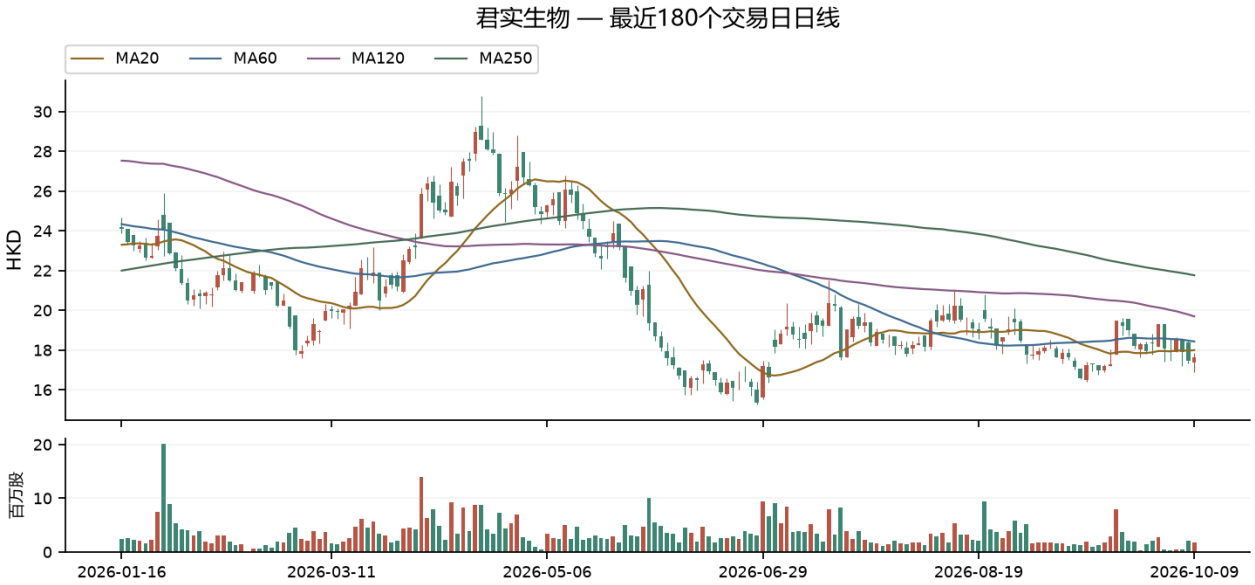
| 期限 | 悲观价格/涨幅 | 基准价格/涨幅 | 乐观价格/涨幅 | 基准年化总回报 |
|---|---|---|---|---|
| 五年 | 0.00<br>-100.00% | 9.17<br>-48.03% | 79.71<br>+351.59% | -12.27% |

| 期限 | 名义目标日 | 模型采用日 | 日历核验状态 |
|---|---|---|---|
| 半年 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 已按香港政府公布假期及 HKEX 证券交易规则核验 |
| 一年 | 2027-10-09 | 2027-10-07 | 已按香港政府公布假期及 HKEX 证券交易规则核验 |
| 三年 | 2029-10-09 | 2029-10-09 | 周末已解析；对应年度交易所节假日日历尚未核验，实际交易日待核 |
| 五年 | 2031-10-09 | 2031-10-09 | 周末已解析；对应年度交易所节假日日历尚未核验，实际交易日待核 |

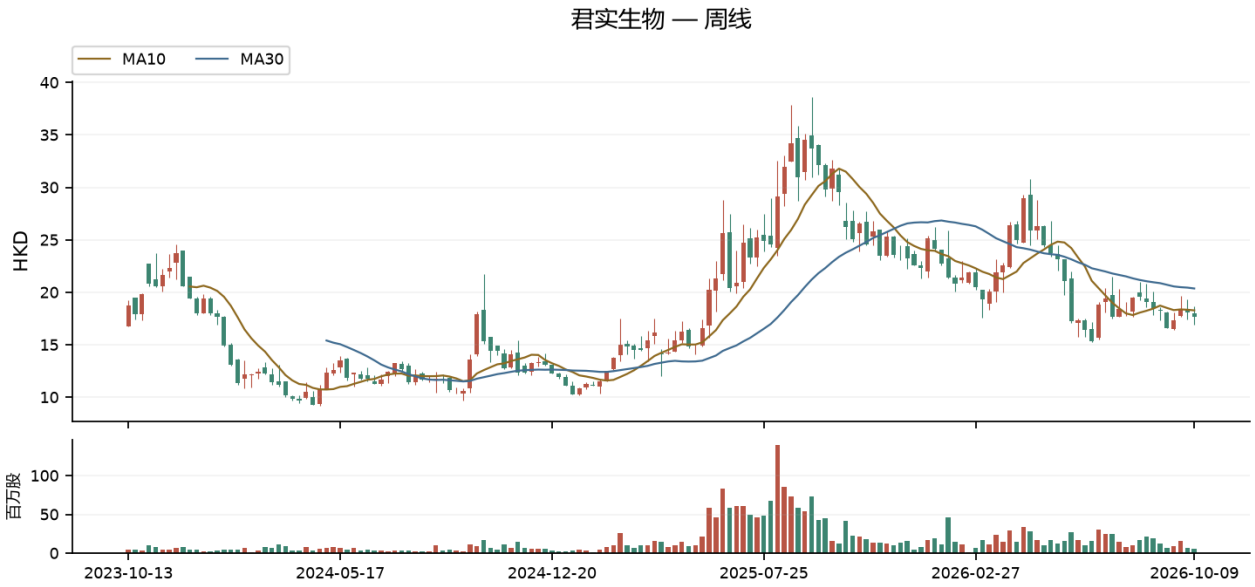
| 证据领域 | 可信度与限制 |
|---|---|
| 总体 | 中 |

| 港币兑人民币变化 | 贬值 5%总回报 | 不变总回报 | 升值 5%总回报 |
|---|---|---|---|
| 半年 | -58.22% | -56.02% | -53.82% |
| 一年 | -69.74% | -68.15% | -66.56% |
| 三年 | -61.33% | -59.30% | -57.26% |
| 五年 | -50.63% | -48.03% | -45.44% |

汇率敏感性固定本币目标价，仅转换人民币投资者回报；不会再把同一次汇率变动叠加到盈利换算假设。




**日线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量保留原股数。来源及异常修复见行情锁版。**




**周线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量保留原股数。来源及异常修复见行情锁版。**

研究基准 2026 年 10 月 9 日收盘，01877.HK，发行人 I046，证券 S053，价格 17.65 港元。资料截止当日收盘前。2026 中报首次业绩 8 月 26 日 17:02、完整报告 9 月 24 日 16:30；2025 年报 4 月 27 日 17:26；9 月股数月报 10 月 5 日 16:34。采用 junshi-v1-netLicensedRights-known2026Bonds-2029Put-equityOptions 版本。本文所有未来收入、概率、融资、估值及分配均为研究假设。

| 期限 | 评分/100 | 悲观 HKD | 基准 HKD | 乐观 HKD | 基准股价回报 | 推荐梯队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 2027-04-09 | 46.2 | 0 | 7.762985 | 37.571422 | -56.017083% | 观察，短期不优先 |
| 一年实际 2027-10-07 | 54.2 | 0 | 5.621598 | 53.431753 | -68.149586% | 条件观察，需重估现金与新药 |
| 三年 2029-10-09 | 61.5 | 0 | 7.184226 | 65.286108 | -59.296170% | 高风险管线选择权 |
| 五年 2031-10-09 | 65.2 | 0 | 9.172004 | 79.705075 | -48.033974% | 进取候选，尚不宜作稳定复利底仓 |

| 年底情景 | 价格 HKD | 相对 17.65 涨跌 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 悲观 | 4.412500 | -75.000000% | 25% |
| 基准 | 10.757852 | -39.048999% | 50% |
| 乐观 | 28.795616 | 63.147968% | 25% |
| 加权期望 | 13.680955 | -22.487508% | 100% |

## 一 投资结论与不同期限的判断

君实已经具备持续增长的药品销售，其商业成熟程度明显高于没有上市产品的纯研发企业。然而现价 17.65 港元包含相当的新一代免疫治疗和抗体偶联药物预期，本研究基准现金分配估值尚不足以支持。半年推荐分数 46.2，一年 54.2，三年 61.5，五年 65.2。长期得分较高反映多个研发项目的潜在价值，不代表当前价买入能实现基准正回报。进取型选择同样需要比较预期回报、资金路径和失败代价，不能只按最大乐观目标排序。

一年基准 5.621598 港元对应约负 68.15%的股价变化，乐观 53.431753 港元则对应约 202.73%上涨。如此宽的范围来自不同商业增长、临床成功、融资和折现假设共同作用，并非价格统计置信区间。悲观模型后续现金不能维持，普通股经济价值按零处理；这是一种压力终局，不能据此断言公司将破产或

股价必然归零。短期价格还会保留市场对研发的选择权，因此年底悲观价格仍按部分价值重估为4.412500港元。

本章与公开瑞银29.1港元目标存在明显差异。差异主要来自把持续产品经营与首付、投资处置分开，明确处理2029年债券回售、银行续贷、可能的股权发行，以及累计亏损对现金分配的限制。研究不为接近机构目标而调整结果。若公司通过更高销售利润、更早海外授权、资产变现或成本控制，证明这些保守假设不再成立，就应该修改模型和分数。对研究结论保持可证伪，比维持看涨方向更有价值。

推荐改善需要看到三个层面的新证据。首先是拓益持续处方增长与收款同步，其次是JS207、JS212或BTLA项目出现足以改变治疗标准的比较数据，最后是2029年前形成可执行资金计划。只发布进入临床、会议入选、监管受理或获准开展研究，不能替代这三项验证。若主要产品价格竞争恶化、研发支出持续增加而现金回流延后，当前估值缺口会扩大，短期推荐应进一步降低。

## 二 收入结构与主营商业化质量

2026年上半年总收入16.96211亿元，其中药品销售14.07315亿元，许可2.54158亿元，服务3082.1万元，其他391.7万元。药品销售占总收入约八成三，是商业底座的主要来源。国内特瑞普利单抗销售约12.99亿元，同比增约36%，说明医院覆盖、获批适应症和商业效率已产生实际效果。其余药品、海外供货与净销售分成没有公开完整逐药拆分，因此不能把14.07315亿元减去12.99亿元所得差额全部称为某一个新产品销售。

许可收入的构成尤其重要。上半年确认不可退还首付2.01921亿元、销售版税4763.1万元，以及按时间摊销的许可收入460.6万元，没有确认里程碑收入。首付能够改善资金条件，但它不是每半年都自动重复的营业收入。将2.54亿元许可收入乘二，再给产品利润倍数，会把一次交易误当持续年金。本模型把已商业化版税作为核心净收入，将未来条件里程碑另列现金假设，并把已在六月现金锚点中的首付排除未来新增收款。

2025年收入24.98420亿元，药品销售约23.01亿元，国内拓益销售约20.68亿元。与2024年19.48317亿元总收入相比，主营产品增长具有连续性，不只是2026年一笔交易带来的总额变化。2026上半年国内拓益12.99亿元也高于2025上半年约9.57亿元，其增长可以支撑全年销量进一步提升，但不能直接保证未来几年保持同样增速。基数扩大后，医院覆盖、患者入组和医保适应症新增的边际贡献会变化。

产品商业化不能只看销售额，还需区分渠道发货与最终患者使用。上半年应收及票据净额7.43754亿元，高于2025年底5.06747亿元；库存4.98818亿元则较5.73110亿元下降。收入增加伴随应收占用可能是正常扩张，也可能反映回款滞后。需要后续检查账龄、客户集中、医院账期及信用损失。应收

总量本身不足以判断收入虚增，但如果销售增长持续高于现金回收，就必须提高营运资金预算和融资需求。

君实销售团队的经济效率已经改善，但还未证明完全自给。上半年销售及分销费用 5.07169 亿元，相比收入仍很大；行政费用 2.79359 亿元，研发 6.43935 亿元。拓益毛利增加要先覆盖这些费用，余下才能服务债务、工厂和股东。收入规模突破某个整数关口不会自动建立盈利护城河，真正重要的是每新增一元净销售带来多少可持续现金，以及不依赖新发行时经营能否延续。

## 三 特瑞普利单抗的适应症与竞争位置

特瑞普利单抗是公司最成熟的核心资产，中国商品名拓益，海外部分市场商品名 LOQTORZI。截止中报日期，公司披露在中国内地获批十三项适应症，其中十二项纳入医保。它在肾癌、三阴性乳腺癌及黑色素瘤等医保适应症中具有差异化地位，但不能把这种具体标签解释为整个 PD-1 市场没有竞争。其他药企拥有不同标签、联合方案、医院关系和国际证据，实际处方选择受到疾病类型、指南、支付和安全性共同影响。

鼻咽癌是拓益国际商业化的重要锚点。亚洲尤其中国的患者基础较大，疾病流行结构与欧美肺癌市场不同。欧美批准可以提高研发和工艺信誉，也能带来较高单价地区的版税，但患者规模较小，不能仅用当地高药价乘以中国病例数。美国合作销售是对特定标签和实际支付体系的商业验证，不等于拓益已经在美国广泛肺癌一线市场拥有份额。估值时必须用各地区真实权利和患者群分别评估。

医保扩展为国内拓益增加可支付患者，也可能降低净销售单价。若每位患者收入下降而接受治疗的患者增长更快，总收入仍可上升；若扩适应症后医院预算不足、竞争替代或治疗周期缩短，放量可能不及预期。因此不能以医保纳入作为单向利好。本文核心收入已经把皮下与静脉制剂的转换合并，并在长期加入竞争衰减，避免旧产品和新剂型同时占有同一患者的完整支出。

国内基准销售代理从 2026 年 27 亿元增至 2027 年 31.5 亿元、2029 年 39.8 亿元、2032 年 46.5 亿元。悲观对应 2026 年 25.5 亿元，随后趋于平台和下降；乐观 2032 年 63 亿元。全部为研究假设，不是公司销售指引。基准早期增长主要来自适应症放量与渠道效率，后期放缓体现同靶竞争和更先进疗法进入。若未来新增病种疗效明显强于现有标准，可提高峰值；若净价被压缩，应先降低单位经济而非单纯增加患者数量抵消。

与 PD-L1、双抗、ADC 等疗法的关系并非总是互相替代。拓益可能与 ADC 组合使用，提高疗效和自身处方量；下一代 PD-1 与 VEGF 双抗也可能取代部分原有 PD-1 处方。本模型分别估计自有药品净收入，但新产品峰值需考虑旧拓益收入被蚕食。组合治疗可以让两个不同药物各有销售，不能把整个联合方案市场额分别全额给每一个组分。这个约束尤其影响 JS207 与 JS212 长期乐观值。

## 四 围手术肺癌与皮下制剂的近端催化

2026 年 5 月 26 日公告披露 NEOTORCH 最终分析达到预设疗效边界，具体包括二至三期人群无事件生存和主要病理缓解率，以及三期人群主要病理缓解率。试验纳入五百零一名可切除二至三期非小细胞肺癌患者，随机、双盲、安慰剂对照设计提高证据质量。公告并未将总体生存列为这一最终阳性结论的主要指标，因此不能写成最终 OS 已被证明显著。OS 属于次要终点，投资逻辑应依可取得的具体证据展开。

7 月 21 日监管已受理拓益联合化疗用于可切除二至三期非小细胞肺癌围手术治疗的补充申请。原有三期患者标签扩至二期患者有潜在市场意义，但审批时点、标签限制及后续医保支付仍有不确定性。受理说明申请进入审评程序，不能等同获批，更不能保证医生在所有可切除患者中选择这一方案。已有国际免疫围手术方案的竞争，也会影响指南、疗程及临床选择。

皮下特瑞普利单抗 JS001sc 在 2025 年 11 月公布三期研究达到主要终点，2026 年 3 月十二项肿瘤适应症上市申请获受理。皮下给药可以减少输注时间和医疗资源占用，改善便利性，尤其在重复治疗中有实际价值。然而与联合化疗同时使用时，患者仍可能需要静脉化疗，便利性并非完整消除住院或输注。商业价值需要按具体场景判断，不能仅凭给药方式把原有市场规模增加一倍。

中报说明皮下三百六十毫克每三周方案的暴露与静脉二百四十毫克方案可比，并未出现新的安全性信号。剂量数字不同，不代表每位患者净收入自动按比例上升。若医保和医院选择允许便利性溢价，毛利可能改善；若皮下定价与原静脉价值相当，主要收益是防御份额、降低给药负担及改善持续使用。本文把两种剂型统一纳入国内拓益收入，审批成功只影响增长路径与利润率，没有另加一套完整产品净现值。

半年期限需要观察受理后的具体进展、医生采纳及全年销售现金，而不以审批传闻抢先确认收益。若皮下获批后回款未改善，或替代静脉的速度快却净价显著下降，新剂型可能只实现防守而非新增盈利。反过来，若更高处方持续性与医院效率得到证明，近端催化会直接提高核心收入质量。投资判断失效条件应是实际单位经济不达预期，而不是某一天技术指标回落。

## 五 海外合作与净经济权益

君实与 Coherus、Hikma、Dr. Reddy’s 及 LEO Pharma 等合作覆盖多个地区，中报披露拓益在五十多个国家和地区获批，在八十多个国家推进合作。国家数量说明注册布局广，不代表每一个市场有相同收入和利润。某些地区患者规模、价格与支付能力很有限，且合作方可能负责营销、供货和注册。估值应看君实取得的供货收入、版税、销售分成及费用责任，而非把合作方所有销售当成君实营业额。

LEO 合作覆盖欧盟、欧洲经济区、瑞士及英国，2025 年收到一千五百万欧元不可退还首付，并有新增适应症里程碑及双位数净销售分成。首付在账上通过合同负债摊销，2026 半年确认四百六十余万元属于会计收入，不是同金额再次现金到账。合同具有固定期限，不能永久按同一比例增长。未来欧洲销售仍需支付、医生教育和合作方执行验证，双位数只说明范围，具体比例未公开时应标成研究假设。

Coherus 在 2024 年终止的项目是 JS006 抗 TIGIT 合作，其先前支付的三千五百万美元期权执行款不退还，拓益相关条款继续有效。不能把 JS006 终止解释为拓益美国商业协议全部终止，也不能把已收执行款重新计入未来现金。2022 年 JS006 十八个百分点版税条款更不能移用到拓益。合作资产、地区及经济条款必须逐项核验，名称相近或同一合作方都不足以支持共享版税率。

本文商业化版税与供货采用净经济收入代理，2026 年基准已商业化版税一亿零五百万元，2032 年五亿四千万元，未来数字均为研究。因为公开财务没有足够逐地区销售及利润分拆，不能伪装成精确美国、欧洲和新兴市场预算。单独保留净收入模型有助于减少全球销售重复，但代价是预测误差较大。若之后公司披露可靠地区流水、供货与版税率，应替换聚合代理并重新校验成本。

## 六 PCSK9 阿达木单抗及抗病毒产品

昂戈瑞西单抗君适达是 PCSK9 产品，2024 年取得初始上市批准，2025 年新增相关适应症，并于 2026 年纳入医保。它面对持续血脂管理的广泛需求，也面临成熟抗体、口服及核酸降脂疗法的价格与依从性竞争。长期价值不能只按高胆固醇患病人数乘以年药价。需筛选治疗标准、他汀不耐受或控制不足患者、实际支付及持续用药，且处方依从性对终生慢病收入特别重要。

君实在中国内地把君适达相关研发、生产和商业化权利许可给博创，合作方负责后续商业化，并按条款支付里程碑与销售佣金。由此君实的收入归属应按净合作经济计算，不是博创终端全部销售。中报未披露可可靠使用的分成百分比，本文将其包含在商业化净许可代理，不给予完整中国 PCSK9 销售估值。若博创销售快速扩张，未来净版税可增加；若终端降价，净收入也会承压。

阿达木单抗君迈康由君实与迈威等合作开发，已有多个自身免疫适应症及医保覆盖。它是成熟机制的生物类似药，市场需求稳定，但竞争者较多、净价持续受压。这里的价值更多是渠道、制造效率及稳定现金，不应获得与首创肿瘤双抗相同的高成长倍数。合作所有权及利润分配不完整公开，本模型其他药品毛利采用净经济代理，并从集团终末回收预留少数权益，不能声称分药财务已精确披露。

民得维是口服抗病毒药，2025 年由附条件批准转为常规批准，已纳入医保并覆盖两千余家医疗机构。其收入受感染周期、患者重症风险、就医与处方行为影响，不能恢复疫情极端阶段需求假设作为长期常态。库存减值与销量波动对利润质量也有意义。公司可以通过基层和电商提高可及性，但这类渠道覆盖不自动形成稳定每年复购，其他药品代理因此采用有限增长并在远期逐步衰减。

## 七 IL 17A 授权交易的确定与不确定部分

罗科奇拜单抗 JS005 用于免疫炎症疾病，2025 年三期银屑病研究达到主要终点、2025 年 12 月上市申请获受理。2026 年 6 月与复星万邦签署大中华区协议，收到二亿一千五百万元不可抵扣不可退首付，未来可获得最高十一亿二千五百万元开发和销售里程碑，以及双位数阶梯版税。首付是真实资本支持，里程碑上限却需要条件实现，不能直接全额加入当前净资产或预计年收入。

本模型大中华区净销售峰值悲观十五亿元、基准三十亿元、乐观五十亿元，分别乘研究版税百分之十、十四、十八，再乘批准及商业化风险因子。精确阶梯条款未公开，这些比例不是合同披露。基准首商业年 2027 年，属于可修改研究时间假设。由合作方承担主要商业化可降低君实新增销售投入，但并不消除临床、监管及合作执行风险，毛利仍保留一定净费用。

银屑病已经有 IL-17、IL-23 等有效治疗，创新药进入市场需要比较皮损清除、起效、持续性、安全性、给药频率与支付。仅说明靶点成熟可以提高生物学可行性，却同时意味着差异化难度较高。IL-17 抑制还需要关注感染及特定炎症性肠病患者风险，不能把三期达到一个主要终点等同最佳整体获益。若新产品在价格或便利性上缺乏优势，应下调峰值而非继续用患者总数支持。

批准后最有用的数据是净销售、处方持续、医保准入及合作方实际付款。首付让交易成为重要积极事件，但对一年估值的增量有限，因为这笔钱大部分已反映在六月现金与历史收入。本文版税降至百分之十的敏感性，一年基准约 5.452776 港元，说明整体价值更多仍受拓益、银行资金和新一代肿瘤项目影响。不能因为一笔高质量合作就忽略其他负债和研发费用。

## 八 BTLA 项目的临床价值与失败路径

Tifcemalimab 即 JS004，是针对 BTLA 免疫抑制途径的抗体。作用机制与 PD-1 不同，具有联合免疫治疗的探索意义，但机制合理并不能保证临床增益。JUSTAR-001 为国际、多中心、随机、双盲、安慰剂对照三期，比较 BTLA 与拓益联合、拓益单用及安慰剂在局限期小细胞肺癌放化疗后巩固治疗的表现。试验计划约七百五十六人，截至报告日期已入组超过七百三十人，预计 2026 完成入组。

接近入组完成可以降低招募风险，不能降低未知疗效到接近零。研究需要比较联合相对拓益单用的增益，而非只证明免疫治疗优于安慰剂。局限期小细胞肺癌已有新的巩固标准，监管和医生会关注与当前治疗的可比获益、总体生存、安全性及经济负担。若联合增加免疫相关不良反应却没有足够生存优势，双药成本和复杂度可能使商业化受限。

BT-NICE 二期食管癌围手术探索仅二十五名患者，披露高客观缓解率、病理完全缓解及一年生存结果，对机制有鼓励意义。小样本、单臂及特定手术患者选择会使结果不适于直接推断随机三期获益。不能

把一年总体生存百分之百看成所有患者长期存活，也不能拿它与别的试验不同人群简单排名。本文该数据作为支持合理性证据，不作为确定批准成功率或全球峰值的核心锚点。

中国局限期小细胞肺癌 BTLA 基准首商业年 2030 年、峰值十八亿元、风险因子百分之五十二，海外净许可另列、仅计新增 BTLA 药品价值。基准不是三期阳性的预测，而是有明确阶段证据仍留失败率的风险调整。若主要终点失败，应把相应组峰值或成功率大幅下调，不能用其他适应症小样本维持原价值。三年期限接近这一证据转换窗口，收益波动会比成熟产品增长更剧烈。

## 九 JS207 双抗与竞争门槛

JS207 是 PD-1 与 VEGF 双特异抗体，试图同时处理免疫抑制和血管生成。全球同机制领域已有高关注项目，使资本市场愿意提前给予较高选择权。然而同靶点不等于同分子，抗体设计、结合比例、暴露、安全性和临床人群都影响结果。君实不能直接继承其他企业双抗的随机疗效，也不能以同类估值乘以管线数量。当赛道拥挤时，晚进入者需要显示更清晰的疗效或安全性优势。

中报披露多项二期组合研究正在进行，2025 年 10 月美国批准开展 JS207 对比纳武利尤单抗的非小细胞肺癌新辅助二至三期临床申请。获准开展研究只是试验合法实施条件，距离完成招募、随访、主要分析和监管审批仍有多个步骤。尤其不能把 FDA 允许试验写成 FDA 批准产品，也不能用二至三期字样推断已经完成全球注册三期。本文首商业时间落在 2030 年以后，反映证据和执行仍需时间。

PD-1 与 VEGF 联合的失败路径包括出血、血栓、伤口愈合、蛋白尿等抗血管生成风险，以及增加免疫毒性。围手术场景对手术安全和延迟更加敏感，早期肿瘤缩小不能替代长期无事件与总体生存。还需检查治疗人群是否包含驱动基因阳性、鳞癌或特定高风险亚组，不能把适合一组患者的结果扩展到整个肺癌。商业模型的可治疗患者数应随标签而调整。

基准中国 JS207 峰值四十亿元、风险因子百分之四十六，海外峰值一百八十亿元再乘净许可率和较低风险因子。峰值高于当前销售底座，显示长期估值确有较大创新预期，但它并非已经签署的交易价值。中国与海外分区，且海外只计研究净版税，不能将潜在全球终端销售全归君实。峰值减少三成的敏感性，一年目标降至 4.928499 港元，体现这一项目对远期价值的重要性。

## 十 JS212 JS213 与早期平台

JS212 为 EGFR 与 HER3 双靶向 ADC，中美已进入早期临床，2025 年 12 月 FDA 允许开展研究。ADC 的价值来自抗体选择、连接子、载荷、内化及患者筛选整体，不是靶点更多就必然更有效。需要关注肺毒性、骨髓抑制、眼毒性、停药率及可持续给药强度。早期客观缓解可能支持扩展研究，但若剂量限制

使长期获益不足，峰值应下降。未取得可靠成熟数据时，不能用临床前图片或体外活性给确定高成功率。

JS212 与 JS207、第三代 EGFR 抑制剂及其他免疫药的组合可能扩大治疗覆盖，也会增加费用和不良反应。模型分别计 ADC 自身药品收入，不把所有组合组分的完整销售额在每一个资产里重复。对 EGFR 突变肺癌患者，已有靶向药耐药后的治疗竞争非常激烈，需要清楚区分既往治疗、耐药机制和 HER3 表达。随机比较的无进展、总体生存与患者体验，比跨试验缓解率高低更能支持份额。

本研究 JS212 中国基准 2032 年开始商业化、峰值三十四亿元，海外 2034 年开始、全球终端峰值二百亿元再转为净许可。概率显著低于已完成三期或获批药物，且全部研发费用仍计入集团预算。海外净峰值减少三成与国内同步敏感，会使一年目标约 5.178948 港元。如此长的现金期限对折现和延误敏感，半年投资不能把未来峰值等同已经形成的盈利。

JS213 为 PD-1 与 IL-2 双功能融合蛋白，仍处于中外一期研究。IL-2 可刺激免疫细胞，但也可能涉及调节性细胞、系统性反应、暴露和耐受的复杂平衡。融合分子在肿瘤微环境中的作用需要临床验证，不能从自然细胞因子作用推出稳定疗效。模型给有限全球净经济组和较低风险因子，明确不是全球全部销售。若出现严重毒性或药效无法在可耐受剂量发挥，应压低或取消这项选择权。

JS107 靶向 Claudin18.2 并使用 MMAE 载荷，JS105、JS111 等小分子以及登革热疫苗也提供研发多样性。多样性可以减少单靶点失败的影响，同时增加试验、制造和管理成本。登革热疫苗尤其需要处理血清状态、安全性及感染增强风险，不能只凭取得全球许可推断早期上市。本文给这些项目有限组值，已转让上海致域的资产不会再按君实完整权利估值；未知范围不补造全球权益。

## 十一 利润质量与历史口径

2026 半年集团亏损 3698.6 万元，归母盈利 2550.1 万元，少数权益亏损 6248.7 万元，三者并不矛盾。归母转正说明股东层面会计结果改善，但集团全部经营还未正向，不能把归母数字直接当全集团自由现金。上半年毛利 12.79431 亿元，扣研发、销售及行政已非常接近经营盈亏边界，再受到财务、联营及其他损益影响。估值应先解释这些来源，不能只把每股盈利二分钱年化后计算市盈率。

其他收益包括出售联营君实润佳收益 1.37815 亿元、转让管线与专利换取上海致域股权收益 4783.7 万元、公允价值收益 2919.3 万元等。出售部分可带来现金，但收益不是持续药品利润；换取股权的交易更不等于同金额可自由支付研发。账面盈利被这些项目明显支持，去除股权激励后的 1.53 亿元归母盈利仍不能作为常态销售盈利。研究同时保留交易带来的合法资产价值和非现金性质，避免两个方向的误判。

出售君实润佳总对价一亿七千万元，其中六月现金流已收到五千一百万元，剩余一亿一千九百万元列应收。本模型把剩余部分作为2027收款假设，并做回收比例敏感性，没有再次把一亿七千万元全部入未来现金。若后续公告证明已收到，应更新现金锚和剔除预测收款。股权处置的收益、现金、账面应收及原资产冲减应一并核对，单独看损益额会高估流动性。

2025年报摘要中五年财务资料与正式国际会计准则报表有不同口径，集团损失摘要与IFRS正文不完全相同。本文历史财务选用正式IFRS报表，2025集团亏损9.72693亿元，2024亏损13.81580亿元，分别对应明确报表期间。不能把摘要毛利或亏损与IFRS研发、现金及净资产交叉拼接。口径差异在来源记录中保留，研究没有把差异擅自解释为经营异常。

毛利率还受一次性库存减值、许可结构和产能利用影响。上半年存货相关减值规模约一亿三千余万元，可能分布于销售成本及研发消耗，不能直接把全部加回推算一个所谓真实毛利。产品价格、产量和损耗变化影响长期毛利，许可首付占比则使组合毛利暂时较高。本文核心药毛利按悲、基、乐分别设定并公开，不能用当期混合毛利率统一套所有新品和服务。

## 十二 研发 制造与资本投入

研发6.43935亿元同比下降，说明公司在项目优先级、试验资源及费用管理上有所调整，但下降本身不必然提高价值。若停止低潜力项目可改善资本效率；若推迟关键试验导致延后上市，费用减少可能只是现金时间移动。本文2026基准全年研发13.2亿元，随JS207、JS212及国际BTLA推进逐步增加，2032年17亿元。未来研究需以项目进度和试验复杂度校验这一预算，而非永久按低费用增长。

公司物业厂房设备约50.41339亿元，占用大量已投入资本。半年购置厂房设备现金3.37161亿元，承诺资本开支7.96443亿元，另有建设应付5.17189亿元。资产大不等于价值等额可变现，厂房价值取决于质量体系、适合产品、产能利用与后续维护。若实际需求远低于产能计划，折旧、闲置与资金压力会持续影响股东回报，不能以有大工厂为由给额外制造净资产溢价。

资本承诺与现有建设应付可能指向不同付款义务，但不能仅把全部余额相加后一次扣现金，随后又在年度资本预算重复扣。本文以未来现金资本支出路径承接义务，并明确预算是研究假设，未称已知道每份工程付款时点。若公布更完整付款表，应替换预算并检验年内最低现金。资本开支增加两成的敏感性仍保持基准融资路径可行，但价格降至约5.409640港元，显示真实付现金对估值有直接影响。

会计折旧与现金资本支出必须分开。本文加回的是已进损益的厂房设备及无形资产折旧，不把使用权折旧一并加回后忘记租赁现金。租金现金仅另扣超过已入费用的差额，避免已留成本又完整扣本金的重复。银行利息采用全部应计负担，资本化部分不会再次额外扣在现金桥；资本支出预算排除已通过利息支付的同一成本。这样的边界需随报表更新复核。

## 十三 现金 理财 负债与真实跑道

六月银行余额及现金 27.05943 亿元，流动理财 9.63885 亿元，合计 36.69828 亿元，另有受限存款 2633.7 万元。理财可提供财资收益，却不是同银行活期完全相同的流动性，需要关注赎回时间、基础资产和风险。本文起始现金与理财分别滚动，基准 2026 赎回五亿元、2027 再赎回剩余，受限存款按已披露一年内释放条件在 2027 处理。非流动战略股权不会进入短期研发跑道。

非流动金融资产 19.35342 亿元包含上市与非上市股权、优先股和合伙投资，部分具有可见市场价格，部分依赖估值假设。即使上市，也可能有持有目的或变现限制，不能把全部当随时可用现金。集团还确认其他有限合伙人的金融负债 4.10493 亿元，因此战略投资并非全部无负担属于普通股东。模型仅在有限终末期按折价回收，并扣合伙负债与少数权益，避免在运营现金、投资净值和许可中多重计价。

六月银行借款 48.08773 亿元，科技债等其他借款 10.09103 亿元，借款合计 58.17876 亿元，明显高于现金和流动理财。随后 7 月 22 日收到三亿元债券款、8 月 21 日收到七亿元债券款，票息分别 2.59%与 2.55%，都在 2029 年到期。研究同时增加现金和债务，不把借钱当净财富增加。六月已经包含年初十亿元债券，新增历史事件只追加后两期，避免债与现金各自漏算或重算。

年初十亿元科技债期限三加二，持有人在第三年有赎回选择。本文基准 2029 年按全部回售处理，加上 7 月与 8 月两期，合计 20.09103 亿元债券现金偿还发生在三年目标之前。即使法定最终到期可以延至 2031，也不能默认所有持有人同意延期。现金桥将债券与银行净偿还分开，三年目标日债余额为零；年度内还款具体时点仍需预留更保守流动性，不能只检查年底余额。

六月全部借款的到期分布为一年内 13.98507 亿元、一至两年 16.25880 亿元、两至五年 17.99245 亿元及五年以上 9.94244 亿元，四档合计 58.17876 亿元，包含银行及已发行债券，不能全部称为银行借款。模型把债券按公开条款单独偿还，其余银行逐年净偿还路径依赖部分续贷，并非银行已经承诺展期。低利率、抵押资产和融资渠道可以提高成功可能，但核心业务现金不足时续贷条件可能变严。银行短债不续贷的敏感性出现资金失败，这一结果提示经营增长与资本市场不能分开研究。

## 十四 融资与股数的对应关系

9 月月报法定股 10.26689871 亿，包括 H 股 2.602957 亿、A 股 7.66394171 亿；A 股库存股 81.5871 万，流通经济股合计 10.25874 亿。H 股价格只能与全公司经济股份对应每股价值，不能用全部公司利润除以 H 股数量。行情显示 H 股市场值约 45.94 亿港元属于该类股份市值，不是全公司用同一 H 股价格标记的总价值。跨市场同股经济权利和不同交易价格必须清楚区分。

君实 A 股未在用户推荐证券名单，本文不另给 A 股排名，但 A 股期权及总股数会影响 01877 每股价值。已授 A 股期权 2367.5 万、H 股 1321 万，总计 3688.5 万；H 股方案尚可授予额度不能视为当前已发行。A 股行权价 46.67 元人民币、H 股 32.30 港元，截止研究价远低于 H 股行权价，因此基准不假设近期行权。乐观情景则需要同时加入新股和实际行权收款，不能只扣稀释却漏现金。

2026 年 9 月公告确认部分 A 股首期行权条件满足并取消若干离职或考核不符合期权，预留授予七十一万五千份。首期可行权 1146.75 万，未来预留和第二期各有有效窗口。乐观研究分别在 2027 与 2028 安排 A 股行权，H 股在 2028 与 2029 安排，属于价格和条件支持下的假设，不是已经收到现金。行权是否发生还需看 A 股市价及个人选择，不能因 H 股乐观目标高就自动认定 A 股全部行权。

基准预计 2029 年发行三十亿元权益资金，假定发行价 22 港元、净到账百分之九十七，新增一亿五千万股，另计后续员工权益。无这笔融资，模型最低现金约负 20.76 亿元；仅发行二十亿元仍出现现金不足。三十亿元不是董事会融资计划，而是经营与还债预算下的研究条件。公司若取得更早现金里程碑、出售可用投资或银行延长债务，可减少发行，届时需要把现金、负债和股数同步重算。

额外 2030 年八亿元发行的测试并非最低生存所必需，剔除后基准仍有最低 8.73245 亿元现金，且现有股东少受稀释，因此正式基准仅保留 2029 三十亿元。发行价下降三成会降低一年每股目标至约 5.335499 港元，反映融资金额相同却需要更多新股。权益激励费用在现金桥加回，与实际股份或未来员工股数另处理，现金替代因子为零，不会一边稀释一边重复扣现金薪酬。

## 十五 估值模型与重要敏感性

本文采用有限股东现金分配估值，先预测已上市药、净版税和风险调整新品收入，再扣完整研发、销售、行政、资本、营运资金、利息与偿债，最后按各年实际稀释股份折现可分配现金。当前现金和未来发行都在现金滚动中，不能再额外加到终值。2035 年后也必须先弥补约 111.38589 亿元累计亏损，并留保守储备才假设分红。可分利润滚动统一取预测增量的百分之九十，另外百分之十作为储备代理；这不是实际逐主体法定分配核算，集团亏损锚也不等于已核验的母公司法定可分利润，后续须用主体报表替换。

基准 2027 收入 36.839 亿元，正常利润代理负 3.55533 亿元；2029 收入 48.7462 亿元、正常利润约 2.64006 亿元；2031 收入 60.2898 亿元、正常利润约 8.74622 亿元。这些利润排除已收大额首付和投资处置收益，也不等同未来 IFRS 归母精确预测。新品采用不同上市时点、峰值、概率和净许可率，研发却完整支出，因此模型不会因对收入乘成功率而同幅缩减必须先发生的试验成本。

基准一年 5.621598 港元、三年 7.184226 港元、五年 9.172004 港元主要由 2036 年起分配与 2041 年净回收折现而来。长现金等待使目标低于一个给近期正常利润高倍数的模型，理由是股东不能立即自由

拿走工厂、借款和战略投资的账面额。有限截止也没有给予无限期永续增长。若后续有明确更早可执行股东分配或出售，应加入真实现金事件，不能仅用想象退出倍数提升估值。

折现率基准百分之十三，下降两个百分点一年约 7.027361 港元，上升两个百分点约 4.518926 港元，显示远期现金价值对资本成本敏感。国内拓益收入提高两成，一年约 7.876849 港元；下降两成则资金路径失败。研发全部增加两成也导致压力缺口，资本全部增加两成尚维持流动性。这些单变量结果不是总风险边界，现实中价格、疗效、融资和费用可能同时恶化，不能按各测试简单相加。

所有新品推迟两年，一年基准降至 3.464173 港元、五年 5.652023 港元，仍能维持设定融资路径，但远期收益减少。BTLA 概率下降十五个百分点，一年约 5.197843 港元；非流动金融回收归零约 5.427834 港元。由此投资的核心并非战略股权账面值，而是主营药现金与新一代产品执行。忽略亏损限制的一年参照约 6.553477 港元仍低于现价，说明结论不是单由分红限制产生。

乐观一年 53.431753 港元依赖国内拓益高增长、多个新品较早成功、较高净权益峰值、较低折现率、期权行权现金及无需新增大额市场融资。2032 乐观收入约 150 亿元，远高于当前规模，必须得到强临床和商业证据支持。乐观值用于展示上行选择权，不应当作常态目标或获利概率。三年乐观年化约 54.64%、五年约 35.20%，高收益的相反面是多资产失败或融资条件恶化时现有股东价值大幅下降。

## 十六 半年日线与关键观察价格

日线覆盖七百三十九个真实交易日，使用以基准日名义价归一的复权价格，20、60、120 及 250 日均线分别 17.998、18.434、19.696667 及 21.76404 港元。17.65 收盘分别低于这些均线约 1.93%、4.25%、10.39%及 18.90%，中期均线仍在上方形成连续观察区。不能仅因已经跌多就判断便宜或趋势反转，价格低于历史峰值也不能替代商业估值。

最近五交易日均线变动，20 日略上升 0.256239%，60 日下降 0.807146%、120 日下降 1.941587%、250 日下降 1.162577%。这表示短反弹开始改变最短平均值，但中长结构仍偏弱，不能把一条短均线上翘当多头排列。二十日回报约 2.975502%，六十日负 12.710184%，一百二十日及二百五十日回撤更大。技术上应先区分跌势减缓与重新建立上升趋势。

最近二十与六十日最低观察位 16.40 港元，距收盘约负 7.08%；二十日高点 19.63 距现价约 11.22%，六十日高点 20.98 距约 18.87%。这些是区间极值，尚未经多次触碰和成交结构筛选，所以称观察位而非保证支撑阻力。若收盘稳定越过 18.43 再试 19.63，并伴相对强弱持续改善，半年量价评分可提高；若反弹在均线附近反复失败，应保留下降判断。

日线五十二周最高约 32.62、最低 15.25，现价距高点约负 45.89%，期间最大回撤约负 52.88%。低点距现价约负 13.60%，并非最大下跌空间，破位后价格仍可继续下降。日线和周线五十二周高点不同，来自二百五十二日与五十二周样本窗口边界，不能混用。研究不采用旧高点作为年底合理目标，更不把从高点折半自动定义为安全边际。

10 月 9 日开 17.39、最高 17.84、最低 16.91、收 17.65，较前收 17.46 上涨约 1.09%，当日成交额约 3039.43 万港元。单日收在开盘之上能说明该日价格回升，不能确认一个大级别底部。要看随后是否保持较高低点、是否站回中期均线，以及回落时是否量能下降。短期观察逻辑若在 16.4 以下持续收盘且放量，应视为反弹路径失效，而不是继续用“跌多会涨”维持推荐。

## 十七 成交量 相对强弱与辅助指标

当日成交 175.66 万股，最近五、二十、六十日平均分别约 102.20 万、192.77 万及 257.68 万股。当日量比 0.918880 采用此前二十日均量作为分母，略低于常态，并未显示强势突破所需的显著新增参与。五日均量低于二十与六十日，也支持反弹仍较谨慎。成交额与股数单位均已明确为港币元和股，不能把股误当手而将交易热度扩大数百倍。

最近二十日上涨日和下跌日各十天，上涨日累计 2316.28 万股，下跌日 1539.17 万股，比例约 1.504894。这个指标对短期修复有一定支持，但它只按收盘涨跌分组，不能识别每笔主动买卖。下跌趋势中少数大成交反弹也能使比例升高，不能据此宣称主力吸筹。没有逐笔、可靠自由流通股及完整换手资料时，本文不制作精确成本分布或资金身份图。

行情换手字段缺失；如用 H 股已发行 2.602957 亿股计算，当日成交约占 0.675%，这只是类别发行股数的简化周转，不是自由流通换手率，也不能同 A 股换手直接比较。限售、战略持有和投资者结构会改变实际可交易筹码。技术评估重点仍是成交量的历史一致口径、价量在关键位是否同向，以及流动性是否足以支持计划交易规模，不用缺失字段填造精确机构持仓。

二十日相对恒生指数超额约 5.95341 个百分点，相对创新药行业基准约 2.094764 个百分点，说明近期反弹比市场和行业略强。六十日却分别落后约 9.522281 和 9.487192 个百分点，反映短修复未弥补中期失地。行业使用国证港股通创新药粗粒度指数，不能完全代表君实具体产品竞争；该指数仅用于价格回报，成交量不适用。市场超额与行业超额有关联，评分不重复作为两个独立强信号。

日线 RSI 约 46.28，尚未显示持续强势区；MACD 差值负 0.087218、信号负 0.034992、柱值负 0.104453，短动量仍偏弱。ATR 约 0.995332 港元，相当于价格 5.64%，说明正常波动也很大。ATR 是历史平均真实波幅，不是单日最大损失或止损必然成交范围。指标只作为趋势与波动辅助，不能同时因 RSI、MACD 和均线相似信息反复加分。

## 十八 周线与技术判断的失效条件

周线一百五十七期，20、60、120 周均线 18.13、22.960833、19.189083 港元，没有足够二百五十周数据，因此不补造。五周斜率分别负 8.944804%、负 3.358073%及正 1.27635%，中短期仍下降。周线 MACD 柱虽转为正 0.196295，但差值与信号都在零轴下，反映下行动量可能减缓，未必进入长期牛市。日与周信号不同可以并存，不能只取最看涨的一组。

最近周量比 0.319245，需考虑截止周实际交易天数和休市影响，不能把缩量直接当投资者失去兴趣或卖盘枯竭。二十周上涨累计 1.38228 亿股、下跌 1.74122 亿股，比例约 0.793857，与短日线修复形成差异。周 RSI 约 43.32，周 ATR 约 2.36844 港元、价格 13.42%，体现多周持仓波动更大。周量应与完整周和相同节假日样本比较，才适合修改趋势评价。

半年技术改善可按顺序观察：先收复 18 元附近最短均线，再稳定穿越 18.43，随后验证 19.63 及 20.98 区间。突破时成交至少应相对自身历史明显提高，回踩时成交减少且不失守，才更能支持结构变化。这里只给观察流程，未给保证收益的交易规则。价格成功突破而基本面没有新增证据，可能只提高短期量价分，不应同时提高所有长期经营和估值分数。

明确反证包括放量跌穿 16.4 后不能迅速修复、六十日持续跑输行业、均线继续下弯，以及反弹在 19.63 附近发生明显价格失守。若财务或临床重大坏消息造成跳空，历史支撑可能失效，不能按图形机械加仓。技术止损也可能受流动性和开盘缺口影响。本文量价结论用于半年排序与观察，不用于断言市场参与者身份或替代未来现金模型。

## 十九 年底价格与权重的解释

年底悲观 4.412500 港元、基准 10.757852 港元、乐观 28.795616 港元，分别对应现价负 75%、负 39.05%及正 63.15%。三种情景以各自长经营价值为基础，再用近端市场兑现系数处理不足三个月的信息消化，系数是判断假设，不是统计校准。临床利好、产品现金和融资确定性提高可支持乐观方向；销售、债务或风险偏好恶化可支持悲观方向。年底目标不是把一年价格按月份线性缩放。

默认百分之二十五、五十、二十五权重的期望 13.680955 港元，对应负 22.487508%。若悲、基、乐改为四十、四十、二十，期望 11.827264 港元、负 32.990006%；若改为二十、四十、四十，期望 16.703887 港元、负 5.360413%。即使提高乐观权重，年底期望仍未必超过现价，这解释短期排序较低。权重不是获利概率，投资者不能把加权均值理解成最可能精确落点。

瑞银 9 月 4 日新闻明确将目标由 32.1 降至 29.1 港元、维持买入，理由涉及更激烈全球竞争。相对 17.65 涨幅约 64.87%，接近本文年底乐观端但不意味着两个模型相同。新闻没有明确原研报目标期

限，不能擅自称确定十二个月，更不能直接用为年底基准。摩根大通 10 月 6 日行业报道谈利率敏感性，未给君实具体目标，研究仅把它作为行业观点保存，不填造价格。

## 二十 三年 五年与十年经营持续性

三年持有到 2029 年 10 月 9 日，需要经历拓益增长、皮下与扩标签转化、BTLA 进一步证据以及 20 亿元以上债券偿还。这个时点的资金压力早于大量早期产品收入，因此临床潜力不能自动解决偿债。基准股价回报约负 59.30%，年化约负 25.88%；乐观约正 269.89%、年化 54.64%。收益路径高度分叉，最值得跟踪的是经营回款和在成熟数据前保持研发能力，而不是只盯某个会议日。

五年目标 2031 年 10 月 9 日，JS207 和 JS212 有机会从早期进入成熟比较验证，成功时新产品与海外净权益会扩大公司收入和利润。基准股价回报负 48.03%、年化负 12.27%；乐观约正 351.59%、年化 35.20%。模型至此尚无股息，总回报与股价回报一致。若行业、资金和产品证据共同改善，应重新评估增长、融资规模与分配时间；单凭持有时间变长，不会让不合理买入价格自动安全。

十年经营展望关注 2036 年前后产品接续。拓益会面对更强新机制、专利与价格压力，企业必须靠临床和研发组织持续产生第二、第三增长来源。若 JS207、JS212 或其他平台获得验证，商业基础可能从单一 PD-1 扩展到免疫与 ADC 组合；若这些项目多次失败，则现有厂房和销售队伍可能成为成本负担。研发管线数量不是长期竞争优势，重复产出有效且可盈利产品才是。

长期资本分配质量同样决定十年回报。战略投资可以引入技术和合作，但若资金长期分散于低透明非流动股权，普通股东可能承担负债却难以收到回报。未来应观察公司是否把核心现金优先用于高证据项目、偿还高风险债务，并在可分配条件满足后透明地回馈股东。模型 2036 开始有限分配只是研究政策，董事会没有作此承诺；投资者需要用真实决策检验而非把预测分红当已宣布。

推翻当前谨慎结论的正面证据，应包括更高且可持续的拓益净现金、重要新品随机临床明确领先、实质海外交易收款，以及 2029 债务不用大额低价发行即可处理。推翻长期候选定位的负面证据，则包括主要新一代项目安全或疗效失败、商业净价长期下降、不可控研发投资、续贷中断或显著治理问题。每次更新都应同步改收入、概率、现金、股份和期限排名，避免只把新闻标题换成更乐观文字。

## 来源与模型核验

核心来源：2026 中报 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0924/2026092400305.pdf ；首次半年业绩 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600488.pdf ；2025

年报 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0427/2026042701561.pdf ；9月股数 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1005/2026100500920.pdf 。

二期债 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0722/2026072201137.pdf ；三期债 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0821/2026082101232.pdf ；首期债 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0126/2026012601334.pdf ；围手术最终分析 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0526/2026052602052.pdf ；围手术受理 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0721/2026072101139.pdf 。

瑞银公开新闻 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/01877/AAFN/NOW.1542986/research-report ，2026年9月4日13:37；摩根大通行业新闻 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/01877/AAFN/NOW.1547876/research-report ，10月6日10:19。原始机构研报和确切目标期限缺失。其余逐条公告、发布日期、原始行情路径与模型输入保存在 junshi_sources、junshi_model 及证券 S053 来源记录中。

# 亚盛医药 06855 HK

06855.HK 现价 28.22 HKD

| 期限 | 得分/100 | 全榜梯队 | 基准目标价 | 股价涨幅 | 含分红回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 43.60 | 第 10 梯队 | 12.52 | -55.63% | -55.63% |
| 一年 | 51.60 | 第 10 梯队 | 9.15 | -67.56% | -67.56% |
| 三年 | 57.30 | 第 10 梯队 | 11.80 | -58.17% | -58.17% |
| 五年 | 58.80 | 第 9 梯队 | 15.20 | -46.13% | -46.13% |

梯队按全名单中具备合理评估条件的股票分别计算；条件研究证券明确暂不排名。三年和五年年化以累计现金分红、不再投资计算。

| 年底情景 | 目标价 | 涨跌幅 | 情景权重 |
|---|---|---|---|
| 悲观 | 0.00 | -100.00% | 25% |
| 基准 | 16.27 | -42.34% | 50% |
| 乐观 | 46.08 | +63.30% | 25% |

年底判断加权期望价 19.66HKD，期望股价回报-30.34%。权重是研究判断，并非统计概率；悲观价格亦不是最大损失边界。

| 期限 | 悲观价格/涨幅 | 基准价格/涨幅 | 乐观价格/涨幅 | 基准年化总回报 |
|---|---|---|---|---|
| 半年 | 0.00<br>-100.00% | 12.52<br>-55.63% | 61.99<br>+119.68% | — |
| 一年 | 0.00<br>-100.00% | 9.15<br>-67.56% | 91.04<br>+222.61% | — |
| 三年 | 0.00<br>-100.00% | 11.80<br>-58.17% | 112.25<br>+297.77% | -25.21% |

| 期限 | 悲观价格/涨幅 | 基准价格/涨幅 | 乐观价格/涨幅 | 基准年化总回报 |
|---|---|---|---|---|
| 五年 | 0.00<br>-100.00% | 15.20<br>-46.13% | 138.28<br>+390.02% | -11.64% |

| 期限 | 名义目标日 | 模型采用日 | 日历核验状态 |
|---|---|---|---|
| 半年 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 已按香港政府公布假期及 HKEX 证券交易规则核验 |
| 一年 | 2027-10-09 | 2027-10-07 | 已按香港政府公布假期及 HKEX 证券交易规则核验 |
| 三年 | 2029-10-09 | 2029-10-09 | 周末已解析；对应年度交易所节假日日历尚未核验，实际交易日待核 |
| 五年 | 2031-10-09 | 2031-10-09 | 周末已解析；对应年度交易所节假日日历尚未核验，实际交易日待核 |

| 证据领域 | 可信度与限制 |
|---|---|
| 总体 | 中 |

| 港币兑人民币变化 | 贬值 5%总回报 | 不变总回报 | 升值 5%总回报 |
|---|---|---|---|
| 半年 | -57.84% | -55.63% | -53.41% |
| 一年 | -69.18% | -67.56% | -65.94% |
| 三年 | -60.26% | -58.17% | -56.08% |
| 五年 | -48.82% | -46.13% | -43.43% |

汇率敏感性固定本币目标价，仅转换人民币投资者回报；不会再把同一次汇率变动叠加到盈利换算假设。




**日线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量保留原股数。来源及异常修复见行情锁版。**




**周线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量保留原股数。来源及异常修复见行情锁版。**

研究基准：2026 年 10 月 9 日香港收盘；06855.HK，I021 / S026；现价 28.22 港元。资料按公告首次公开时间截断，不使用此后临床读出。模型 ascentage-v4-equityRewards-noCashSubstitute-finiteDistributions，独立计算与电子表格桥均已核对。一年实际目标为 2027 年 10 月 7 日，名义目标 10 月 9 日遇周末且 10 月 8 日为重阳节休市；现金折现按实际日期重算。本章有效正文不含标题、表格、来源及共用宏观内容。

| 项目 | 半年 | 一年 | 三年 | 五年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分/100 | 43.6 | 51.6 | 57.3 | 58.8 |
| 悲观目标 HKD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基准目标 HKD | 12.5225 | 9.1550 | 11.8039 | 15.2035 |
| 乐观目标 HKD | 61.9943 | 91.0401 | 112.2507 | 138.2843 |
| 基准股价回报 | -55.63% | -67.56% | -58.17% | -46.13% |
| 基准累计股息 HKD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基准年化总回报 | — | — | -25.21% | -11.64% |

亚盛在本轮研究中归入审慎观察梯队。进取型标准仍要求成长机会能够转化为现有股东回报；它有两款中国已上市产品、多个全球注册试验和凋亡通路研发能力，但当前经营现金不足以支持完整全球开发。股价经过大幅下跌，并不能消除融资与临床两重约束。半年不优先推荐；一年等待现金、融资和入组证据改善；三至五年具备上行选择权，却需要超出现有融资容量的资金和可验证的竞争优势。证据可信度为中：财报和证券身份清楚，未来发行、试验结果及海外价格仍高度依赖假设。

三种价格是明确假设下的条件估值，不是统计置信区间。悲观的零值用于融资失败及股权价值耗尽压力测试，不能解释为年底股价必然归零或损失上界；市场可以长期给予临床选择权价格，也可能以低价资本重组改变普通股权益。基准采用完整研发、延迟海外商业化及持续融资后股份稀释，因此显著低于现价。乐观依赖多项国际试验同时成功、较高净销售和有利发行价格，不能当作一个独立药品成功便可获得的回报。评分没有用乐观极值直接抬高排序。

结论成立条件是：既有两款药的患者渗透持续扩大，主要全球试验按照足够完整的对照证据推进，短期银行贷款能够续作，未来资本能够在模型假定价格附近募集，并且销售费用和研发项目排序受控。若取得可信赖的注册结果、真实到账的大额授权款或大幅降低临床现金需求的合同，基准应上修。若商业收入减速、关键临床出现不利生存或安全信号、银行不续贷、融资价格显著下降，估值与推荐需要进一步下修。

## 一 公司经营结构及收入权利

亚盛的主要经济活动是自主发现、临床开发和商业化小分子肿瘤药。核心技术围绕细胞凋亡、激酶及蛋白降解展开。奥雷巴替尼已在中国慢性髓性白血病场景形成商业收入，利生妥于二〇二五年获得中国复发难治慢性淋巴细胞白血病及小淋巴细胞淋巴瘤的附条件批准。其它药物大多处于注册试验或早期开发。投资上需要把成熟商业产品现金、已支付合作款、临床资产远期现金和股东未来融资成本分开，不能只数管线项目个数。

二〇二六年上半年总收入三亿零二百二十一万元，同比增长约百分之二十九；其中产品销售二亿八千二百三十七万元，约占百分之九十三点四。商业化权利收入一千八百六十九万元，其他收入一百一十六万元。产品销售增长约百分之三十二点六，说明既有药品商业需求仍在增加；商业化权利收入与去年同期相同，其来源是期初合同负债的分期确认，不代表这一半年新收到同额现金。总收入与现金销售不是完全同义，估值不能把同一首付款再资本化一次。

中国大陆贡献了全部已披露客户收入。全球研发与全球上市身份已经建立，全球商业化收入仍未出现。因此“国际化公司”描述的是资产权利、开发组织和融资渠道，不等于当前收入多地域分散。国内医保降价、医院准入和渠道结算，对现金流的影响仍最直接；海外利率变化主要影响远期资产折现和融资承接。两者影响机制不同，不能把人民币贬值简单解释为所有收入受益。

收入还有较高客户集中度。中报客户甲收入二亿一千零四十一万元，约占总收入百分之六十九点六，客户乙和客户丙分别三千九百六十九万元及三千一百一十四万元。集中度部分反映销售合作与药品配送组织，而不是终端患者集中；不过渠道客户的采购安排、账期及合作关系仍会改变季度收入节奏。不能用配送商采购直接推算医院处方持续率，也不能把所有库存采购都解释为最终患者用药。

二〇二一年的信达合作涉及奥雷巴替尼中国商业化权利，公司保有相关开发知识产权。预付和开发监管里程碑记录为合同负债，并在商业化期限内摊销，销售里程碑满足条件时确认。二〇二五年累计进入有关合同负债的金额三亿四千九百五十二万元，当年其中三千七百四十九万元随时间确认收入。二〇二六年上半年同类摊销一千八百六十九万元，不能当成一条无限增长的产品销售线。本模型不把这项既已收款的摊销列入未来经济现金。

自主产品与合作产品的利润率也需要按公司实际收入层级分析。财报产品成本很低，主要与小分子制造成本、存货和服务成本有关，不说明所有利润属于股东。销售团队、医学推广、注册研发、合作经济安排及总部管理费都在毛利之后扣除。模型的核心产品毛利率按悲观至乐观分层，低于短期会计毛利率，并保留足额销售预算。使用端市场规模或患者账单总额直接乘高毛利，会显著夸大股权现金。

## 二 奥雷巴替尼的临床基础与市场边界

奥雷巴替尼是第三代激酶抑制剂，核心中国适应症集中在耐药慢性髓性白血病。二〇二一年批准及后续适应症扩展提供了真实商业基础，二〇二五年有关中国慢性髓性白血病适应症进入医保，提高可负担性。疾病通常需要长期监测和持续治疗，产品价值不仅取决于一次缓解率，还取决于分子反应持续、疾病进展、安全性、停药和患者支付。医保准入扩大患者覆盖的同时压低单位价格，销售增长需要新增患者超过净价格下降。

慢性髓性白血病已有多个成熟治疗选择。前线药物、其它第三代抑制剂及不同作用位点的新药形成复杂序贯路径。亚盛需要证明某些耐药突变和既有治疗失败患者仍能获得临床收益，并在安全性与管理便利性上形成可接受的治疗窗口。不能将所有慢性髓性白血病患者都作为同等可争取市场，更不能把耐药细分患者与一线人群重复加总。不同地区的基因检测、既往治疗覆盖和医生偏好，会使可治疗人数与流行病学总人数相差很大。

二〇二六年欧洲血液学会议数据提供了耐药人群信号。一项早期研究二十二名既往帕纳替尼及或阿西米尼耐药患者中，九名检出特定不良预后突变；这九名中四名取得临床反应，两名达到主要分子学反应。结果对困难治疗人群有探索意义，但九人的分母很小，不能直接当作全球注册成功率，不能把某个亚组的百分比套给所有耐药患者。是否有一致的反应持续和不良事件管理，需要更大样本及更长随访。

另一项中报引用的前瞻对照研究纳入一百零五名至少两种既往抑制剂治疗后反应不佳患者。六个月主要分子反应约百分之五十四点三，对照约百分之十；十二个月累计主要分子反应约百分之五十七点一，对照约百分之二十一点四。这是比单臂反应更有用的证据，但比较的是特定既往治疗和继续原有方案，不能直接证明优于所有当前最佳序贯药。血小板减少等高级别血液学不良事件仍需结合疗效净收益分析。

海外主要注册路径包括针对多线治疗后慢性髓性白血病的第二项全球研究。截止日公司仍披露入组推进，监管机构允许开展试验与批准药品上市是两个不同节点。注册研究的入组速度、对照方案、主要终点、数据成熟度和地域代表性都会影响结果及审评。模型把海外商业起点安排在未来年份，并对收入乘临床风险因子，没有将试验启动公告当成今年海外销售已兑现。

第一项全球研究面向新诊断费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病，以奥雷巴替尼结合低强度化疗比较研究者选择的激酶抑制剂加化疗。中报的剂量探索部分显示，三个诱导周期后微小残留病阴性完全缓解约百分之六十三。探索阶段的疗效提示可以支持继续开发，不能替代随机部分的长期事件无进展或

生存结果。急性疾病患者的感染、骨髓抑制和合并治疗管理，也使从缓解率到商业价值的转换更复杂。

第三项全球研究聚焦琥珀酸脱氢酶缺陷型胃肠间质瘤。这是与常见激酶突变型胃肠间质瘤不同的少见亚型，存在未满足需求，同时入组和商业患者识别更加困难。模型只计该亚型，不用全部胃肠间质瘤市场计算峰值。若疗效只有短期稳定而缺乏可持续肿瘤控制，价格和审评接受度都可能受限；若证据显示明显优势，少见患者仍可能支持较高每位患者经济价值，但不能自动获得大众适应症规模。

奥雷巴替尼与利生妥、双特异抗体等组合的早期结果，展示了联合治疗方向。儿童复发难治人群某些小队列反应率很高，分母和可评估标准却不同；例如中报九名疗效可评估与十二名某一时点残留病评估并不是同一分母。组合贡献亦不能全部归给一个药，更不能同时在两款自有药估值中计入全方案收入。对患者而言有价值的组合可能需要复杂支持治疗，实际成本和销售承担必须另核验。

中国奥雷巴替尼核心收入模型基准从二〇二六年的四亿七千万元增长到二〇三二年的九亿一千万元；这些是公司确认层级的研究假设，没有公开产品分项时不冒充公司指引。增长来自耐药患者渗透、医院覆盖及用药持续改善，而不是扩大到尚未批准的一线急性疾病。中国急性淋巴细胞白血病和少见胃肠间质瘤另列风险资产，避免把适应症扩展预期提前混入成熟收入。

## 三 武田选择权的经济意义

武田合作是市场最容易高估确定性的事项。二〇二四年六月十四日签订独家选择权协议，并非当天全球商业授权已经全面生效。武田获得在满足条件后进入许可协议的权利，拟许可地域排除中国大陆、香港、澳门、台湾和俄罗斯。二〇二六年中报仍明确公司持续推进所有临床开发，直至武田行权。将武田视为潜在强合作方是合理的，将研发责任已经全部转移给武田则与披露不符。

协议一亿美元选择权款已于二〇二四年七月二日收到，七月四日公告确认。它是历史真实现金，已经进入过去资产负债及经营现金结构，不能再当二〇二六年年底新增首付。二〇二四年瑞士来源知识产权收入六亿七千八百四十二万元，使当年总收入与利润表现改善；二〇二五年没有同等款项，产品增长却被总收入回落遮蔽。分析应拆掉这项一次性背景，才能理解经营趋势和今年现金缺口。

公告提及行权费、潜在里程碑合计最高约十二亿美元及两位数销售版税，全部有行权和后续条件。公开资料不足以确认各个里程碑金额、付款时点、行权最后期限及完整地域经济。模型基准不加入未来行权现金，乐观只列有限年度合作现金预算，不将十二亿美元上限一次折现入净现金。乐观现金也不是声称已经知道真实行权费，而是对后续有利合作的预算，读者可以将其改为零重新核算。

海外奥雷巴替尼风险资产只计净许可经济收入，代表未来合作结构下归属亚盛的净版税或等价经济现金，不计全球药品销售总额。这样避免把武田的商业收入当作亚盛收入再乘自己的高毛利。反过来，当前完整全球研发依旧计入费用，没有在基准中提前免除。若武田不行权而公司选择自销，海外销售费用、团队投入和峰值净收入需要重新建模；不能同时保留低成本版税结构与高额自销收入。

武田的股权投资与选择权款也是不同交易。持有约二千四百三十一万股，在六月披露比例约百分之六点五，体现双方利益联系和一定尽调基础；股权持有不构成未来商业成功保证。股东可以在金融上承担风险，临床和监管仍要独立完成。不能把“有国际大药企股东”转换为临床成功率百分之百，也不能认为该股东必须在流动性紧张时继续注资。

未来最有价值的信息不是重复合作最高总额，而是：是否正式行权、净现金是否实际到账、研发费用具体由谁承担、地区权利是否改变、上市和生产责任如何分配、监管数据是否足够。某些交易新闻会推高价格，却未必改善完整现金预算。研究评分把这些列为期限内潜在催化，同时保持不确定性，避免对尚未公告时间的事件给出半年必达承诺。

## 四 利生妥的已批准适应症与竞争价值

利生妥属于选择性抑制凋亡调控蛋白的药物。中国附条件批准使公司从一款商业药扩展为两款，适用人群是至少接受一线系统治疗、包括既往相关激酶抑制治疗的成人慢性淋巴细胞白血病及小淋巴细胞淋巴瘤。附条件批准意味着仍有后续证据和监管义务，不应写成所有治疗线均获完整批准。临床商业价值在于提供耐药后的治疗选择，并可能通过固定疗程和联合方案拓展更大人群。

国际竞争已经很成熟。已上市的同类药物及与激酶抑制剂联合方案形成标准治疗体系，医生熟悉剂量爬坡、肿瘤溶解综合征监测、血细胞减少管理和药物相互作用。新产品需要证明临床优势、操作便利、治疗持续或对特定耐药机制的价值，而不是只强调“全球第二款同机制产品”。进入较大的海外市场同时意味着更加严密的比较证据、支付方议价和营销费用。

中国注册相关研究七十七名既往相关抑制剂失败患者中，七十二名可评估，独立审查总反应率约百分之六十二点五，中位无进展生存约二十三点九个月。这个结果对后线困难人群有实际临床意义，却不能与一线组合接近百分之百的反应率进行不加调整的横向比较。患者治疗线、风险基因、既往药物、随访和评估标准不同，观察到的百分比不能直接代表产品质量排序。

中报还引用一百七十六人的早期单药及组合研究。单药四十六人、联合利妥昔单抗三十九人、联合阿卡替尼九十一人；其中部分为既往未经治疗患者，部分为复发难治。单药复发难治可评估人群反应率约百分之六十七点四，另一组合约百分之八十四点六；阿卡替尼组合二十二名未经治疗患者全部反

应，六十五名复发难治患者约百分之九十六点九。这些分组不能拼成一个统一百分比，更不能当作随机证明优于成熟同类药。

剂量爬坡较短可能有利于便利性，但应完整评价肿瘤溶解风险、肾功能、肿瘤负荷、药物相互作用和监测场景。某个早期试验未观察到重大毒性，并不能在大规模商业使用中证明风险消失。患者结构更广、中心经验不一，实际安全管理可能与研究中心不同。便利性带来的商业价值必须在患者接受、医生支持和支付方认可中兑现，模型不额外给一个未经证实的“完全无风险”溢价。

中国医保是利生妥近端最重要商业变量之一。中报计划积极推动二〇二六年医保纳入，截止日不能当作谈判已经成功。入医保后患者支付负担下降、医院准入可能加快，但谈判降价也可能压缩净收入。两种效果应按患者数与净价分别计算：患者数大增却单价更低，短期收入不一定按处方增速增长；若低价进入使产品更早用于更多线次，还要防止与其他自有适应症收入重复。

商业渠道已经开始建设。中报奥雷巴替尼有关医院及药房覆盖约八百七十九家，利生妥约四百一十五家，其中利生妥医院覆盖约六十家。整体商业团队近三百人、活动覆盖约一千五百家医院，组织覆盖与实际开出处方机构不是同一指标。上半年销售费用大幅增长说明新产品上市需要前期投入，不能将覆盖数字直接乘每家固定收入。需要观察有处方患者、复购、治疗持续和每位销售人员净贡献。

利生妥中国已批准后线核心收入基准从二〇二六年两亿元增长至二〇三二年十六亿五千万元，悲观约四亿九千万元，乐观约三十亿五千万元。核心仅包括现有批准人群和合理渗透，尚未批准的一线与其它疾病增量另列风险收入。由于财报未提供完整分药收入，本年度拆分是分析预算，合计需与总产品销售趋势一致。它不表示公司已经发布每款药的全年指引。

## 五 利生妥全球注册项目

全球联合研究针对既往相关抑制剂治疗超过一定时间却反应不理想患者，是在现有治疗基础上增加利生妥的路径。临床需证明额外药物带来足够深度、持续性和风险收益改善，而不只是短期血液指标更好。部分患者继续原治疗也可能维持较长稳定，因此对照结果对商业价值特别重要。全球审评还会关注患者筛选和不同既有抑制剂的差异，不能把整个慢性淋巴细胞白血病市场都当作立即适用。

一线联合研究比较利生妥加阿卡替尼与免疫化疗，意在验证固定期限方案。成熟治疗体系正在演变，研究对照在最终读出时是否仍反映临床实践，会影响医生和支付方接受度。即使主要终点满足，商业上仍需与同期成熟的无化疗或固定疗程竞争。模型对全球慢性淋巴细胞白血病各线合并估算，不将一线、后线、添加治疗分别当成互不竞争的完整市场。

老年或不适合强化化疗急性髓性白血病研究采用利生妥加阿扎胞苷。该疾病对总生存、感染和骨髓恢复有严格要求，短期完全缓解可能与长期生存出现差异。患者虚弱、合并症多，持续给药和剂量调整会影响真实收入。既有同机制联合治疗有成熟证据，新方案需要证明可接受的整体利益。模型给这一适应症低于慢性疾病主路径的基准风险因子，而非因已开始第三期就一律给同样成功率。

高危骨髓增生异常综合征全球研究需要更谨慎。血液学反应、输血减少、转化成急性白血病和生存之间存在复杂关系，早期反应不能确保监管和支付方认定足够收益。中报所述十名真实世界患者反应率约百分之七十，其中初治与复发患者各五名，分组只有几名，不能证明在大规模随机人群中稳定存在相同效果。模型因此给较低风险因子，商业起点也晚于慢性淋巴细胞白血病路径。

另一项三十人真实世界髓系研究包含二十五名急性髓性白血病患者，完全缓解及不完全恢复完全缓解约百分之七十二，另有少数骨髓增生异常患者。研究是回顾性，药物组合和患者状态可能不同，高级别血小板减少、贫血和中性粒减少仍存在。不能把回顾性结果直接当作第三期总体疗效，更不能用它证明可以替代所有既有方案。分析保存具体分母，避免高反应宣传掩盖选择偏倚。

维奈克拉耐药患者中的潜力值得观察，但凋亡网络的耐药可能涉及靶点突变、替代生存通路和微环境等多种原因。另一个同机制小分子未必能对所有耐药患者有效。公司计划专门验证既往失败人群，是合理研究方向；在结果尚不充分时，不能把所有同类药耐药患者按高成功率加入峰值。模型在总体风险收入中保留选择性空间，没有单列一个不受竞争的大额耐药市场。

全球利生妥基准峰值分别假定慢性淋巴细胞白血病净销售八十亿元、急性髓性白血病六十亿元、高危骨髓增生异常三十亿元人民币，再乘不同临床及商业风险因子。这些是未风险调整的成熟期净销售假设，不是当前订单，也不是所有患者账单。它们本身已经包含海外市场成功的显著要求；基准仍因长时延、完整开发费用及融资稀释而缺乏现价安全边际。乐观峰值更高，必须与多个适应症及支付方成功同时成立。

## 六 其它管线与技术持续性

另一款多靶点激酶抑制剂针对部分肺癌患者，作用涉及相关激酶与黏附信号。中国两项第三期研究分别面对既往第二代抑制剂耐药或不耐受，以及未经治疗的特定融合阳性晚期肺癌。初步脑脊液药代与患者信号支持继续开发，但血脑屏障暴露不等于一定达到颅内持久控制。成熟竞品在颅内疗效、长期生存及耐药管理上有丰富数据，公司需要在相应治疗线证明差异。

中国同类激酶肺癌治疗竞争充分，许多产品已有良好医生认知与医保支持。新药即使获批，初期放量也可能被价格、处方路径、合并突变与安全管理约束。模型把各治疗线合并成一个中国风险资产，海

外另设较晚、较低概率资产，防止中国研究成功直接等于全球商业成功。卵巢癌、特定肿瘤模型的组合潜力没有被当作已经确定的多个大适应症。

凋亡相关另一早期产品试图恢复肿瘤抑制通路。临床需要筛选相应基因状态，某些肿瘤存在生物学依据，并非所有实体瘤都适合。中报儿童早期组合十七名可评估患者中四名反应，约百分之二十三点五，疾病控制较高；这些结果帮助定位开发方向，不能证明广泛患者受益。单个完全缓解病例尤其不能当作注册证据。模型将各相关早期癌种合为低概率收入组，不堆叠很多独立高峰值。

双重凋亡蛋白抑制剂在实体瘤组合中具有科学吸引力，另一靶点也与血小板生存相关，因此治疗窗口是投资核心。间歇给药、药物相互作用及组合剂量需要在真实患者中优化。与成熟肺癌药物组合的早期文章提供机制和临床信号，但还需看额外疗效是否超过毒性及成本。模型没有因为“新机制”三个字就赋予成熟盈利公司估值，也没有把整个肺癌市场重复加入多个资产。

表观遗传相关早期资产面向肿瘤和贫血，健康受试者单次剂量研究完成与患者长期疗效仍相距很远。贫血模型中改善血红蛋白可能有吸引力，但需要证明长期安全、剂量依赖、输血或患者功能收益。肿瘤组合也需避免把实验室协同直接等同临床价值。模型将早期组合按低风险因子、远期上市和有限现金估值，未把每一种探索疾病都列成独立百亿机会。

蛋白降解平台的首个公开临床候选在二〇二六年获得中美临床试验许可，针对野生型及部分耐药突变靶蛋白。降解与抑制的区别在机制上有意义，人体药代、选择性、组织分布、蛋白恢复和安全性仍需临床证明。实验模型对若干竞品显示更强活性，不构成真实患者疗效优越结论。模型给予早期降解产品约百分之八的基准风险因子，商业起点较晚；这些是研究假设，不能解释为统计预测。

公司披露大量全球授权专利，说明研发积累和保护布局，但专利数量不能直接变成护城河评分。需要看核心化合物专利范围、到期、延长期、自由实施、制剂或用途专利质量以及竞争对手是否能绕开。研究没有取得各资产所有地域有效期的完整法律意见，因此有限现金截止到二〇四一年并随商业年龄衰减，不加永久终值。潜在专利延长可在证据明确后作为上修，不能现在默认。

十年研发持续性取决于候选优化能力、临床患者识别和资源排序，而不是管线始终增加数量。若公司能够及时停止失败方案、把成功资产交给合适合作方、保留关键地区经济，再用正现金支持新项目，平台可持续。若所有早期项目均同时全球推进，现金需求会不断上移，成功药物的经营利润也可能被更多研发吞噬。长期评分因此没有仅因科学平台丰富就高于更成熟现金流公司。

## 七 财务质量与现金跑道

上半年毛利二亿九千零四十九万元，毛利率约百分之九十六点一。同期销售费用二亿二千六百三十六万元，行政一亿一千八百九十三万元，研发六亿九千七百四十六万元，仅这三项合计约十亿四千万元。毛利高并未转化成经营盈利；销售费用已相当于产品收入约百分之八十点二，研发约为总收入的二点三一倍。新产品推广和国际注册费用均真实存在，不能因为利润表亏损“主要由研发造成”就把研发从估值中删掉。

法定归属股东亏损八亿一千六百六十九万元，较去年同期五亿九千零七十七万元扩大。其它收入四千四百八十三万元中，银行利息三千五百九十九万元，政府补助四百五十八万元，其它四百二十五万元；其它费用包含汇兑损失、无形资产减值及捐赠等。持续经营分析可调整一次性损益，但不能由此消除六亿多研发和两亿多销售。模型正常利润代理剔除既有商业权利摊销和非核心公允价值项目，同时保持完整核心支出。

二〇二三年总收入二亿二千一百九十八万元，研发七亿零六百九十七万元，总亏损九亿二千五百七十一万元。二〇二四年收入九亿八千零六十五万元，含武田历史知识产权款约六亿七千八百万元；研发九亿四千七百二十五万元，归母亏损四亿零五百四十三万元。二〇二五年产品收入增至四亿九千九百二十七万元，但总收入五亿七千四百一十二万元，研发十一亿三千七百四十五万元，归母亏损十二亿四千二百七十七万元。历史变化显示现金与一次性授权对利润比较有很大影响。

经营现金二〇二四年流出约一亿一千一百三十六万元，二〇二五年流出十一亿七千四百一十三万元，二〇二六年上半年流出五亿八千一百二十三万元。前一年较好现金表现与合作收款相关，不能作为稳定现金创造基线。今年现金消耗约每月九千七百万元，静态六月经济现金可覆盖约十九个月当期经营消耗，但这个简单比例未扣偿债、资本开支和新增试验，不能当成正式安全跑道。

六月现金及银行余额十八亿九千五百五十八万元，包含现金等价物十五亿六千七百一十五万元、超过三个月定期存款三亿二千三百三十二万元、受限余额五百一十一万元。模型扣受限现金后起点十八亿九千零四十七万元。定期存款到期九亿四千五百二十九万元使现金等价物上升，不使公司总财富增加；把到期存款当新增自由现金会高估经营改善。现金汇兑损失也与利润表汇兑口径不同，需要分别处理。

六月银行贷款约二十亿七千零八十四万元，含租赁后的计息借款合计二十亿九千四百五十七万元。短期无抵押借款十四亿三千八百万元，主要到期二〇二六至二〇二七；长期贷款存在较长到期，但不能以最长二〇三八年推断所有短借已展期。六月银行负债略高于经济现金，净现金概念已不足以保护完整临床预算。资金来源既依赖股权融资，也依赖银行滚动续贷。

上半年新银行借款八亿五千九百五十万元，偿还七亿四千七百三十二万元，是大量滚动借款与净增借款并存。总新借款不能全部当作永久融资资本。模型银行本金按有限逐年净偿还减少，意味着多数到期短借继续滚动续作；这是条件假设，不是已签长期展期证据。若短期贷款全部要求立即偿还，流动性压力会比当前基准大得多，需要额外融资或研发收缩。

固定资产及使用权等可以支持部分抵押借款，但不是同额可自由变现现金。工厂、楼宇和研发设施对持续经营有用，出售可能削弱业务；强制处置回收价也可能低于账面。模型保留经营相关资产在成本与现金流中，没有把固定资产账面再加为现金。小额金融与合营权益采用六月账面锚折损，不能声称是十月九日可出售市值。租赁费用留在完整经营成本，折旧加回排除使用权，避免租债双扣。

收购相关或有款合计一千六百九十九万元，分别安排未来有限支付后清零，不在付清后继续扣净债。应收账款一亿五千六百四十万元，库存六千四百三十万元，对当前收入规模有意义。新增收入越快，账期和库存越可能占用营运资本，因此模型并未将高毛利销售全部当期变成现金。商业化权利合同负债也不能一律当普通借款，它有履约摊销而非全额银行偿付性质。

股权激励上半年费用三千一百二十五万元，还有股权结算奖金约五千九百四十五万元的权益变动披露。非现金费用可以改善经营现金，但员工新股仍对股东形成经济成本。修订模型在经营费用中保留股份支付，现金全额加回，不再安排同一奖励的百分之百现金替代；员工股份另作经济稀释。上半年信托购股现金七百八十二点三万元已在六月现金锚，不重复扣除，现有计划通过新股配发满足奖励。未来没有独立承诺的同额现金购股预算，现金替代因子设零；若以后真实使用现金购股，则必须连同其抵消新增股份的作用一起重算，不能现金与相同增股双扣。

## 八 美国融资身份与股份稀释

美国存托证券每份对应四股普通股，港股及美国存托证券共享同一发行人权益。香港每股目标不能直接与美国每份存托证券美元目标比较，应先按四股及汇率转换，且市场交易时区不同。基准使用香港十月九日收盘，不用随后美国交易价格代替。同一份普通股已被存托凭证代表时，不能把两地股数相加成两倍，也不能只用港股可流通数量分摊全球公司价值。

九月底法定已发行普通股三亿七千四百九十六万二千零八十六股，月内新增一百三十四万五千八百四十六股，来自限制股份奖励安排。上半年加权平均股数三亿七千三百二十四万八千二百一十七股适用于当期每股亏损，不能取代基准日前最新法定股数。模型用九月底全部股数为锚，再预测奖励和融资新股。发行价下降时，同样资金需要更多股份，现有股东承担更大稀释。

七月公告提出最高两亿美元按市价发售计划，销售代理及美国自动储架登记提供融资通道。但计划具有交易禁售、重大未公开信息、香港豁免、上市许可和监管申报等条件，没有直接证实全部金额已经

收到。中报半年没有股权融资，九月底股份变化来自奖励，不提供大额融资已到账证据。模型二〇二六年未加入计划募集现金，下一年以后按情景设置，不能把容量写成存款。

目前两亿美元容量在研究汇率假设下约十四亿元人民币。基准二〇二七至二〇三二年累计发行总额约一百二十四亿元人民币，显著超过当前容量，需要多次后续授权、登记或其它交易与市场承接。这个数字体现完整全球研发成本的负担，不能称为已承诺资金。乐观累计也约八十九亿元，只是在更高发行价格和较早商业化下需要较少稀释。所有情景均必须关注资金可得性，融资需求本身不是融资能力。

发行净额按总额百分之九十七计算，包含研究费用折损；实际费率和承销条件未完全核验。新增股份按人民币总额乘港币汇率、再除港币每股发行价计算。基准未来发行价从三十港元逐步提高至五十五港元，乐观更高，悲观较低。发行价格是重要假设，绝不保证股价能够在融资时维持该水平；如果市场认为稀释或临床风险更高，发行折价可能使资金缺口与股数同时恶化。

未来融资只能改变公司的现金账户和全部股份，不能单独作为旧股东的一项投资收益。本模型逐年滚动现金、银行本金、或有付款、完整研发、股份奖励和发行净额，随后仅将真正可分配给股东的现金按分配日全部股数计算每股金额。二〇三三年起，清偿银行和或有款后，超过十五亿元经营现金储备的部分假设分配百分之七十，剩余现金继续留存；二〇四一年将未分配现金及折损后的金融、合营权益扣除未清银行和或有款，仅回收一次。目标日现金展示给读者核验，不在未来分配现值外再相加。五年内所有情景股息均设为零；二〇三三年后分配政策是研究假设，非公司承诺，普通股持有人个人预扣税不计入本币税前总回报。

最低现金储备假定一亿元人民币，悲观路径在二〇二七年出现负现金，直接归为融资失败零权益压力。基准在完整约一百二十四亿元融资假设下最低现金约四亿三千六百七十二万元，乐观最低约二亿九千三百六十一万元，二者仍依赖资本按时募集。取消后续融资或只使用当前两亿美元计划，基准路径均失败。因年度模型未逐月排现金，年内峰值缺口可能更大，应在正式融资日期和试验付款信息取得后细化。

## 九 估值方法 情景与敏感性

本研究用两条既有药品确认收入和十七项按适应症、地区拆分的风险资产，生成二〇二六至二〇四一年有限经营现金。每项资产有商业起点、未风险调整峰值、收入曲线、风险因子和净毛利假设；概率只作用收入，不机械缩减既已计划的研发支出。销售费用为核心预算加风险新药收入比例，避免远期收入增加而商业团队成本不变。每股价值只由有限年内股东分配及末年净资产回收决定，没有无限增长终值，也不以融资所得现值直接提高旧股东价值。末年回收不计厂房等营运资产额外出售值、未实

现药物专利出售价值及末年以后的经营，属于保守结束假设。企业所得税已在经营现金中扣除；不将同一现金分配再扣企业税。

折现率悲观百分之十七、基准百分之十三点五、乐观百分之十一，反映资本成本、执行与融资约束。临床风险已经通过收入因子体现，折现率并非把同一种风险精确统计再扣一次，而是不同资本环境下研究取值。实际概率、资本成本及资产相关性难以完全识别，应看敏感性而非小数点精度。主模型使用人民币财务、港币每股目标，研究换算一元人民币约一点一港元，一美元约七元人民币，都是敏感性假设。

年底只有约一个季度，不把机构一年目标线性缩到剩余月份。模型基准年底约十六点二七港元，乐观四十六点零八港元，悲观融资失败压力零。短期市场识别因子在基准和乐观不同：长期估值变化不假设当季全部兑现，明显恶化压力可更快反映。识别参数是价格路径假设，不改变经营模型；它只在目标内在价到市价时应用一次，避免总表再重复加或减。

| 年底情景 | 价格 HKD | 相对 28.22 回报 | 成立条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悲观 | 0 | −100% | 极端融资及权益耗尽压力，非统计价格下界 |
| 基准 | 16.2728 | -42.3359% | 完整费用、延迟海外、持续大量融资和显著稀释 |
| 乐观 | 46.0825 | +63.2975% | 多项临床与有利资本路径被部分提前识别 |
| 25/50/25 期望 | 19.6570 | -30.3436% | 研究判断权重，非获利概率 |

默认年底期望为十九点六六港元，约负百分之三十点三四。期望值是三种条件价格按四分之一、二分之一、四分之一权重计算，不是统计均值预测。乐观上行很宽仍无法在默认权重下覆盖悲观和基准损失，反映当前回报分布依赖少数成功路径。若权重更向乐观倾斜，结果改善，但权重选择本身需要新增证据，而非为了得到正收益调整。完整总表保存两种权重敏感性，读者可以核算。

三年至五年基准目标约十一点八零及十五点二零港元，年化回报约负百分之二十五点二一和负百分之十一点六四。晚期价格较一年改善，来源是临床资产逐渐商业化、正现金开始形成和不确定时间缩短；它没有抵消此前融资产生的持股比例下降。乐观目标约一百一十二点二五及一百三十八点二八港元，代表多个全球适应症成功和高净销售，不能当作“至少会回到历史高点”的证据。

基准二〇三一年风险调整收入约三十点九五亿元，二〇三二年四十三点六七亿元，二〇三三年六十点五三亿元；经营现金仍在较早年份为负，二〇三三年自由现金开始接近转正。模型对应的海外临床进展有长等待期。乐观二〇三二年收入约一百四十亿元，二〇三四年约二百七十八亿元，已经是多个商业产品共同成功的大公司路径；必须检查商业费用、生产能力和竞争现实，不能仅看到峰值便接受。

最重要敏感因素是全球利生妥慢性疾病与髓系适应症的成功和净价格，其次是完整研发预算、商业延迟、发行价及续贷。某些敏感变动会使最低现金触发失败，目标会非线性降为零；这是资金约束导致，不能用平均每股变动掩盖。模型提供取消未来资本、只用现 ATM、发行价格下降、临床风险降低、上市延后和研发增加等独立压力。改变输入后须重新跑全情景，不能只改总表一格目标价。

一年基准敏感性显示，折现率减少或增加两个百分点，目标分别约 11.1089 及 7.5796 港元；未来发行价格整体低百分之三十，目标约 7.6539 港元。全球利生妥峰值低百分之三十时约 6.4210 港元，临床风险因子各低十五个百分点时约 5.9220 港元。完整研发现金预算增加百分之二十、仅有当前按市价计划、没有后续资本或短债不续作，均使最低现金失败；全球利生妥商业化延后两年仍能在此融资预算下维持最低储备，但一年目标降至约 6.0376。取消重复奖励现金支出改变了这一压力边界，不能继续沿用旧版延迟即归零结论。这些结果不能解释为事件概率；持续融资或较晚兑现会影响旧股东每次实际可得的现金。

年底权重四十、四十、二十的悲观偏重组合，期望约 15.7256 港元、相对现价-44.2749%；二十、四十、四十的乐观偏重组合，约 24.9421 港元、-11.6154%。即使提高乐观权重，当前三个情景仍没有自动产生高于现价的年底期望。权重来自研究判断，新增注册或资本证据应先改变模型假设，再决定是否修订权重。

## 十 半年日线 周线与量能

十月九日港股收盘二十八点二二，开二十八，日高二十八点六二、低二十七点一二，较前收二十八点零二上涨约百分之零点七一。当日反弹并未改变所有主要日均线下方的结构。二十日均线二十九点九九一，六十日三十三点一六二，一百二十日三十五点七九，二百五十日四十六点零三九；现价分别低约百分之五点九、十四点九、二十一点二和三十八点七。

均线斜率也不支持趋势反转。过去五日比较，二十日均线下行约百分之四点一，六十日下行二点二，一百二十日下行二点六，二百五十日下行二点零。现价一次上涨可以是超跌反弹，只有在价格站上短均线、短均线走平转升、回踩不破且量能改善后，才有较可靠的趋势变化。四条均线提供不同周期位置，不按相近指标重复给趋势加分。

近二十个交易日股价回报约负百分之十三点五，六十日约负百分之二十八点三，一百二十日约负百分之四十六点五，二百五十日约负百分之六十四。三年样本中的最近五十二周日线高约七十九点三，低约二十七点一二，现价离高点约负百分之六十四点四，仅高于近期低点约百分之四点一。大回撤说明市场预期已经显著降低，不能证明估值已低于基本面，也不保证近期低点就是底部。

日线观察支撑二十七点一二，现价距离约百分之三点九；最近二十日区间高三十二点四八，距离现价约百分之十五点一；六十日高三十九点七八，距离约百分之四十一。这些是区间极值，未按多次触碰或成交密度验证，不能称为坚固筹码支撑。若收盘跌破二十七点一二并在放量中继续创新低，短期低位修复判断失效；如果迅速收回并有相对强弱改善，才重新观察。

当日成交约二百一十六万五千六百股，成交额约六千零一十四万港元。五日均量约一百七十三万八千股，二十日约二百三十五万一千股，六十日约二百六十五万四千股；相对前二十日均量量比约零点九一。反弹当日未显著放量，短期均量低于中期均量，属于活跃度减弱而非确认突破。金额和股数是不同指标，不能把股数按每手再重复乘，也不能用港元成交额和人民币同行直接混比。

最近二十日上涨日共七日、下跌日十三日，上涨日累计量约一千八百九十七万股，下跌日约二千八百零五万股，比例约零点六七六。它显示这个窗口下跌日的交易活动更强，不证明特定投资者在卖出，也不能据此声称“主力出货”。分析仅用方向与成交关联，未取得逐笔委托和最终受益人信息，不画声称精确的筹码成本分布。技术得分较低来自价格、均线、相对表现与量的共同证据。

当日成交占九月底全部法定股数约百分之零点五八，可以作总股本口径粗略交易活跃度；实际自由流通股换手率没有独立可靠来源，因此不标为精确流通换手。奖励信托、创始人及机构持股影响自由流通，存托凭证转换亦可能改变交易组织。若需要更精细流动性建模，应取得官方可流通定义和两地转换数据。成交额仅数千万港元，较大建仓仍可能影响价格。

相对恒生指数，近二十日落后约十点五一个百分点，六十日落后约二十五点零八；相对粗粒度港股通创新药指数，分别落后约十四点三七和二十五点零四。公司弱势不是同期市场整体下跌就能解释，融资和预期调整可能更重要。行业指数不是专属疾病可比组，包含不同经营阶段公司，所以相对值作情绪与市场位置参考，不当作精确基本面因果识别。

日线相对强弱指标约四十点七五，未到可以机械定义为“跌无可跌”的程度；即使进入极低值，下降趋势仍可能延续。动量差值约负一点一八九、信号线负一点一三〇、双倍柱约负零点一一八，提示短期负动量仍未完全消失。平均真实波幅约一点七八七港元，占现价约百分之六点三三，说明单日正常波动足以跨越近期支撑距离，固定很窄的观察位可能频繁失效。

周线样本一百五十七根，二十周均线三十三点六四七、六十周四十九点七七八、一百二十周四十七点六零四，没有二百五十周真实数据。现价分别低约百分之十六点一、四十三点三和四十点七。二十周及六十周均线五周斜率均显著下行，一百二十周仍微升但价格远在其下，反映前期高价留下长期平均，不构成当前趋势支撑。不能补造缺失长均线。

周线近二十周上涨周五周、下跌周十五周，上涨与下跌累计量比约零点三四六，平均真实波幅约四点三一八港元、现价占比约百分之十五点三。长期波动很大，季度临床、融资或合作消息能改变数周行情。周线五十二周的高点与日线五十二周窗口不同，数值差异来自采样边界，不应强行认为一个来源错误；复核使用统一复权和窗口定义，既有样本也有少量逻辑修复记录。

半年技术条件可以分成三段观察：先守住近期低点并收复二十日均线，再观察三十二点四八区间高与六十日线附近，最后看三十五点七九至三十九点七八区域能否逐步消化套牢和预期。每段需要伴随成交超过正常均量、回踩缩量且相对市场不再显著走弱。单日越过一个水平不等于整个下降趋势结束，公告跳空也可能快速回补。模型没有用机械图形预测半年必达价格。

## 十一 行业 经济与政策传导

公司收入以中国血液肿瘤治疗为主，疾病需求对普通消费周期相对不敏感，但患者支付与医院预算仍受经济环境影响。医保谈判增强可负担性，医院准入受管理规则和支付方式制约，治疗期间检查、住院与支持治疗费用亦影响选择。经济走弱时疾病不会消失，真实支付能力却可能下降；有医保支持产品的患者覆盖可能改善，净价格及回款仍受压。因此防御性不能仅由“医药”行业标签赋予。

国内利率下降有助于浮息贷款成本和银行续贷环境，但无法自动解决临床项目现金缺口。每个百分点利率变化作用于约二十亿元贷款，量级远小于每年十多亿元研发和销售投入。更关键的是银行愿否维持信用、抵押价值和现金储备。海外利率下降能改善生物科技融资需求和远期估值，但公司必须在实际发行时得到承接；资本市场复苏与某家发行人的融资条件不完全同步。

人民币与美元变化影响海外试验、团队和供应商费用，香港股价又以港币表示。模型用固定换算便于比较，未假定公司完全汇率对冲。人民币贬值可增加美元合作款人民币价值，也可提高海外临床费用，净影响取决于时间与币种现金结构；在尚未收到新合作款时，费用压力可能先发生。港币兑人民币投资回报另列敏感性，股价本币回报与国内投资者换汇后收益不能混为一项。

美国和欧洲监管考察临床质量、安全、样本代表性、生产质量与疗效终点。中国审批和海外试验许可提供基础，却不能替代海外上市申请的完整资料。生产基地获得某些质量认证也不意味着所有产品通过美国监管，产品特定工艺、验证及检查可能仍需投入。公司现有产能可支持未来小分子商业化，但估值仍保留资本开支和转移准备，避免用厂房名义产能当作已售订单。

创新药产业周期受到资本供给和国际合作影响。大药企对具有差异证据的资产愿意付费，对同机制竞争激烈且全球开发昂贵的资产会更谨慎。海外授权可能减少资本压力并扩大销售，但需要让渡部分经济；坚持全部自销可能保留上限，却增加现金和执行风险。亚盛拥有成熟合作基础，但仍需要逐条合同确认。行业整体交易热潮不能直接变成它的确定里程碑现金。

## 十二 四期限投资逻辑与反证

半年核心问题是价格下降结构能否修复，以及利生妥医保和融资信息能否改善现金预期。现价低于四条主要均线、当日量比不足一、相对指数持续落后，图形没有提供抢先重仓依据。半年进取交易需要明显新证据，可能是可信赖资金到账、具有实质临床意义数据或趋势确认；若仅为会议预告和管理层表态，持续性较弱。对当前基准负回报，不应以“半年反弹机会很大”替代完整概率和成本讨论。

一年会出现更清晰商业增长与资本需求比较。需要核验二〇二六全年实际产品收入、二〇二七推广效率、医保净价、研发预算、融资总额及实际新增股数。若每增加一元产品收入同时增加更大研发销售现金，规模增长并不改善股东回报。基准一年目标较低，反映仍处烧钱阶段且融资未被盈利覆盖；有利临床或授权可以上修，不能默认到某日期现金问题自然消失。

三年进入部分海外或新适应症可能实现商业化的窗口，但模型商业起点仍是假设。全球试验成功后，生产审评、支付谈判和商业团队也要时间，不能把数据公布日当收入首年全年峰值。三年投资收益来源应是成功概率提升、净销售形成及融资压力减轻；失败路径包括研究推迟、竞争标准提高和同样资金以更低价格发行。股东持有期限延长不能自动抵消永久稀释。

五年更接近全球商业产品组合成形，合理关注的是自由现金和每股经济。若一款全球慢性疾病产品成功但其它试验继续高投入，现金转正可能晚于收入增长；若两款主要资产形成成熟利润再开展纪律化研发，长期价值可明显提高。基准五年仍低于现价，说明以完整开发、较慢上市和大量融资的路径计算，当前价格已经要求较有利结果。乐观幅度大体现机会，但长期得分也受临床与资本相关风险限制。

十年经营展望需要检验疾病治疗范式是否改变。固定疗程组合、免疫治疗、移植与新靶点可能重新划分现有小分子市场；患者寿命延长可增加持续治疗价值，也可能让更安全或更深缓解方案获得优势。公司若只依赖一组凋亡与激酶资产而缺乏下一代临床质量，早期科学积累可能无法抵御竞争。另一方面，成熟产品现金和高质量降解平台若形成循环，组织有能力延续。模型不将十年经营可能性直接写成永久股价上涨。

最直接反证包括：奥雷巴替尼收入停滞且医院覆盖不能转为患者；利生妥医保准入后收入不增反降、治疗持续明显不足；注册试验在对照下未达到预期临床利益或安全风险恶化；武田未行权且全球开发

必须独自长期承担；实际融资折价和股数显著高于预算；短期银行不续贷或现金低于必要运营储备。任一项都需要重算，不以“长期看好”遮蔽。

上修证据也有具体标准：关键试验拥有可复核随机结果、完整终点和安全性，而不是仅有口头反应率；正式许可合同明确现金到账、研发分担及亚盛净权利；产品增长带来销售费用率下降和经营现金改善；融资足以覆盖明确注册路径且稀释可控；技术趋势回到上升并相对同行稳定。多项同时成立才可能从审慎观察升到较高推荐梯队，单条新闻更适合调整局部情景。

## 十三 外资目标价 治理及核验边界

公开新闻中找到花旗二〇二五年八月二十二日买入、目标一百一十四港元，以及摩根大通二〇二五年八月八日增持、目标九十三港元。两者都早于当前研究截止超过九十天，原始研报和明确目标期限未取得，标为历史新闻转述。不能因新闻页旁边显示最新股价就改变研报日期，更不能把旧目标直接放进年底期望表。若未来取得最新原报告，应记录假设和事件背景后与本模型比较。

机构目标可作为研究差异的起点：可能对全球上市速度、净销售、融资金额、研发分担和成功概率有更乐观认识。正确比较是逐项拆出这些假设，看是否有新证据；不是认为国际投行必然比有限现金模型正确，也不是用目标均值充当年底价格。当前未找到最近九十天可核验外资报告不意味着机构没有发布，表示公开检索证据缺失。缺失保留空项，不编造机构名或目标。

主席九月二十三至二十五日市场购买约三万八千六百三十股，总额约一百一十五万七千港元，均价约二十九点九五；九月二十八日收盘后公告。这是个人市场购买，不是公司大额新增融资，也不是注销股份回购。它可表示个人信心，规模约全部股本百分之零点零一，对十多亿元研发预算没有直接补充。不能用少量增持证明当前估值安全或资金缺口已有解决方案。

公司研发、交易与股权奖励包含治理判断。创始人与科学团队具有技术积累，国际董事和双市场上市提高披露要求，但高成本全球推进仍需要董事会资源纪律。关联收购或有款、奖励信托和员工股份需持续核验，避免经济成本被非现金标签掩盖。治理评分较低主要来自资金与执行约束，而非没有证据地推断不当行为；未来透明合同、项目停止标准和资本规划可改善评分。

所有重要数字在模型中记录币种、单位、报告期间、首次公告及原始链接。中报英文用于核对中文抽取中可能反转的表列，原始财务单位千元转换为百万元及十亿元时保持一致。行情按双来源收盘与三年日线交叉核验，统一归一复权，保留修复记录；交易量按股、金额按港币。没有真实逐笔数据和全部自由流通股口径，因此不声称拥有精确筹码、资金身份或无误差换手。

本章的审慎结论是公司科学与全球价值选择权成立，但以当前完整费用和后续融资看，现有股东回报高度依赖有利临床和资本条件。研究提供了可上修的条件与失败路径，目标幅度不是交易指令。更新应优先追踪现金到账、借款续作、全球注册证据与每股稀释，再判断价格趋势是否支持；不能只因短期反弹修正多年经营模型，也不能只因股价新低忽略有效的经营改善。

## 来源与复核记录

- 中期报告英文：2026-09-17 07:42，首次业绩 2026-08-20 07:00：[HKEX](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0917/2026091700079.pdf)。

- 2025 年报 2026-04-28 07:10，首次业绩 2026-03-26 06:31：[HKEX](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0428/2026042800195.pdf)。

- 2026-09 股份月报 2026-10-07 16:42，基准日前且发布时收盘后：[HKEX](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1007/2026100700946.pdf)。

- 主席市场购买 2026-09-28 22:45：[HKEX](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0928/2026092802053.pdf)。

- ATM 计划 2026-07-19 19:18：[HKEX](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0719/2026071900105.pdf)，正文美国登记日期表述与周日公告存在时序差，保留原文，不推断实际生效及到账。

- 武田期权 2024-06-14 20:15：[HKEX](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0614/2024061401323.pdf)；2024-07-02 收到选择权款，7 月 4 日 07:12 公告：[HKEX](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0704/2024070400023.pdf)。

- 利生妥中国附条件批准 2025-07-10 16:55：[HKEX](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0710/2025071000427.pdf)。

- 所有临床数字来源为截止日前公司中报/公告转述；独立论文链接未完全取得，不标为已独立复核期刊原文。

- 机构目标为原新闻日期历史转述，链接见模型 brokerTargets；90 日内目标空缺保留。

- 行情原始链接、修复与相对指数记录：data/market_snapshot_locked.json；独立模型 QA：data/I021_independent_qa.json；电子表格桥 QA：qa/ascentage_adapter_qa.json。

# 微创医疗 00853 HK

00853.HK 参考价 6.08 HKD

暂不排名。9 月 1 日起股票及 40168 债券停牌；核心中报、租赁核查、债务持续经营未解，8 月 31 旧价非 10 月 9 可交易现价。条件模型不排名不列正式收益/期望。

以下仅是融资、存续或复牌条件成立后的估值参考，不计算正式推荐分、涨跌幅、含息回报或判断加权期望价。

| 条件参考期限 | 目标日 | 悲观参考价 | 基准参考价 | 乐观参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年底 | 2026-12-31 | 0.00 | 6.17 | 22.40 |
| 半年 | 2027-04-09 | 0.00 | 6.53 | 24.04 |
| 一年 | 2027-10-07 | 0.00 | 6.86 | 24.92 |
| 三年 | 2029-10-09 | 0.00 | 11.49 | 32.95 |
| 五年 | 2031-10-09 | 0.00 | 13.57 | 34.67 |

2026 年底成立条件：可靠报表及复牌仍无法扭转高融资和经营亏损；PE 方法 0 不等于清算结果；租赁与财报核实、维持持续经营及债权安排；全集团外部业务和完整费用兑现；可靠复牌、经营增长和成本改善同时兑现且债务获合理解决；不自动认定豁免或未完成处置已到款

半年成立条件：可靠报表及复牌仍无法扭转高融资和经营亏损；PE 方法 0 不等于清算结果；租赁与财报核实、维持持续经营及债权安排；全集团外部业务和完整费用兑现；可靠复牌、经营增长和成本改善同时兑现且债务获合理解决；不自动认定豁免或未完成处置已到款

一年成立条件：可靠报表及复牌仍无法扭转高融资和经营亏损；PE 方法 0 不等于清算结果；租赁与财报核实、维持持续经营及债权安排；全集团外部业务和完整费用兑现；可靠复牌、经营增长和成本改善同时兑现且债务获合理解决；不自动认定豁免或未完成处置已到款

三年成立条件：可靠报表及复牌仍无法扭转高融资和经营亏损；PE 方法 0 不等于清算结果；租赁与财报核实、维持持续经营及债权安排；全集团外部业务和完整费用兑现；可靠复牌、经营增长和成本改善同时兑现且债务获合理解决；不自动认定豁免或未完成处置已到款

五年成立条件：可靠报表及复牌仍无法扭转高融资和经营亏损；PE 方法 0 不等于清算结果；租赁与财报核实、维持持续经营及债权安排；全集团外部业务和完整费用兑现；可靠复牌、经营增长和成本改善同时兑现且债务获合理解决；不自动认定豁免或未完成处置已到款




**日线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量单位尚未完成交叉核验，量图和量能指标暂不展示。来源及异常修复见行情锁版。停牌公司仅绘最后真实交易日以前历史，不把停牌填充值作为交易。**




**周线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量单位尚未完成交叉核验，量图和量能指标暂不展示。来源及异常修复见行情锁版。停牌公司仅绘最后真实交易日以前历史，不把停牌填充值作为交易。**

发行人 I016；证券 S018；00853.HK。价格资料 market-v1.6，研究截止 2026 年 10 月 9 日。8 月 31 日 6.075 港元为停牌前历史参考，不是 10 月 9 日可交易收盘；股票与 40168 债券自 9 月 1 日起停牌。四期

限得分、正式推荐梯队、目标回报、含息及年化回报、年底期望均不适用，暂不参加排名。历史原件可信度高，2026 财务及持续经营条件可信度低。

| 条件观察时点 | 悲观 PE 方法值 | 基准条件值 | 乐观条件值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 年年底 | 0 | 6.169 | 22.400 | 港元；2027 前瞻完整归母经济盈利；财报及债务条件须成立 |
| 2027 年 4 月 9 日 | 0 | 6.533 | 24.036 | 港元；未验证真实交易及全部资金路径 |
| 2027 年 10 月 7 日 | 0 | 6.862 | 24.916 | 港元；原 10 月 9 日为周六 |
| 2029 年 10 月 9 日 | 0 | 11.489 | 32.952 | 港元；再融资、业务抵销和归属持续有效 |
| 2031 年 10 月 9 日 | 0 | 13.565 | 34.669 | 港元；长期经营、更新投入及资金条件均未解除 |

## 投资结论与信息资格

微创医疗是一家具有多类医疗器械、海外销售网络和上市子公司权益的集团，存在经营费用压缩、全球商业化平台扩大以及重组减轻部分融资负担的潜在改善空间。但它的价值判断必须以合并外部经营、母公司可动用现金和债权合同为基础，不能只把各子公司的增长故事相加。2025 年法定总利润转正，持续经营却仍亏损；2026 中期经营预告改善，同时融资费用和未核一次性损失仍使预计持续业务亏损。进取型标准可以给扭亏过程较高容忍度，却不能跳过财报延迟、停牌和持续经营重大不确定性。

本章结论为暂不排名，保留有条件研究。正式中报、租赁核查、债权豁免及现金安排没有完成可靠公开核验，10 月 9 日也无法以 6.075 港元历史参考执行普通新仓。集团经营改善可能创造长期价值，但需要先证明旧股东能在债务偿付、少数股东归属和持续投入之后分享成果。条件模型以七类外部收入扣完整费用，加入有限联营权益盈利，再得到集团归母经济利润，避免把机器人自身收入、母集团外部收入、脑科学持股市值和现金重复计价。它是敏感性工具，不是已经解决资金问题的正式目标模型。

2027 基准外部收入 13.1 亿美元、归母经济盈利 5416 万美元，年底二十八倍前瞻市盈率、法律全股约 19.174 亿股及每美元 7.8 港元的研究换算得到 6.169 港元条件值。这个结果没有因为资产很多便自动给予巨额重组溢价：完整销售、行政和研发仍需成本，集团融资和少数股东分享也需扣除。乐观 22.400 港元要求收入与毛利、费用率、债务成本共同显著改善。历史参考价与这些方法值之间不列正式收益率，年底不加权，因为持续经营条件和可交易基准尚未达到可计算投资回报的门槛。

推荐逻辑的最强正证应是多期外部收入、完整经营利润与可汇至母公司的现金同时改善，并有明确债权合同安排；反证是租赁核查无法支持财报、赎回或约束触发资金需求、对子公司增长的归属降低、集团渠道收入不能转化为外部终端回款。无论股价未来如何波动，反证出现都要重算模型。当前不排名并不等于断言必然破产，而是把能证明的业务进展与尚不能证明的资金条件分开。只有在新财报、真实交易和债权条件明确后，才能讨论是否进入半年或一年进取型榜单。

## 集团边界与经济归属

公司经营包括心血管器械、骨科、心律管理、主动脉及外周血管、结构性心脏病、手术机器人以及其他业务。不同板块面临不同的临床证据、支付、采购和研发周期，不能统一给一个行业高增长率。上市集团往往对部分主体持股不足一半，但基于董事会与投票控制仍合并其报表；合并收入不意味着全部利润属于微创医疗普通股股东。后续估值应逐层扣少数股东并确认现金可分配性。如果某个主体失去控制，则从整项合并变为权益法，收入消失不必然代表业务停止，利润和资产口径也需相应改变。

2025 年 12 月脑科学部分股权转给第三方并出现董事会控制变化，集团剩余权益约 39%，年报认定失去控制，作为终止经营列示，以后按权益法计量。因此 2025 年总收入 11.05381 亿美元包含脑科学 1.10472 亿美元，持续收入为 9.94909 亿美元；2024 比较也重新列示持续与终止部分。2026 上半年预告明确排除脑科学并重列 2025 同期。不能把 2026 持续收入增速与 2025 旧总收入直接相比，也不能在未来全集团销售模型继续合并脑科学后再加一份持股价值。本章只加入有限的权益盈利假设，且不叠持股市值。

机器人板块更能体现内部交易抵销的重要性。2025 分部报告收入 7757.5 万美元，其中分部间 5505.6 万美元，集团外部收入 2251.9 万美元。机器人上市主体在人民币财报中的收入 5.51069 亿元，与美元分部销售大致同属单体经营规模；母集团最终外部收入并不是全部 7757.5 万美元。因此不能把机器人 5.51 亿元与集团海外渠道销售再相加，也不能在集团利润倍数之后叠一份机器人市场价值。内部渠道可以提高效率，合并估值仍必须走到最终外部客户，模型的机器人收入输入明确采用集团外部口径。

## 心血管器械的稳定收入与竞争

心血管分部 2025 外部收入 1.81751 亿美元，报告分部收入 1.82181 亿美元，较重新列示上年增长约一成。公司描述冠脉支架集采后向疾病整体解决方案转型，球囊、配件及有源器械成为增长来源，并披露 FireSweeper 导管、FireSpear 设备及配套导丝等国内许可。产品拓展有助于降低对单一支架价格的依赖，但新设备进入临床仍需医生训练、耗材使用和采购预算。年报所述调整后利润率不等于集团归母净利率，公司还需承担总部、债务和其他亏损业务，所以不能直接用该板块的盈利质量替代整集团。

该领域需求来自冠脉介入的临床需要，老龄化提供长期数量基础，支付和集采则影响单位价格及渠道利润。进口替代可以扩大份额，也可能让供应商同时承担更低净售价和更广医院覆盖。公司在年报中提及 Firehawk 相关临床研究发表，这是临床证据进展，本文以公司原件陈述为来源，不扩大到已独立核证全部终点或全部治疗场景优越。长期竞争优势应由可靠临床效果、器械操作、成本和服务共同支撑。模型 2027 基准该板块 2.3 亿美元外部收入，对成长有要求，若传统产品降价快于新产品替代应下调。

## 骨科的调整 渠道与未完成处置

骨科 2025 外部收入 2.34758 亿美元，分部收入 2.35155 亿美元，较上年减少约 7%。报告描述美国收入承压，中国市场调整和供应链变化，海外不同地区表现分化；公司仍有植入物、翻修及肩关节等产品进展。骨科并非一项天然持续高增长资产，医院手术量、医生习惯、经销关系、植入物证据及集采价格都会影响经营。与机器人结合可能帮助术前规划和植入，但设备与耗材协同需要实际销售和使用验证。模型不把协同愿景单独资本化，也不在降低研发销售费用后仍假设所有新产品免费产生收入。

7 月 15 日公司宣布向天智航出售海外骨科核心主体控制权益的意向，7 月 29 日已签有条件协议，所有出售方拟转 62%，苏州微创拟出售约 44.29%，原持约 82.29%降为 38%，完成后目标不再合并。对价为天智航新股，发行基准 14.36 元人民币并可调整，最终资产评估和总对价尚未确定，还须内外批准。由此不能说公司已收到大量现金偿债，也不能把目标全部资产和未来天智航股票同时保留。本章截至日未核完成，模型不加处置现金或收益，未来若完成应替换收入、债务、股权和权益盈利整套口径。

出售控制权益可能降低合并亏损和后续投入，也可能减少外部收入与旧股东对未来恢复的分享；获得上市股票不等于立刻可变现现金，锁定、市场价格和持股安排均需核。交易最终价值应比较出售价格、保留权益、失去的经营现金、解除的担保或债务以及税费，而不是仅看“聚焦核心”措辞。条件基准仍保留骨科经营，并要求其外部收入逐步稳定；如果完成交易，需建立新权益法桥。现在用不确定处置收益支持 2026 年度债约利润或提前赎回，都会把未落实事项当成已完成的资金来源。

## 心律管理的经营与融资区别

心律管理 2025 外部收入 2.297 亿美元，美元增长约 4%，排除汇率后接近平；其欧洲业务占比较高，产品包括起搏、除颤和相关长期管理。植入设备具有技术、质量和售后要求，注册、可靠性与临床采用可能形成客户黏性，但也有大型国际厂商竞争。蓝牙连接、磁共振兼容及新一代设备可帮助产品更新，医院采购仍受支付、预算和医生选择影响。本章不将日常病患监测自动视为高利润软件订阅，也不把收入美元增长全部归因终端数量，在经营模型里完整保留研发、服务与市场成本。

2025 年 12 月心律业务重组进入心通体系，集团心通权益约 45%且仍保有控制，继续合并；相关普通股和优先股安排改变，年报融资变动显示约 2.64833 亿美元回购义务退出负债，同时心律可转债以 1.7008 亿美元现金全部赎回。这些是资本结构改善与现金支付，不等于整个集团没有债。重组的收益或权益转移也不必然进入经常归母利润。未来心律经营转好一部分要由少数股东分享，模型分别列集团融资费用和少数归属，没有只加业务增长却忽略重组后权益稀释。

## 主动脉及外周血管业务

主动脉及外周血管分部 2025 外部收入 1.87855 亿美元，分部净利润 7770 万美元，为集团重要盈利支撑，产品升级及海外渠道扩大具备实际基础。8 月 26 日集团披露心脉 2026 上半年中国准则未经审计财务，收入 7.93949 亿元，主体归母 3.22362 亿元，分别增长约 11.13%及 2.45%，公司持股 40.32%并合并。公告同时明确该数据只覆盖心脉，不排集团内部交易，也不是全集团财务。不能把 3.22 亿元直接作为微创医疗半年归母利润，亦不能将该主体账上资产全部当母公司可用现金。

该板块的高利润依赖产品创新、医院采用和适应复杂病变的临床价值，仍需应对降价、市场覆盖和海外注册维护。公司披露部分产品欧洲及其他市场许可，并提及 Hector 获美国突破性器械资格，该资格有助于后续流程但不是美国商业批准。本文不以资格数量推算美国确定销量。基准 2027 外部收入 2.4 亿美元、以后逐步增长，是依据已有经营规模作出的研究假设；如果国内竞争压价或海外注册不能形成付费使用，盈利支撑可能下降。该板块不能无限补贴其他亏损方向，还需考虑自己的研发、资本开支与少数股东分配。

## 结构性心脏病及组合协同

结构性心脏病 2025 外部收入 4271.7 万美元，分部报告收入 5131.4 万美元，两者因内部交易不同。公司披露海外 TAVI 等业务扩张较快，但总体收入增长有限且分部亏损扩大，国内价格调整与新品商业化成本仍影响利润。它与心律管理整合形成心衰完整解决方案的愿景有逻辑基础，客户、产品和渠道能否形成更高效率却需要实际费用与收入验证。把两个业务共同包装成大市场平台后不能自动提高毛利、削减全部销售费用；医生学科、患者病程和采购流程不同，协同有范围与执行时间。

瓣膜、左心耳封堵及其他介入器械需要临床和监管证据，新产品从许可到覆盖医院、治疗量、支付和市场份额可能经历长过程。国内需求庞大并不代表全部患者在短期都采用高价值新器械，竞争与支付约束可能抑制单价。2027 模型基准外部收入七千万美元，乐观九千万，要求已有产品扩展；以后收入增长并未为每个早期研发项目额外加价。若新品成本与持续试验支出超过预期，要提高完整研发预算；若质量、临床或许可问题发生，应降低相应收入，不能以母集团产品组合分散作为忽略单一平台风险的理由。

## 机器人与其他业务的集团价值

机器人海外扩张已在独立公司原件中获得订单和商业安装证据，但集团价值最终要看分销环节对外售出、现金和归母贡献。2025 该分部外部收入只有 2251.9 万美元，而分部间销售 5505.6 万美元，说明增长阶段对集团渠道抵销尤其敏感。本章 2027 基准外部机器人收入 1.7 亿美元已远高于 2025 外部基础，乐观 2.8 亿美元，需要终端渠道快速转化，而不是只要求机器人主体发货增加。若渠道库存上涨或客户延付，母集团利润与现金改善可能低于单体机器人宣传增速，投资者应同步核两套报表。

其他业务 2025 外部收入 9560.9 万美元，包含未达到独立分部披露门槛的非血管介入、手术器械和相关新兴方向，部分早期项目曾形成亏损与减值。不能因为“其他”增速高便把所有未来研发平台算成高估值资产；也不能在非核心业务处置时保留其原增长不作口径调整。模型给有限其他外部收入，并在集团完整研发、行政及联营亏损里保留资源成本。长期是否聚焦得更有效，需要看停止或剥离的项目、实际现金减少和剩余产品质量，不靠项目总数量判断集团竞争能力。

## 全球商业化平台与宏观传导

年报描述 GloMatrix 相关业务收入 1.639 亿美元，排除汇率增长 78.8%并达到平台收支平衡，总部出海平台另有 1.09248 亿美元口径。二者覆盖范围不同，已经包含于业务或集团收入，不能在七分部之外再加一项海外平台销售。平台可以共享注册、销售、工程师与渠道资源，让中国开发产品进入海外市场；内部发货和最终外部销售也可能在不同分部。模型采用已抵销外部收入，从源头避免重复，同时保留销售和行政成本，不把平台收支平衡等于集团全部债务利息已经被覆盖。

海外销售有两种不同口径：包括既有欧美业务的全部非中国收入，以及中国研发获批产品通过海外渠道销售。2026 预告所谓海外约 140%增速采用后者，不能对集团全部海外收入乘 2.4。2025 持续外部地域收入中国 4.21470 亿美元、欧洲 3.25950 亿美元、北美 7957.9 万美元、亚洲其他 1.08927 亿美元、南美 4232.5 万美元及其他 1665.8 万美元。欧洲和国内基数远大于某些高速新市场，集团增长要看加权结果。市场进入数量也不等于相同金额订单，逐地区支付与汇款能力影响现金周期。

美元是报表呈列货币，经营功能币包括人民币、欧元和日元。美元折算增长与本币实际增长不同，人民币变动同时影响中国成本、出口售价和境内资金汇出，欧美汇率则影响当地收入、利润与美元债务的匹配。年报披露没有重大对冲安排，但持续监控汇率。本文每美元 7.8 港元仅估值换算假设，并列 7.75 至 7.85 敏感性；它不覆盖经营汇率效应，也不是截止日已核即期汇率。港币兑人民币的投资回报敏感性仍需总表单独处理，不能把报表美元与投资港元的关系简单视作无风险。

## 法定盈利与经营核心桥

2025 持续收入 9.94909 亿美元，销售成本 4.41398 亿美元，毛利 5.53511 亿美元；研发 1.35499 亿美元、分销 2.94601 亿美元、行政 1.60804 亿美元，毛利减这三类约亏 3739.3 万美元。这一核心经营定义与 8 月中期预告脚注的经营净利定义相近，但尚未包括其他收入和支出、融资、减值、税与归属。不能将其与集团法定净利混用。2024 重新列示同一核心约亏 1.61036 亿美元，说明控制成本已带来实质改善，仍需进一步收入及效率才能覆盖融资成本和其他持续损耗。

持续其他净收入 4764.7 万美元含补助、利息、汇兑及处置固定资产，其他经营支出 3150.7 万美元；融资 1.11261 亿美元、应收及担保预期损失 523.5 万美元、可转债公允价值损失 2374.4 万美元、其他金融损失 49.1 万美元、非流动减值 9894.7 万美元。持续子公司处置收益 4964.7 万美元、联营权益处置 388.4 万美元，权益法净亏 2509 万美元。最终持续税前亏 2.32490 亿美元、税 2322.3 万美元、集团持续亏 2.55713 亿美元，归母持续亏 2.33849 亿美元。这套桥是判断经营改善能否转为股东回报的基础。

终止脑科学经营当年集团利润 2.9414 亿美元、归母 2.82368 亿美元，与持续亏损合计集团总利润 3842.7 万美元、归母 4851.9 万美元。脑科学失控确认 2.76893 亿美元收益，现金对价 1.01552 亿美元和剩余权益公允价值 3.14068 亿美元合计 4.15620 亿美元，扣原归母净资产 1.38727 亿美元得收益；处置同时退出脑科学现金 8696.4 万美元，净现金流入仅 1458.8 万美元。收益远大于真正新增合并现金，不能拿 2.77 亿美元去填债务偿还预算，也不能把全年归母转正说成完整经常业务已经盈利。

## 非经常项目与调整口径

集团 2025 经调整亏损 1.00134 亿美元，由法定利润 3842.7 万美元，加股权支付 3524 万美元，扣子公司处置 3.2654 亿美元及联营权益处置 388.4 万美元，加金融公允价值损失 2492.7 万美元、减值 1.0725 亿美元和优先股利息 2444.6 万美元而来。它说明某些重组与非现金项目影响较大，但不是普通股可自由分配利润。股权支付对股东有稀释或替代成本，优先融资支出在资本结构调整前也有经济代价。长期模型保留经常激励，按目标资本结构的全部融资费用计算，不能永远加回它们来制造净利。

减值较高提示过去投资、资产和研发商业化判断存在修正；一次性项目可不重复预测相同金额，但不能认定今后完全不需资产减值或损失。融资公允价值变动与现金支付不同，估值应分辨合同本金、溢

价、有效利息与账面损益。总部和联营损耗同样不能被忽略，分部净利总和需要加未分配费用才能勾稽集团。本章以完整经济费用假设而非剔除所有不利项的调整口径估值，保留核查额外成本敏感性，并明确这些未来费用不是已经确认处罚或资产损失。

## 研发 资本化与长期竞争

持续研发费用 1.35499 亿美元，含终止业务全集团研发 1.46504 亿美元；无形资产变动中当年资本化开发新增 1668 万美元，研发费用与新增相加 1.63184 亿美元只是全研发投入代理，不是精确现金研发，因为费用内含摊销、激励及不同期间计量。资本化开发当年摊销 1574.8 万美元，未投入使用部分仍较大。不能在经济盈利中既保留同一旧摊销又把新增资本化全额加扣而不说明重复，也不能把资本化视作无成本。本章未来完整研发比例作为涵盖产品更新、资本化类投入和激励的统一预算，不另外加一次历史资产摊销。

压缩研发可以帮助近期亏损收窄，却可能推迟产品更新、注册和证据积累。集团的理想路径是减少重复或低价值项目，把资源集中到能够形成临床和现金回报的方向，并保持必要质量合规。若 2027 至 2031 收入增长来自新产品与海外扩展，研发绝对预算需要跟随，不能同时假设高增长和长期研发快速归零。本章基准完整研发约收入 11%，随着收入扩大绝对额增长；乐观 2031 提高至 11.5%，避免把长期技术选择权视作免费。反证是注册进展和临床证据因投入不足持续落后，或资本化资产再次大额减值。

## 现金流和融资分类的核验

2025 集团经营现金净流入 6913.2 万美元，终止脑科学贡献 2831.4 万美元，剩余持续部分约 4081.8 万美元，不能把全部 6913 万美元当成 2026 以后持续业务基准。固定资产现金投入 8681.4 万美元，无形资产及开发 1494.4 万美元，按全集团经营现金减二者约负 3262.6 万美元融资前自由现金流；再扣融资分类租赁本金 4203.4 万美元、利息 465 万美元、借款现金利息 3595.4 万美元和转债现金利息 3242.5 万美元，约负 1.47689 亿美元。各口径要同时说明经营边界和利息分类，防止只挑现金最好的数字。

2025 投资现金净流入 1615.5 万美元包括定存及质押减少、处置、金融产品赎回与购买、联营投入和贷款等，融资净流出 1.29110 亿美元。现金期初 7.12995 亿美元，加经营、投资、融资及汇率 1333.6 万美元，期末 6.82508 亿美元。出售子公司、借款和少数股东增资可以在短期支持资金，但它们不是可无限重复的经营现金来源。集团还付少数股东股息 2196 万美元和激励股采购资金，说明合并经营盈利之外存在现金归属成本。2026 财报未披露，本文不据旧现金流推算研究日已实现余额。

## 合并现金与母公司可用资金

2025 末现金及等价物 6.82508 亿美元，三个月以上定存 1.08135 亿美元、质押存款 338.1 万美元合计另列 1.11516 亿美元。现金中有心脉指定用途募资 1.41581 亿美元，不能作一般用途；除此之外内地现金 3.77520 亿美元受外汇汇出规则限制。指定用途与内地规则分别是不同限制，不应一概称永远无法使用，也不能认为母公司可立即拿走。未分配总部现金 1.31084 亿美元和存款 109.2 万美元仅属分部调节口径，不能等同精确母公司银行余额，但有助于理解集团总现金不代表全部母公司流动性。

简单全集团现金减借款、转债与租赁约负 9.18244 亿美元，是历史净债指示，并非可直接从未来集团市盈率再扣的估值项。现金和债务分布于不同主体，某家盈利子公司拥有现金同时母公司背负转债，不能自动抵销出可执行偿债能力。集团内部担保、质押和资金转移还需合同和法规核验。本文没有把定存或非上市金融资产全部当即时现金，没有从已不含特定项目的池子再次减同一限制。未来应该建立主体分层资金表，经营现金、分红、借款、担保、质押及转债到期都逐层对应，条件值才可能变成正式价值。

## 债务本金 账面值与赎回

2025 银行借款 11.93953 亿美元，流动 4.14387 亿美元，非流动 7.79566 亿美元；转债与可转贷款账面 3.55386 亿美元，租赁 5141.3 万美元，融资负债合计 16.00752 亿美元。合同赎回应看本金和条款，而非直接拿账面值替代现金。2028 转债本金 2.2 亿美元、票息 5.75%，持有人可在 2026 年 12 月 21 日要求本金及应计未付利息赎回；年报流动账面 2.15873 亿美元是计量值。年底专项如果忽略此日期，就会把债务偿付压力错误地推迟到 2028 到期之后。

2029 可转贷款本金 1.585 亿美元，转换价 7.46 港元；2027 年 5 月贷款人可要求全部赎回并收 30%本金溢价，即利息之前约 2.0605 亿美元；2029 还款须 40%溢价，利息之前约 2.219 亿美元。协议还含某些业绩未达时 5000 万美元预付款及 30%溢价安排，可能影响提前现金需求。2028 债转换价 12.779 港元，在旧参考价以下情境不能假定投资者必然选择转股替公司免去现金；转股选择及条件由合同和债权人决定。模型没有把潜在转换股票加进分母同时还保留全部本金与利息的同一情景，未来更换处理须联动。

## 约束 豁免与持续经营

年报披露重大持续经营不确定性：持续业务亏损、最近一年银行和转债现金需求，以及部分非流动银行与可转贷款约束可能使资金依赖续借、融资和目标满足。约 7.50049 亿美元银行及贷款相关业绩约束包含 2026 上半年集团净利不少 4500 万美元、全年不少 9000 万美元，未达可能有被要求立即偿还和交叉违约影响。2025 未违反银行约束不意味着以后没有压力。董事提出成本控制、延期非必要资本开

支、处置资产、引资与银行谈判方案，财报采用持续经营基础；这些计划的成功仍涉及未来条件，不可把计划当已承诺现金。

8 月 12 日中期预告称就预计亏损已经取得适用于该期间可转贷款协议财务约束豁免。这个范围不能扩成所有银行、全部债券、2026 年度或所有未来年份均免约束，也不等于已完成 12 月本金赎回或 2027 溢价处理。正式中报及债权公告应说明豁免对象、期限、其他条件、费用和剩余责任。若资金来源只靠不断延期而经营现金不能覆盖费用，公司价值仍对债权决策敏感。本文的条件经营模型不预测确定违约，却明确尚未证明逐年债务全路径可清偿，因而长期数值不作为无条件推荐。

## 租赁保证金与中报延迟

8 月 20 日公告说明张东路 1661 号物业的原租赁为 2021 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日五年，原约总面积约 126370 平方米、总租金约 1.9466 亿美元，美元金额使用历史换算人民币 6.4612 元而非 2026 即期汇率。三家主体已续约约 13872.64 平方米至 2031 年 7 月 31 日，八家其他主体约 74686.84 平方米仍商议租金、期限、面积和保证金。集团该物业保证金约 2.9599 亿元人民币，退款时间和方式尚未定。不能把五年总租金当年租金，或把人民币保证金误写成美元并当年末确定现金到账。

8 月 31 日二十二时五十九分公告，翌日有同文再刊，明确需进一步议定租约及保证金，复核保证金可回收性、装修成本合理性，以及集团与出租方和关联人士关系，财报及审阅未能完成，股票和债券 9 月 1 日九时停牌。本章保留最早公告时间，不把 9 月再刊误称全部信息第一次发布。核查尚无结论，不能指控已经发现造假；同时不能将其描述为无关紧要的排版延迟。保证金、装修、租金与关联披露可能影响资产和费用、流动性和治理，必须等明确事实再修改估值。

年报非流动租赁和保证金总额 3743.2 万美元，附注所述付回青橙账面 3861.3 万美元范围并不完全一致，可能有流动分类或其他计量差异，已核资料不足以强行勾同。8 月公告人民币 2.9599 亿元又属新时间和具体物业范围，不能混作年末美元同一数。报告保留三条原始记录及限制，不利用差异推定新增现金或损失。核查费用敏感性只代表研究压力预算，不是公告确认赔偿、罚款或全部保证金减值。未来若提供退款、续约、装修审阅与关联人士结论，才有条件精确调整现金和完整租赁成本。

## 应收 存货与营运资金

2025 贸易应收总 3.47657 亿美元，减预期损失 1958.7 万美元后净 3.28070 亿美元，较上年 2.65636 亿美元增加；其中第三方总额 3.33182 亿美元、关联 1447.5 万美元。净账龄超过十二月 1375.4 万美元，较上年 680 万美元增加，其余一月内 1.48861 亿美元、一至三月 1.08158 亿美元、三至十二月 5729.7 万美元。增长与较长账龄都需要结合业务和收款，不能只看关联比例低便断言无信用风险。集团内部

客户抵销后余额较低也不消除海外渠道最终客户回款问题，单体机器人关联销售与集团净应收必须分别理解。

存货 3.49199 亿美元，其他流动应收 4.68967 亿美元含预付、保证金和税务等，流动净资产 5.04521 亿美元不全是可迅速付债的现金。设备、植入物和不同地区备货需要资金，老型号换代或销售放慢可能形成减值。合同负债 6546.1 万美元含未来履约、设备预收和其他项目，收款可以支持经营，但履约后仍有成本，不能全当利润。模型用完整成本和费用率作条件盈利桥，尚无 2026 真实营运资金表；若海外增长占用更多应收和备件，现金改善可能滞后于利润，应在资金模型中增加占用而非假设免费成长。

## 股本 潜在转股与归母成本

9 月底月报 10 月 7 日十六时三十一分发布，已发行普通股 1917386655 股，法律库存零、当月无新股；授权总数五十亿不是已发行分母。旧财报的会计激励信托或福利计划资产与法律库存不是同一概念，172000 股长期福利信托单独列示，不擅自从法律股本扣除。期权或计划余额包括 2010 计划 41212338 份、2020 计划 63525251 份、2023 计划 35463313 份，未来可新发行份额与余额也不同。未行权权益不等于今日全股，目标分母须考虑实际归属、转股和未来融资条件，避免把计划上限全部当成已稀释。

月报 2028 转债潜在新股 134537601 股，2029 贷款 166329391 股，合计约 3.00867 亿股，未转股。本章 2027 及远期分母逐渐增加是研究稀释压力，不声称两笔债必然全转或所有期权全行权，也未加未来发行现金价值。若以转股减少融资费用和债务，应同步增加对应股份；若以现金配售解决赎回，应按毛款、费用、价格和发行数联动，并说明授权。本文条件盈利桥未建立这些完整资金分支，故不能用已减少融资费用的未来经营价证明债务自动解决，仍以维持持续经营和合理债权安排为前提。

## 活动经营模型与完整成本

2027 基准七分部外部收入分别为心血管 2.3 亿美元、骨科 2.3 亿、心律 2.6 亿、主动脉外周 2.4 亿、结构心脏七千万、机器人 1.7 亿、其他 1.1 亿，合计 13.1 亿美元。分部数量是对外收入预测，已排集团间设备发货，脑科学没有销售行。完整成本率 39%、销售 24.5%、行政 11%、经济研发 11%，加有限补助、扣其他经营及核查压力后，再算现金利息、融资、其他权益亏损和脑科学权益贡献。税与少数归属后归母盈利 5416 万美元，不是公司指引、投行一致预测或由中期预告倒推的已实现利润。

基准完整研发 1.441 亿美元与收入同步，覆盖资本化类开发及经常激励预算；销售 3.2095 亿美元、行政 1.441 亿美元不消失，海外渠道扩大并非免费。现金利息九百万美元、融资七千五百万、其他联营净亏一千万、脑科学权益一千三百万均为假设；脑科学贡献来自母公司持有经济权益，不能再加脑科学全部盈利或市值。基准税率 20%、少数 4500 万美元后普通股分享较集团总盈利低，反映部分盈利板

块并非全资。若税亏跨主体不能抵扣、少数分享或融资成本更高，归母可能低于路径，需要逐项修正。

该方法使用全集团经济利润市盈率，含现金利息和融资、完整业务与权益贡献，因此没有再加历史现金、证券持股或子公司估值，也不重复扣历史净债。若改用分部价值和持股市值的资产和估值相加法，必须重新分配净债、少数、总部开支、内部交易与税，不可与现有集团利润法任意拼接。当前数据无法精确证明所有主体资金可上划及逐年清偿，经济盈利模型仅判断经营门槛。未来长期价格虽可按明确假设计算，不代表现金已经有路径覆盖近期赎回、更新租约和全部研发扩产。

## 悲观分支与模型限制

2027 悲观外部收入 10.15 亿美元，成本 47%、销售 29%、行政 15%、研发 14%以及核查压力等使完整经济归母亏损约 2.2675 亿美元。市盈率法没有正盈利，输出零；2029 和 2031 类似未扭亏，所以各期限悲观方法值均零。这不是预期复牌股价零、公司净资产零或最大损失边界，也不是已验证清算估值。资产、技术、权益、债权及重组回收可能有其他价值，需另建具备现金和合同证据的模型。把这个零与两个正价按默认权重混算会掩盖模型适用性，所以本章不发布年底期望或获利概率。

乐观 2027 外部收入 15.8 亿美元、成本 37%、销售 23.5%、行政 10%、研发 11%，融资降至六千万美元、少数六千万美元，归母约 1.57323 亿美元。收益源于收入结构和费用效率的共同改变，不是单靠有一次性资产出售。乐观合理倍数仍依披露可信度、债务和竞争风险，不能仅因公司具多产品便使用无限高倍数。若费用减幅影响长期研发，或渠道价格与质量并未支撑毛利，应该削减盈利。价格计算虽明确，乐观经营及资金条件未验证，不可解释成股价一定反弹至历史高位的保证。

## 年底信息集与现金压力

年底离研究日较近，主要事件是租赁财报核查、交易恢复及 12 月 21 日转债选择，不宜只看来年增长。一项旧全集团现金预算示意：起始 6.82508 亿美元，经营净流入八千万、资本支出六千万、融资分类租赁 4668.4 万美元、借款转债现金利息 6837.9 万美元、少数股息两千二百万、流动银行还款 4.14387 亿美元及转债本金 2.2 亿美元，结果负 6894.2 万美元。它不是 2026 真实现金预测，也没考虑 5 月 2027 溢价或新增租约，旨在说明即使整体经营改善仍需明确资金安排，不能宣称集团现金充足就无期限压力。

单取旧集团现金减流动银行和 2.2 亿本金还剩 4812.1 万美元，但这没有扣经营投入，也假定所有现金可自由使用；未分配总部现金 1.31084 亿美元相对于本金已经少 8891.6 万美元，虽不是精确母银行余额，足以提醒主体分布的重要性。定存和受限资金何时可用、债权是否续期或转换、资产售股是否有

流通限制，都改变实际支付能力。模型没有默认免费新贷款、未完成对价或保证金全退，年底条件值仅在财报与持续经营安排成立时有意义，无法按默认 25/50/25 权重作正式期望。

## 半年经营逻辑与失效路径

到 2027 年 4 月，理论上至少需要可靠 2026 财报、租赁核实、近期债权安排和新的对外经营证据。基准半年条件价 6.533 港元用同一 2027 归母 5416 万美元、约 19.4 亿股及三十倍前瞻市盈率。期限增长并不自动消除停牌和资金问题，只有新财报和交易资格可以建立可执行现价。半年上涨来源若存在，应来自持续盈利被验证和资金不确定性下降，而非只靠 2025 法定总利润为正或旧投行高目标。技术观察需使用复牌后完整日线，短线资金不能替代账目核实。

半年失效条件包括延期继续、租赁资产或费用重大修正、提前赎回现金来源不清、非核心处置未能获得可用资金，或外部渠道销售落后于内部发货。预告经营正利至少 2400 万美元仍低于当期融资约 4300 万美元，若资本结构改善不足，年报归母可能没有扭亏。若公司通过有成本的融资维持经营，新增利息和股份需要同步反映；若依靠极低价格售资产，近期现金改善可能牺牲长期价值。不能因复牌后两天上涨便取消这些失效条件，半年评价仍要依核心证据。

## 一年经营逻辑与失效路径

一年目标原 2027 年 10 月 9 日周六，观察 2027 年 10 月 7 日此前港股交易日，基准条件 6.862 港元采用 32 倍和约 19.7 亿股。该时点应能看到 2027 中期持续业务、外部机器人转化、完整费用和母公司资金，但 2027 年 5 月贷款人要求本金加 30%溢价的可能性更早发生，不能在一年结论里跳过。收入增长与债务安排的顺序决定是否有能力等到利润释放，短期贷款压力会影响长期估值。当前一年仍只列条件价，不公布正式排序或与历史 6.075 港元的收益期望。

一年正证是外部渠道现金、持续利润和归母归属都清楚，同时资金安排不是以无法承受的成本买时间。反证是经营利润增加却被融资、税、少数和联营亏损持续消耗，或者业务处置后收入结构减少而旧盈利预测没有更新。若骨科目标退出合并，需要把剩余权益和天智航股份重新估值，而不能保留整项收入。若脑科学继续停牌或业务受影响，权益贡献也应减值而不是无限沿用本章假设。统一集团模型应随事实变化重算，不能分别为每个子公司保留最乐观版本相加。

## 三年成长与股东分享

2029 基准七分部外部收入合计 16.2 亿美元，完整成本 38%、销售 24%、行政 10.5%、研发 11%，融资六千万，脑科学权益一千七百万，少数六千五百万，归母约 1.14567 亿美元，21 亿股及 27 倍得到 11.489 港元条件值。该路径要求既有产品持续、海外平台真实向外售出、长期研发质量保持，以及债务约束

得到解决。它并非把公司每年靠处置收益变成盈利，也不假设所有子公司利润百分之百归属。三年倍数低于一年，体现成熟后成长降速和集团结构仍需折价。

三年乐观外部收入 22.1 亿美元、归母 2.6884 亿美元，33 倍得到 32.952 港元；需要多个业务共同扩张并有合理融资，资金与注册服务投入增加。失败路径是在扩张过程中累积存货和长账期、集团抵销增加、售后合规费用上升，或者债转股削弱旧股东分享。即使母公司资产证券化提高账面权益，不能当作可持续每股盈利。公司承担较复杂融资和少数结构，三年分析应把每股归母与经营质量作为核心，行业地址市场巨大不是免除这些检查的理由。

## 五年与十年经营持续性

2031 基准外部收入 19.8 亿美元，归母约 1.7013 亿美元，22.5 亿股、23 倍得到 13.565 港元条件值；乐观外部 29.3 亿美元，归母约 3.57164 亿美元、28 倍得到 34.669 港元。这些价格要求十亿美元规模集团在费用、研发、服务和资本结构上达到比 2025 更稳定状态，并不是只靠一个新机器人平台拉动全部股东价值。长期提高收入也需要产品替换和全球合规，模型保留研发及少数归属，未加独立自主技术溢价。所有远期市场休市日历需未来核验，按目标日前最后交易日规则调整。

十年关注点是集团能否从多方向扩张转为可靠现金创造、合理资产配置和可理解的归母权益。心血管和主动脉需要持续证据，骨科和心律需质量、器械寿命与服务，机器人需终端使用和耗材复购，结构心脏需临床及支付。公司可能通过聚焦、共同渠道和重组提高效率，也可能因为层级、债务与资源分散难以获得应有利润。本文不给 2036 单点股价，不为未来未知业务额外净现值。若经营增长不伴随普通股可分配现金，长持时间也不能自动修复错误价格与不利资本安排。

## 停牌前日线与均线

行情真实日线七百一十一条，2023 年 10 月 9 日至 2026 年 8 月 31 日，两来源价格历史验证没有未解开高低收问题。旧参考 6.075 港元低于 20 日 6.6235、60 日 6.6616、120 日 7.7915、250 日 9.9616，距离约负 8.28%、负 8.81%、负 22.03%和负 39.02%。各均线五交易日斜率分别约负 1.91%、负 1.51%、负 2.18%、负 1.41%，显示停牌前多周期下降，尚无均线趋势修复。公司订单或重组消息不改变已经发生的价格结构，技术弱势也不能证明未来核查结论。

停牌前 20 日回报约负 10.07%、60 日负 15.15%、120 日负 40.44%、250 日负 53.34%，风险溢价与经营预期变化已反映在持续回落中，但下跌多不等于便宜。估值比较应考虑完整经常归母和资金条件，历史高点可以反映当时市场乐观，也可能属于过高预期。停牌期间不能把空白日补成平价样本去计算新均线，系统显示更新时间不代表有真实成交。复牌后应从实际可交易价格开始确认趋势，并在核查和资金新信息下重新解释图形，旧指标只作历史背景。

## 观察区间与量价失效

旧 20 日区间最低 5.88 港元、最高 7.345，离 6.075 约负 3.21%和正 20.91%；60 日最低 5.83、最高 7.64，距离约负 4.03%和正 25.76%。区间极值属于观察位，未经触碰次数或逐笔成交验证，不能视为可靠防线。复牌后若价格与真实成交支持下重新站上 6.62 至 6.66 附近旧均线，并连续稳定后再观察回踩，才有依据讨论修复；如果跳空越过旧 5.83 或 7.64，这些点不再能够定义原短期风险。财报核查和债权变化可能让图形直接失效，止损不保证按旧价成交。

52 周日线高 16.28、低 5.83，停牌前距高约负 62.68%、距低正 4.20%，窗口最大回撤约 63.43%。从高点回落幅度很大，但没有证据证明旧高点合理，更不表示公司可在半年恢复原估值。重大信息风险可能比过去波动更大，历史低位不是最大损失边界。分析不画没有逐笔数据支持的精确成交量分布，也不把低位换手直接说成大资金吸筹。当前风险首先是无法交易和信息未完成，图形观察不提供优先于财报的推荐分。

## 周线动量与辅助指标

周线一百五十二条，20 周均线 7.1138、60 周 10.0611、120 周 8.3255，旧参考分别低约 14.60%、39.62%、27.03%；250 周真实样本不足，留空。20 周和 60 周五周斜率分别约负 9.04%、负 1.53%，120 周约正 0.06%，整体仍以近中期下降为主。停牌前最后周不完整，不能与完整历史周成交直接相比。复权以同一锁定价格方法处理，公司行动须另外核，周线长期样本缺失不能用推算补齐。周线能够提示旧市场承压节奏，不能给出复牌日期或偿债结果。

日线相对强弱指数约 36.91，MACD 差离负 0.1646、信号负 0.1033、两倍差柱负 0.1226，十四日平均真实波幅约 0.2959 港元、占旧价 4.87%；周线相对强弱约 31.09、平均真实波幅 0.7386 港元、12.16%。周线柱局部正不抵消价格与均线弱势，也可能是跌势减速而非反转。上述指标共用价格输入，不作为多项独立证据重复评分。旧相对强弱较低不等于超卖必涨，平均波幅不能限制停牌后跳空，财报与资金信息仍然优先。

## 成交量单位及同日相对市场

锁行情成交量股与手尚未完成跨源单位核验，活动模型把日周均量、量比、涨跌日量、精确成交额和换手留空，原字段仅存审计。复牌后需要核成交单位、公司行动和真实可流通股，再比较 5、20、60 日量能；当前不能声称旧下跌有某类资金承接，也不从周最后半周量值认定缩量企稳。量能可以描述交易强度，不能识别账户意图。没有逐笔资料不生成精确筹码成本图，对停牌证券尤其应避免看似可量化的短线赔率。

市场比较改用同一锁定恒指历史截至 8 月 31 日：恒指 20 日约负 1.70%、60 日正 1.24%，微创医疗负 10.07%、负 15.15%，同日超额分别负 8.37 和负 16.40 个百分点。原锁表将停牌股 8 月底价格窗口与市场 10 月窗口混合，本章保留原始审计值并覆盖为同日比较，未重采行情。两个窗口均弱于市场，较可能反映公司特定经营、债务和披露担忧，但相对弱势仍不能判断最终核查。行业完整同日基准缺失，行业超额留空，未来复牌后需要重新比较器械同业。

## 外资目标价与矛盾输入

可核旧新闻中，摩根士丹利 2026 年 5 月 21 日目标 10.5 港元、与大市同步，指出控股折价由 30%扩大至 45%；美银 4 月 8 日目标 13.9 港元、买入，调整脑科学退并和费用；花旗 1 月 8 日目标 16 港元、买入；野村 2025 年 7 月 28 日目标 8.81 港元、中性。机器人标题的 4 月 8 日摩根大通新闻正文明确微创医疗 00853 目标从 18.2 降到 18 港元、增持，保留为跨公司明确提及来源，不能误把机器人 42 元套本股。每机构仅最新合格记录，不把历史重复新闻堆成共识。

花旗转载把收入与盈利写成人民币，但其收入规模、美元公司报表和同时给出的市盈率数量级不一致。本文保留已能核的港元目标、评级和新闻日期，却不采用这些有疑点的预测利润和收入作为模型输入，也不擅自把币种改成美元充作原研报事实。美银、摩根士丹利等转载也未提供完整原模型、目标期限或净债分配，所以不能精确断言价格差异全部来自某一倍数。公开目标是外部观点参考，证据缺失应明确，不能只选最高 18 港元当成正式一年或年底上行目标。

上述个股目标均超最近 90 日、停牌前且没有已取得原始研报，研究日后的租赁与资金状态不能由旧评级覆盖。10 月 6 日摩根大通行业利率讨论提及公司估值敏感，没有本股更新目标，不能计作近 90 天目标证据。本文没有平均旧目标，不将 12 个月常见惯例冒充已核期限，也不按剩余月份缩放年底价。新报告若公开，应记录机构、日期、代码、币种、评级、原始或转述和期限，再与集团抵销、归母费用及资金模型交叉比较。直到可靠复牌资料出现，旧目标不能替代正式推荐条件。

## 经济环境与具体风险传导

利率提高会增加新融资和医院设备采购成本，也抬高长周期增长价值的折现，集团比低债盈利厂商更敏感。存款利息增加与较低账面成本贷款只是部分缓冲，合同本金、溢价和再融资条件影响更大。国内医保与集采影响器械单价、渠道费用和使用量，海外经济波动改变医院资本预算、进口及汇款。公司需求包含老龄和病患基础，但经济下行仍可推迟可择期采购与手术，不能因为产品救治疾病便认为收入永不受周期影响。模型的数量收入、毛利、费用和融资应随真实传导调整。

集团多地区多产品可以分散部分经营风险，也可能增加注册维护、质量、税务和管理复杂度。欧美本地业务与中国出口渠道并非同样增长驱动，地缘冲突或供应链中断可能影响交付和维护。人民币或欧

元变化既影响美元呈列又影响现金债务匹配，内地现金汇出限制及少数股东权限也影响母公司偿债速度。正文不套共用宏观乐观段落，而把风险落在具体业务外部收入、完整成本和归属。若海外扩张需要更多服务库存但渠道回款变慢，经营盈利改善不保证资金压力下降。

## 最终反证与更新程序

下一步核验顺序是正式中报及租赁关系、资产与保证金；随后是12月债券与次年贷款的债权选择、豁免范围和可用现金；再核集团外部收入、机器人终端转化、持续归母和少数归属；最后替换骨科处置、脑科学权益与研发资本化的新口径。每项更新须同时修改模型和文字，不只保留更高目标。若融资改变本金和股数，要按同一情景联动；若业务退出合并，要改全套收入成本、现金与权益。没有原件的指标保持缺失，不用万字叙述制造数据已经完整的印象。

微创医疗的经营资产具有实质研究价值，成本压缩和全球化存在改善可能，但当前可核事实同时显示持续经营亏损、融资期限压力、主体现金限制和未完成财报。推荐被推翻的条件包括核查重大损失或披露问题、偿债安排失败、完整经营利润未达、内部销售不能转外部现金、少数与资本稀释侵蚀每股分享以及长期研发服务能力受损。条件表展示这些门槛下可能的经营价值，不是可交易获利概率。待财报、交易及债权条件可靠完成后，再基于新现价重建四期限正式评分与年底期望。

## 来源与核验记录 不计入独立正文字数

2025年报2026-04-30 16:45收盘后，https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0430/2026043001292.pdf。物理89页利润、91至92页资产负债、95至96页现金、97至98页持续经营、126至130页分部与地域、145至146页研发资本化、162至163页应收现金、170至178页债务、191页股本、194至197页处置。原始金额美元千元，历史模型百万、未来十亿美元。

8月31日延迟与停牌公告22:59：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0831/2026083103079.pdf，同文9月1日21:48再刊https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0901/2026083103079.pdf。8月12日中期预告22:16：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0812/2026081201333.pdf。8月20日租约22:27：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0820/2026082001635.pdf。

7月29日骨科协议20:36：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0729/2026072901471.pdf；7月15日意向20:58：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0715/2026071501319.pdf。8月26日心脉未经审计财务21:48：https://

www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082601803.pdf。9 月底月报 10 月 7 日 16:31：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1007/2026100700714.pdf。

目标新闻：MS 2026-05-21 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/00853/AAFN/NOW.1525636/research-report；BofA 2026-04-08 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/00853/AAFN/NOW.1516289/research-report；Citi 2026-01-08 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/00853/AAFN/NOW.1494646/research-report；Nomura 2025-07-28 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/00853/AAFN/NOW.1456379/research-report；JPM 2026-04-08 文内明确本股 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/02252/AAFN/NOW.1516185/research-report。均新闻二手、陈旧，未用于年底直接目标。

# 微创脑科学 02172 HK

02172.HK 参考价 8.05 HKD

暂不排名。2026-09-01 起停牌；10 月 9 日无有效可交易收盘价，2026 中报因关联租赁审查延迟，核心当前利润/现金未可核。保留条件经营估值参考，不列四榜、不算正式目标回报或年底期望。

以下仅是融资、存续或复牌条件成立后的估值参考，不计算正式推荐分、涨跌幅、含息回报或判断加权期望价。

| 条件参考期限 | 目标日 | 悲观参考价 | 基准参考价 | 乐观参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年底 | 2026-12-31 | 1.68 | 6.98 | 12.58 |
| 半年 | 2027-04-09 | 1.60 | 8.91 | 17.81 |
| 一年 | 2027-10-07 | 1.74 | 9.72 | 19.63 |
| 三年 | 2029-10-09 | 1.65 | 12.36 | 26.91 |
| 五年 | 2031-10-09 | 1.21 | 13.71 | 30.45 |

2026 年底成立条件：财报及租赁审查最终可出具可靠结果、无致命披露/索偿或业务失效；仍受集采和出口不及预期压力；财报及关联租赁审查完成并获准复牌；国内平稳恢复、海外放量，真实经营与现金支持经济盈利；审查未发现重大不可恢复损失，国内产品升级和海外渠道收入显著兑现；不把绿色通道当批准，不为脑机无订单收入估值

半年成立条件：财报及租赁审查最终可出具可靠结果、无致命披露/索偿或业务失效；仍受集采和出口不及预期压力；财报及关联租赁审查完成并获准复牌；国内平稳恢复、海外放量，真实经营与现金支持经济盈利；审查未发现重大不可恢复损失，国内产品升级和海外渠道收入显著兑现；不把绿色通道当批准，不为脑机无订单收入估值

一年成立条件：财报及租赁审查最终可出具可靠结果、无致命披露/索偿或业务失效；仍受集采和出口不及预期压力；财报及关联租赁审查完成并获准复牌；国内平稳恢复、海外放量，真实经营与现金支持经济盈利；审查未发现重大不可恢复损失，国内产品升级和海外渠道收入显著兑现；不把绿色通道当批准，不为脑机无订单收入估值

三年成立条件：财报及租赁审查最终可出具可靠结果、无致命披露/索偿或业务失效；仍受集采和出口不及预期压力；财报及关联租赁审查完成并获准复牌；国内平稳恢复、海外放量，真实经营与现金支持经济盈利；审查未发现重大不可恢复损失，国内产品升级和海外渠道收入显著兑现；不把绿色通道当批准，不为脑机无订单收入估值

五年成立条件：财报及租赁审查最终可出具可靠结果、无致命披露/索偿或业务失效；仍受集采和出口不及预期压力；财报及关联租赁审查完成并获准复牌；国内平稳恢复、海外放量，真实经营与现金支持经济盈利；审查未发现重大不可恢复损失，国内产品升级和海外渠道收入显著兑现；不把绿色通道当批准，不为脑机无订单收入估值




**日线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量单位尚未完成交叉核验，量图和量能指标暂不展示。来源及异常修复见行情锁版。停牌公司仅绘最后真实交易日以前历史，不把停牌填充值作为交易。**



**周线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量单位尚未完成交叉核验，量图和量能指标暂不展示。来源及异常修复见行情锁版。停牌公司仅绘最后真实交易日以前历史，不把停牌填充值作为交易。**

发行人 I007；证券 S007。资料截止 2026 年 10 月 9 日。行情使用锁定 market-v1.6；最后真实交易日 2026 年 8 月 31 日，历史参考价 8.055 港元。2026 年 9 月 1 日起停牌，四期限得分及推荐梯队均为“暂不排名”；不能把行情网站 10 月 9 日更新时间当可交易收盘。模型版本 neuro-conditional-whole-group-economic-PE-v1.0；所有下表仅为完成财报审查、可持续经营和真实产品销售条件下的估值参考，既无正式上涨空间也无年底加权期望价。

| 期限 | 悲观条件价 HKD | 基准条件价 HKD | 乐观条件价 HKD | 主盈利期间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年底 | 1.6830 | 6.9818 | 12.5801 | 2026 假设 |
| 半年 2027-04-09 | 1.6046 | 8.9069 | 17.8149 | 2027 假设 |
| 一年 2027-10-07 | 1.7357 | 9.7152 | 19.6294 | 2027 假设 |
| 三年 2029-10-09 | 1.6474 | 12.3618 | 26.9121 | 2029 假设 |
| 五年 2031-10-09 | 1.2087 | 13.7118 | 30.4506 | 2031 假设 |

## 投资结论

微创脑科学是已经商业化、曾具备较高毛利及经营现金创造能力的神经介入器械公司，不能用尚未上市药品的成功率模板一概估值。与此同时，截至研究日公司未公布二零二六年中期财务，且停牌原因涉及租赁交易背景、商业合理性和装修会计处理，这使“经营质量不错”与“现在值得买入”之间存在无法跨越的数据缺口。进取型标准允许承担产品扩张和估值波动，却不能要求投资者用旧价格和未经确认的利润排序。现阶段最合理结论是保留完整基本面研究、列入复牌后重估观察名单，不给予半年到五年的正式分数或购买顺序。低估可能存在，但不能在停牌期间被验证成可执行机会。

公司具有出血性脑卒中器械布局、国内医院覆盖和逐步拓展海外的基础，长线潜在收益来自产品组合升级、海外销售占比提升、经营费用效率及资本分配改善。反方向的证据也非常具体：国内收入不增长，急性缺血性脑卒中和动脉粥样硬化收入下降，销售费用上升、应收账款大幅增加，投资联营企业连续亏损并发生减值。已经有真实销售并不代表每个研发方向都能够转成利润；上市许可不等于采购，创新审批通道不等于批准，脑机接口合作不等于收费订单。这些边界决定本章不为尚无商业化证据的脑机故事额外加一笔巨额市值。

条件估值显示，即使集团保持存续并完成可靠财报，未来价格仍可能在很大范围内变化。年底基准条件值约六点九八港元，来自假设二零二六年国内七亿元人民币、海外一点四五亿元收入及完整费用后约二点零六亿元归母经济利润，采用十八倍市盈率。年底乐观条件值约十二点五八港元需要更好的产品增长、费用效率与二十四倍估值共同实现；悲观条件值约一点六八港元仍假设集团可以维持正常业务。它不是最大损失边界，严重会计、索偿或持续披露问题可以使该经营模型失效。由于没有十月九日有效现价，本章不把任何条件价除以八月旧价生成正式预期收益。

## 公司业务与临床需求

脑血管介入治疗解决的是卒中、动脉瘤及脑血管狭窄等疾病，采购链条涉及专科医生、医院准入、临床路径、医保和集中采购，和大众消费医疗不同。病人通常不会凭品牌广告自行选择植入器械，医生熟悉度、器械性能、风险管理、可获得性和预算共同决定使用。老龄化为疾病负担提供长期支撑，但手术量增长并不是公司收入必然增长：器械平均售价可能下降，复杂病例的产品结构可能变化，招标份额和经销商库存也会改变。这家公司的投资逻辑必须同时回答产品为什么被采用、采用之后谁获得利润，以及销售收款能否及时兑现。

二零二五年收入为七点九零四八三亿元人民币，相比上年七点六一七六二亿元增长约百分之三点八。二零二一年到二零二四年从三点八二八亿元上升至七点六一八亿元，体现业务曾经历较快规模扩张；二零二五年的明显减速则提示成熟产品和采购周期正在影响增长。不能简单把早期复合增速外推到未来五年。整体收入依然增加，但增量已不足以掩盖区域和产品内部的变化。若未来半年中报补发显示国内业务持续下滑，基准估值的恢复假设需要下调；如果海外渠道的增长同时带来现金回款，才可确认它正在形成第二增长来源。

地域拆分提供了比总收入更有辨识力的信号。二零二五年国内收入六点八五五五四亿元，前一年为六点八六四六八亿元，基本持平；海外收入从零点七五二九四亿元增至一点零四九二九亿元，增长约百分之三十九点四。海外约占总收入百分之十三，意味着国际扩张目前只能有限抵消国内的压力。即使海外下一年增长四成，只要国内价格和份额下降，总增长仍可能不快。反过来，国内稳定、海外继续放量才会带来逐步提升的收入弹性。本章的基准预测要求两者都成立，乐观情景则需要海外显著扩大，但没有把海外增长率永久固定在四成。

出血性卒中产品收入四点七五三七八亿元，比上年四点三九九零五亿元增长约百分之八点一，是二零二五年最主要的收入支撑。这一领域涉及弹簧圈、血流导向装置及配套器械，医生对输送系统、释放控制和长期安全性具有实际要求。产品组合越完整，公司越有机会在手术中提供配套方案，但组合销售不是当然的排他优势：医院可能采用多厂家产品，招标价格和操作偏好仍会影响各环节。投资者应

把该板块拆成成熟品种的份额和价格、升级产品的采用速度，而不是只用“国产替代空间大”解释全部增长。

动脉粥样硬化产品收入二点六五三九五亿元，低于上年二点七一八四八亿元；急性缺血性卒中产品收入零点四六五九九亿元，也低于零点四七九七九亿元。两个领域各自下降，说明公司并非所有产品线都处于同一上升周期。新的取栓、通路及支架产品获得许可可以扩充工具箱，仍需要跨过培训、医院试用、医保预算和常规采购的转化过程。急性缺血性产品当前收入规模较小，百分比增长可以很快，却不应直接用小基数增速给全集团赋予高倍数。乐观估值必须最终表现为可见的金额贡献，而不是注册证数量增加。

年报披露约覆盖三千八百家医院、相关器械用于约二十九万台手术，这是渠道规模和临床接触面指标。不同手术可能使用数量不同的器械，也可能通过不同结算路径，因此不能把总收入除以手术数当作净收费单价，更不能把手术数量当成唯一付费患者数量。医院覆盖也有深浅之分：进入医院目录、开展试用、稳定批量使用的经济价值不同。可验证的下一步是观察已有医院的复购、经销商的实际消化和应收结算。若覆盖面增加但收入、现金和存货质量没有相应改善，渠道扩展的投资回报应当被重新审视。

## 产品 审批及创新证据

NUMEN 系列弹簧圈的国内和国际布局构成商业化基础。二零二六年五月二十五日公告确认 NUMEN Helia 获美国 FDA 上市许可，这是已核原件支持的许可事件，不能与早期审批通道混为一谈。美国市场进入条件更复杂：经销合作、医院采购、医生操作习惯、质量追溯及售后能力都影响真正销售。获得许可消除了一个重要门槛，却不提供未来销量保证。半年判断中，该事件应视为销售转化的可观察起点；三年判断中，则需要证明单个产品可以带动配套器械和持续复购，而不是在新闻公布时一次性支付全部海外成熟价值。

Tubridge 血流导向装置是理解价格压力的重要例子。年报指出带量采购影响收入，说明产品的技术属性和定价权之间并无绝对对应关系。中标可以扩大可及性和使用量，但如果净售价下降超过销量增长，收入和单位利润仍会下降。采购合同的量并不总等于即时现金收款，公司也可能承担市场教育和渠道费用。基准情景对国内增长采取恢复但不激进的假设，原因就在于集采后的量价平衡需要实际财报验证。若新一轮招标再次大幅降低价格，应调整收入和毛利同时降低，不能只下调售价却保留原有利润率。

年报记载 Bridge MAX 于二零二五年九月取得国内许可，NeuroHawk 和 AISAdvance 于三月、AISFast 于九月获批。对器械公司，多个环节产品可以帮助建立完整治疗方案，研发团队也可能在材料、输送和

导管设计上共享知识。经济意义仍取决于每个环节在手术中的价值、被采用的频次和销售成本。已上市产品的新增贡献可以进入经营预测，但本章没有逐一填造市场份额或价格。本公司缺乏截至截止日完整可核的各产品收入单价和库存消化资料，用总销售及费用比例建立条件集团模型，比伪精确地给每个注册证估计收入更诚实。

APOLLO Dream于二零二六年三月十八日获得FDA突破性器械认定；Artemis Dream于七月三十日进入国内创新医疗器械绿色通道；NuWismen液体栓塞剂于九月二十四日进入该通道。三项均是研发和监管沟通进展，但本章核查的原件不支持把它们写成已经取得上市批准。突破性器械认定可能促进审评沟通，绿色通道可能便利创新产品程序，均不能替代安全有效性证据、制造体系及最终注册要求。把这些事件与五月NUMEN Helia实际批准分开，是估值输入最基本的纪律。审批推进可以构成催化，却不能提前确认商业收入。

脑卒中器械的临床价值不仅在技术新颖，还在并发症、手术操作成功、再治疗和长期结局。某器械降低某一操作风险，并不必然证明所有病例都优于现有治疗。研究设计、入组病情、对照和随访长度决定证据适用范围。本章未取得能够统一比较所有新产品的公开头对头长期资料，因此不虚构临床优势排序。对长期投资者，关键反证是产品在真实使用中出现安全警示、召回、监管限制或医生采用明显低于预期。此类事件会同时冲击销售、费用和估值，不能仅在风险段落提一句却保留高收入预测。

Tigertriever来自Rapid Medical，公司拥有其大中华地区独家分销安排，不能把代理产品写成公司完全自有知识产权。分销可以丰富手术方案、共享客户覆盖，也可能受供应、价格、合同期限和对方经营状况影响。Rapid的投资回报与Tigertriever销售回报应分开：前者体现联营企业亏损和估值，后者体现国内渠道营业收入及利润。投资账面价值下降，并不自动意味着代理产品失去全部需求；代理销售增长，也不自动恢复投资价值。这种分离避免用一项产品的临床故事掩盖投资财务损失，也避免把同一经济权益重复估值。

## 竞争 渠道与经济周期

公司在神经介入领域的竞争优势来自研发和注册经验、临床使用积累、医院网络及产品配套，而不是专利数量本身。年报提及已授权二百二十九项专利、二百九十余项申请及一百九十四项商标。专利有不同保护范围、地域和剩余期限，商标更多体现品牌资产，数量不能直接换算成股权价值。分析护城河应问竞争者需要多久达到可替代性能、医生转用成本多高、价格下降时公司仍能赚取多少利润。若医院采购更强调等效和低价，产品品牌的高溢价可能收缩；若性能确实解决难题并被长期证据支持，部分品种才可能保持差异化。

中国专科治疗需求受人口结构、诊断能力和医生供给共同推动。疾病患者数量可以很大，但符合介入适应症、及时送达有能力医院并接受手术的人数更少。基层转诊和卒中救治网络改善可能扩大潜在需求，医生培训和手术资源却需要时间。宏观经济下行对刚性卒中治疗的直接冲击通常小于可选消费医疗，但财政、医保支付和医院采购预算仍会约束器械使用。把“刚需”理解为“不受经济影响”会忽略支付端。三年预测可给予需求空间正面评价，同时必须把医保和医院采购制度写进量价假设。

带量采购的短期影响常表现为售价压缩、经销商重整和收入确认节奏变化，长期则可能扩大普及并改善集中度。公司是否受益取决于成本控制、供货稳定和中标后使用量，不宜用行业口号预设答案。二零二五年国内几乎零增长已说明量的补偿并未让全部产品线同步上升。若未来出现量增长、毛利稳定及现金回款改善，采购后的经营模式可以被证明更稳健；若销售费用继续上涨而收入停滞，说明扩量成本可能吞噬降价后的利润。条件模型因此同时设置较低毛利、较高销售费率的悲观组合，避免只在收入端表现压力。

海外扩张不能仅按国内产品性能复制。各国注册、经销商能力、保险支付、医生选择和法律责任不同，单个国家批准不代表全球通行。美元或欧元收入增长还受人民币汇率影响：人民币贬值可能提高报表折算收入，却同时改变进口组件成本和海外费用。港元报价最终由人民币盈利换算，也可能受到香港利率和市场风险偏好影响。本章采用每人民币一点一港元作为估值假设，并明确其并非截止日已核汇率；正负一成的换算敏感性在其他条件不变时线性改变港元条件价，经营端真实汇率效应则不会只有线性关系。

利率下降可能降低权益估值折现压力，但对脑科学这样的现金资产较多公司也会降低存款收益。二零二五年利息收入约一点五六零三千万元，经营利润中包含这部分收益。若利率下降推动市盈率上升，同时现金利息下降，两个方向应一并考虑。高现金余额可以帮助扩张和承受调整，不能自动获得两次价值：先用含利息集团盈利乘市盈率，再把同一现金资产全部加上，会高估权益。本章条件估值坚持整集团盈利方法，现金资产另作偿付及流动性检查，未叠加净现金资产值。

渠道结构需要和增长质量一起判断。前三大客户收入分别约一点九六八零一亿元、一点四三九七四亿元及一点一四九三五亿元，合计四点五五七一亿元，约占全年收入百分之五十七点六五。集中度可以来自大型经销商体系，而非仅三家终端医院，这为覆盖提供效率，也增加对少数付款方的依赖。对方调整库存、授信或区域采购会对收入产生明显影响。未来补发中报的关键观察不是单纯客户数，而是收入集中度、退货或返利条款、应收余额及账龄是否协调。如果收入增长主要伴随更长信用期，应降低商业质量评价。

## 财务利润与现金质量

二零二五年毛利五点八零七二一亿元、毛利率约百分之七十三点四六，高于多数普通制造企业，但产品毛利不能等同于归母可分配利润。销售费用一点六七七七亿元、行政六点三零一五千万元、研发费用七点七九一九千万元，还要支付其他经营及融资费用。运营利润三点一七四九六亿元，低于上年的三点二六八二一亿元；说明收入小幅增加时费用变化已经影响经营杠杆。若投资者只看高毛利和创新产品，就会漏掉获取医院采用、维持合规和持续研发的真实支出。未来估值需要看完整费用后利润，而非把毛利额作为价值替代。

研发费用下降尤其需要细分。二零二五年研发总投入一点零八七六八亿元，其中三点零八四九千万元资本化，损益研发费用七点七九一九千万元；不能把损益费用下降直接解释成研发效率大幅改善。资本化将部分支出转入资产并在以后摊销，经济成本没有消失。年内现金流中无形资产资本支出二点七九四三千万元，又与会计资本化金额不完全相同，差异可能来自付款和会计确认时间。本章未来研发费率按完整经济负担作情景设置，不把降低研发损益率当作免费利润提升，也不机械把当年全部资本化支出重复加回或重复扣除。

销售费用由上年一点三二四七二亿元升至一点六七七七亿元，增加三点五二九八千万元，远快于收入增长；行政费用也从五点五八三二千万元升至六点三零一五千万元。费用增加可能服务海外渠道和新产品推广，但截止日前缺少二零二六年中报验证其收益。对于成长公司，一段时期先投入后收获可以合理；若投入持续上升、国内不增长和海外金额有限，则需要更审慎。基准模型保持较高销售和研发费用，乐观情景才假定规模带来部分费率改善。费用率的每一点变化都对应可计算利润差异，不能只为得到目标价而选择更低比例。

二零二五年其他收入四点七四九千万元，包含政府补助三点五九二一千万元、利息一点五六零三千万元、汇兑收益一点一一三百万元，同时受到公允价值损失五点一七八百万元等抵消。补助可能支持研发和产业项目，但持续金额取决于政策及申请，不能把当年全部补助按永续利润资本化。利息更接近现金资产回报，公允价值损失则具有不同性质。条件模型仅保留部分正常补助和较低现金利息，未知的新补助、投资回升及汇率收益不被当作保证。这会使模型利润与公司非通用会计准则数字不同，差异具有经济理由而非漏算。

税前利润二点三零九八亿元，扣税四点七二二九千万元得到集团利润一点八三七五一亿元；少数股东亏损七十五点九万元使归母利润一点八四五一亿元。这里集团和母公司利润不相同，不能把集团调整利润直接除以母公司发行股数。年报披露调整集团利润二点九八五三二亿元，计算为法定集团利润加股权激励一点八八一五千万元、SAFE 公允价值损失一点一零四七千万元、联营减值五点九五七二千万

元及联营亏损二点五三四七千万元。该指标用于展示特定项目影响，但并不证明所有加回均可永久消除。

股权激励属于真实员工报酬，虽然可能不当期消耗现金，仍以股数或机会成本影响普通股东。二零二五年股份费用一点八八一五千万元，本章正常盈利不永远将它加回。联营企业亏损同样不能只因“非核心”就无限忽略，投资者需要知道公司是否仍会提供资金、代理依赖是否要求继续支持。一次性减值与重复经营亏损可以分离，但分离后也不能再给已经减值的投资加高额资产值。更可靠的分析是披露正常化假设、保留必要费用，并把投资价值与经营利润划清。本章采用的未来经济利润并非公司官方盈利预测。

经营活动现金流二点零二零二三亿元，低于上年二点八四四一亿元。扣除固定资产现金支出一点九七二千万元和无形资产二点七九四三千万元后，融资前自由现金约一点五四三六亿元，仍为正，但与高毛利和调整利润的印象存在差别。现金税五点一三零九千万元、租赁本金二点五一零一千万元、股息现金八点四零四四千万元及激励买股二点九七四千万元继续消耗资金。年末现金六点一一二五四亿元，较年初六点二二五八一亿元小幅下降。这说明公司具备现金缓冲，也说明可用于扩张的资金要扣除真实资本和股东分配需求。

应收贸易款从一点四四零六一亿元增至三点二一零二九亿元，增幅明显超过收入。现金流调节中应收增加一点八二七八二亿元，是经营现金转化变差的重要解释。账龄净额中约一点一三六二七亿元处于六十一至九十天段，另有更长部分；原件信用政策通常三十至九十天。期末应收受销售时点和渠道调整影响，不能凭一年跳升断定坏账或造假，但必须要求补充财报解释及后续收款验证。未来若账龄继续延长、信用减值上升，应同时调低利润质量和估值倍数。没有现金支持的增长很难成为长期复利来源。

存货从一点五七三一八亿元降至一点一八六五八亿元，现金流中存货释放约三点八六六千万元，有助于抵消应收占用。存货下降既可能说明生产库存效率提高，也可能反映产品供应和渠道库存周期，不能自动解释为终端需求强劲。年报区分原材料、在制品和成品，原材料六点五三五二千万元占有较大份额。若新产品集中上市需要备料和渠道铺货，营运资本可能再次增加。因此预测自由现金不应永久复制库存释放。条件 PE 模型另以压力预算检查现金需求，若未来现金转化显著恶化，需改用更严格现金流估值而不是继续使用同倍数。

## 投资资产 资本支出及租赁核查

Rapid Medical 二零二五年收入一点七一三八亿元，低于上年一点九一三九二亿元，全年亏损一点一三七六亿元。脑科学持有约百分之二十二点三的权益，确认联营亏损二点五三四七千万元及减值五点九

五七二千万元，年末该联营投资账面价值已降至零。另有SAFE未来股权协议，其二零二五年公允价值损失一点一零四七千万元也把对应价值降至零。SAFE损失已包括在公允价值相关项目和调整利润桥中，不能第二次加回。零账面值不是断言Rapid产品没有临床价值，而是当前财务资产不能再随意作为正净资产重复加入集团估值。

年报其他联营投资五千万元对应深圳市中金脑科学与类脑智慧产业私募股权投资基金，公司权益约百分之二十。基金名义出资总额十亿元、已缴一点零三五亿元，二者不同；不能把未缴或整只基金规模当公司现金资产。该投资可能带来行业信息或项目接触机会，但基金投资回报时间、退出和新增出资存在不确定性。与Rapid零账面值分开核查，可以避免把年末联营资产五千万元误当Rapid恢复。整集团盈利模型没有把基金投资价值另叠加；若未来改为分部估值，必须同时剥离相关投资收益和母公司支出，保持单一经济归属。

年末现金等价物六点一一二五四亿元、非流动定期存款五点二零八六千万元以及流动结构性存款四点零六七七九亿元，账面总池约十点七零一一九亿元。但结构性存款不是无限制即时现金：八笔来自五家银行，购买成本四点零五亿元，预期年收益百分之一点三五至一点八六，公允价值分类为第三层。短期正常银行风险未必很高，仍需考虑期限、赎回和产品条款。分析偿付能力时先使用现金等价物，其他资产核对可动用条件后再加入。十点七亿元是二零二五年末资产口径，不是二零二六年十月可用现金承诺。

年末合同资本承诺二点二八二八五亿元，另有已批准未签约三点九五三二千万元，合计二点六七八一七亿元。这一规模远大于二零二五年已支付固定资产现金支出，提醒投资者新基地建设等项目可能改变现金趋势。年报记载土地使用权一点三三六九亿元及税四点一四六百万元于二零二五年十二月开工时由预付款转入在建工程，不能把这个会计转移误当当年同金额现金支付。资本项目可能支持产能和研发，也可能在利用率不足时产生折旧、维护和资金占用。必须追踪实际付款节奏及投产收益，不能只把净现金当作闲置可分配资产。

压力预算以二零二五年末现金六点一一二五四亿元为起点，假定未来一年经营现金一点五亿元、支付全部合同资本承诺及部分未签约项目、租赁本金二千五百万元、现金股息八千万元和审查整改现金四千万元，示意终值约三点四八四三七亿元。这里每个未来数字均为预算假设，不冒充二零二六实际余额；合同付款可以跨期，股息也未获未来声明确认。该示例说明，即使现金正值，资本配置仍会消耗显著缓冲。若审查发现额外索偿、银行产品无法赎回或回款恶化，预算要重做，不能用旧现金证明没有风险。

租赁核查直接影响本次可评估资格。八月二十六日晚公司先宣布董事会推迟，九月一日早八点五十六分公告进一步说明中报延迟，并从当日九时停牌。核查涉及出租方及相关人士背景、与公司股东的关

系，租金和保证金条款合理性，以及额外装修成本合理性和会计处理。原件提供的是需要核实的事项，并未宣布已经确认造假、资金被挪用或特定损失金额。本章不扩大事实，也不将其淡化为普通时间安排；涉及关联关系和财务确认的缺口，足以影响治理、流动性和目标利润可信度，须等待可核结论。

年报已披露二零二二年与上海回青橙投资管理有限公司签订五年租约，用于生产、仓库及办公室，二零二五年末相关保证金账面二点五八一二千万元，总租赁保证金二点五八三千万元。保证金通常到期可退，不能直接全额当损失；也不能因为已有年报披露就认为二零二六核查已获解决。出租方关系、租金公允性、装修归属、损益和资产确认各自可能有不同结果。模型把额外成本作为独立情景输入，年底基准一千二百万元、悲观三千五百万元，均为可编辑压力假设而非调查预计值。实际结果超出时必须改算。

现有年报的审计意见与当前中报缺口是两个时间点。经过审计的二零二五年历史数据可以作为基础，却不能替代二零二六经营和核查结论，也不能被推断成审计师已经认可后续全部交易。研究需要等待中报中的会计处理、关联披露、可能重述及现金影响；若存在独立审查，也应读方法、范围和保留事项。复牌本身只解决可交易性的一部分，不保证财务问题消失。只有有效市场价格、足够当前财务及明确审查结果同时具备，才可以重新产生分数、年底回报及各期限推荐位次。

## 股份 激励和股息

九月月报核实法律总发行股数五点八五零九九三八亿股，其中法律库存一千六百五十五点六万股，外部股数五点六八五四三三八亿股。三者关系必须准确：外部加库存等于法律总股。库存股不等于已注销股，不能永久减少估值分母。六月二日回购公告提出总额五千万至一亿港元计划，此前已回购一百四十六点六万股，库存未来可以用于激励。后续九月底库存明显更多，采用早期公告数会漏掉之后变动。条件年底模型使用全部法律发行股，作为未来库存再次用于员工奖励的保守分母。

八月二十一日股息新股实际新增六万四千五百七十一股，发行价九点零一四四港元，和先前预计最多发行五百六十七万余股完全不同。以股代息最终选择数量需要看翌日披露，不能用上限代替实际。八月前总股数五点八五零三四八零九亿，加入实际新股后得到当前法律全股。未来情景分母缓慢扩大反映可能新增激励或其他稀释，并非断言公司一定配售。本章没有为未来库存使用假设额外现金流，也没有把回购计划当作保证注销。这样，利润增长不能因错误的股数处理被放大为每股增长。

四月一日授出五十五万份期权，行使价十点九七港元，按五年每年百分之二十归属，公告未附业绩目标。七月八日期权未行使约八百五十点六二万份，与法律总股及库存不同。激励可以留住研发和临床人才，但是否和每股现金回报对齐应观察条件及新增费用。不能把行使价高于旧参考价理解为不会产

生任何成本，也不能把全部期权立即等同新发行股。本章未来全股情景只是一致性稀释预算，实际执行需逐次更新月报、归属和行权，不把期权现金收入、费用加回与稀释收益混在一起。

二零二五年末期股息每股零点零九港元，于二零二六年七月二日除净，记录日七月八日，现金或凭证八月二十一日安排派发，股息股八月二十四日上市。截止研究日该股息已在过去，不能算进未来半年和一年总回报。部分股东以股代息，未核实际全部现金总支付，不能用全股乘零点零九就声称全部付现。由于中报未发，未来派息金额和是否恢复也不应填造。本章条件价是价格估值，不带虚构分红回报；将来有正式宣派并核对除净时点后，才能在总表按持有期加入含息回报。

## 半年历史图形与量能限制

锁定行情历史覆盖二零二三年十月九日至二零二六年八月三十一日，共七百一十一根日线、一百五十二根周线。十一根原始日线存在明确开高低收逻辑不一致，已用独立同日完整数据修复并保留记录；价格采用归一到名义价格的复权口径，现金股息与历史事件一同保存。这为理解停牌前趋势提供基础，但不能延伸成十月九日即时信号。停牌日没有真实成交，行情更新仍显示八点零五五的行为是旧价延续，不是市场证明基本面稳定。复牌时的新信息可以导致跳空，旧均线和观察位只能作历史参照。

八月三十一日旧参考价低于二十、六十、一百二十和二百五十日均线。相应均线约八点七二八五、九点二五四一、九点七六五五和十点八三一港元，距离分别约负百分之七点七二、负十二点九六、负十七点五二和负二十五点六三。近五日均线斜率也全部为负，说明停牌前短中长日线一致偏弱。这里使用数字解释趋势，却不赋予“现在已经超卖反转”的评价。相对所有均线偏离可以来自悲观预期，也可能来自实质问题；必须等复牌后的价格发现及新增财务决定原有趋势是否仍具解释力。

历史最近二十日区间低点八点零零五、高点九点二四港元；六十日高点十一点三，低点同为八点零零五。旧价离区间低点约百分之零点六，意味着停牌前接近低位，但不意味着该价位会构成复牌后的有效支撑。若新信息使价格跳空低于八点零零五，旧低点不会像可执行止损一样提供保护。若财务完成且价格重新进入八点七三至九点二五均线区间，也需要持续成交和收盘位置确认，单日跳升可能是停牌累积的价格重估。观察区间是检验位置，不是预先承诺的买入卖出路线。

日线相对强弱指标约三十一点五，MACD 差值及信号均为负，柱值约负零点零九二五，平均真实波幅约零点二七七三五港元，即旧价的百分之三点四四。指标共同反映弱势与较大波动，但它们高度依赖同一价格序列，不能分别当三项独立利好或利空重复打分。接近低位的 RSI 并不能判断租赁核查何时解决，ATR 也不提供最大跳空损失。半年分析最大的失效条件是信息集已经改变，而非某个指标金叉。复牌后需先获得真实完整日线，再对趋势和波动作更新，不把停牌空白补成平盘交易。

周线二十、六十、一百二十周均线约九点三五、十一点零六、十点一九港元，旧价全部低于这些水平。二十和六十周均线明显下降，一百二十周斜率接近零，显示中期走弱发生在更长历史平台之下；历史仅一百五十二周，二百五十周均线没有足够样本，本章明确留空。日线与周线方向一致增加了停牌前弱势判断的可信度，但两者依然只是同一历史的不同聚合。临近停牌的一周还可能不完整，不能把其成交总数与完整周直接比较成缩量结论。这一点对技术型半年排序尤其重要。

成交量单位尚未完成跨源核验，锁定数据虽保存供应商均量、量比等原字段，本章不把它们作为精确正式量能数字。现有最后成交股数、当天换手和成交额在研究模型均留空，避免把行情网站停牌零值当真实流动性或直接采用未确认单位。上涨日和下跌日成交量也不能用未核原字段断言“主力出货”或“吸筹”。可以说价格趋势弱、交易在八月底结束，却不能进一步声称知道资金主体。完成单位、公司行动和同日价格交叉检查后，未来复牌报告再计算量比及均量，所有分母需写清是否包含当日。

相对强弱必须对齐停牌前最后交易日。本章从同一锁定恒生指数历史重算截至八月三十一日的二十、六十交易日：恒指分别约负百分之一点七零和正百分之一点二四，脑科学分别约负百分之八点七三及负百分之十三点四三，因此同日超额为负七点零二及负十四点六七个百分点，两个窗口都弱于市场。原锁表把个股八月终点与指数十月窗口相减的字段保留为审计原始记录，不用于正式比较。行业完整可核序列仍缺失，行业超额留空。未来复牌后应以新财报与真实交易观察相对同业表现，旧弱势不是未来必然下跌概率。

## 条件估值的模型结构

本章估值使用单套活动经营模型，按悲观、基准、乐观依次保存条件快照。收入拆国内及海外，成本、销售、行政和研发逐项以比例计算，正常补助、利息、融资费、联营亏损和核查额外成本分别记录；税后集团利润再扣少数股东归属得到母公司经济利润。每股人民币利润除以条件发行全股，再乘市盈率和港元换算率。现金利息已经进入集团盈利，所有现金、定存、结构存款及基金不再加资产净值；融资费用已进盈利，不重复扣债务资产净值。这是整集团 PE 方法的边界，不是宣称资产或债务没有意义。

经济研发费率的设定意在覆盖长期产品维护、创新支出及相关激励，不照搬损益中受资本化影响的短期低值。未来成本和费用比例是完整组合假设，并非在历史损益上简单再扣全部研发现金；因此不会一边沿用含摊销的历史利润，一边重复把同项费用扣两次。正常股权激励不被无限加回，未来分母又保留可能新增奖励，两者分别反映报酬经济成本和每股归属。模型优点是每项都能追溯，限制是缺少

二零二六已披露财务检验。补发后必须用真实收入、费用、现金及股数更新，而不是沿用原条件价充当最新目标。

年底基准国内收入七亿元、海外一点四五亿元，合计八点四五亿元；成本率百分之二十六、销售二十三、行政八点五、研发十四，另有正常补助一千八百万元、利息一千三百万元，扣融资二百万元、联营亏损五百万元及核查费用一千二百万元。税率百分之十八，少数归属一百万元，得到归母经济利润约二点零六三亿元。法律全股约五点八五一亿，十八倍 PE 和一点一换算对应六点九八港元。每个参数都属研究假设，国内恢复和海外继续增长是必要条件，中报缺口使其不能被描述为确定的年底盈利。

年底悲观收入七点四亿元，成本率百分之三十、销售二十六、行政九点五、研发十六，额外核查费用三千五百万元，配合较少补助及较高联营损失，归母经济利润约零点八九五二亿元，十倍 PE 得到约一点六八三港元。年底乐观收入九点一亿元、较好成本和费用效率、无额外核查费用，归母经济利润约二点七八八亿元，以二十四倍 PE 得到约十二点五八港元。悲观仍具有经营利润和可靠财报前提，并未覆盖永久停牌、重大赔偿或经营失效；乐观也没有把所有注册进展当即收入。条件区间只能用于评估参数压力。

半年和一年使用同一个二零二七经营年度，基准国内七点六亿元、海外二亿元，归母经济利润约二点三八九亿元。半年采用二十倍 PE 及五点九亿股，一年采用二十二倍及五点九五亿股，对应八点九一和九点七二港元条件价。一年倍数较高是审查完成、复牌交易和经营兑现后风险偏好恢复的情景假设，并非时间经过自动获得溢价。如果审查仍未完成或新收入只是授信铺货，一年不能无理由高于半年。两个期限的区别在信息验证和估值容忍，经营现金检验失败时两者都需下调。

三年基准二零二九收入十二点三亿元，其中国内九亿元、海外三点三亿元，完整费用后归母经济利润约三点一一六亿元，以二十二倍、六点一亿股得约十二点三六港元。五年基准收入十五点三亿元，国内十点五、海外四点八亿元，归母经济利润约三点九八九亿元，以二十倍、六点四亿股得十三点七一港元。长期收入和利润增长并不被全部转换成更高倍数，反而假定成熟后估值趋于正常，同时股数扩大。国内从平稳恢复到逐步增长、海外多年扩张、销售研发保持完整投入，是这些长期条件价成立的共同基础。

悲观三年和五年收入仅七点九和八点五亿元，较高费用使归母利润分别约七千六百万元和六千九百万元，五年股数又扩至六点三亿、PE 降至十倍，条件值降至一点二一港元左右。乐观五年收入二十四点五亿元、海外九点五亿元，归母利润约七点五三亿元，二十五倍、六点八亿股得约三十点四五港元，要求国际市场实现规模且费用有效吸收。较大乐观空间来自两个经营变量和估值倍数叠加，不能解释成常规回报。若海外仅获得许可没有大规模销售，乐观路径根本无法成立。

估值敏感性可直接按模型重算：相同归母经济利润和股数下，PE 从二十变为十六，条件价下降两成；从二十变二十四则上升两成。若基准二零二七收入九点六亿元、销售或成本费率增加一个百分点，税前利润减少九百六十万元，税后及母公司归属随之变化，影响又会被倍数资本化。股数从五点九五亿增加到六点五亿而利润不变，每股条件价值下降约百分之八点五。汇率、盈利、倍数和股数需要分别展示，不能把收入增长一个变量当成所有情景价变化的解释。这也是不采用网站未经核 PE 直接给结论的原因。

## 四期限逻辑与失效路径

半年期最先需要解决的是审查、中报和复牌条件，之后才谈海外许可兑现、渠道销售及技术形态。如果这些事项及时完成且没有重大财务损失，低预期可能修复；如果停牌持续，投资期限和资金可动用性已经发生变化，即使经营长期存续也无法提供半年交易退出。实际买入决策应使用复牌后的真实价格和完整成交，再核二零二六收入、应收及租赁事项。本章不把八月旧参考价当机会门槛，也不以历史接近低点作为抄底理由。短期论据若依赖缺失信息，增加文字或指标无法弥补。

一年期关注二零二七是否能从财报恢复阶段进入业务验证阶段。国内产品量价能否企稳、美国及其他国际许可是否产生收入、销售费用投入能否带来回款，是基准二点三九亿元经济利润的支点。若真实收入仍停留二零二五水平、应收增长超过销售、资本开支持续占用现金，即使公告更多创新产品，也不足以支持二十二倍完整利润。反证可以定量写成：国内持续负增长、海外规模未达假设、毛利或费率偏离造成归母利润低于基准，应降低条件值并撤销风险修复假设。不能等待到年底再解释为暂时因素。

三年期关键是从国内单一区域和少数成熟产品，变成多产品、多市场的可复制商业体系。成熟器械企业的复利来自重复采购、可靠供货、产品迭代和现金再投资，而不是每三个月出现一条注册新闻。基准海外三点三亿元占收入约四分之一多，已经要求国际渠道持续发展；投资者要观察国际收入质量及实际利润归属。研发、营销和产能之间的投入顺序也重要，提前建设但需求不及会降低资本效率。若新产品安全性、海外合规或关键经销合同出现重大问题，三年逻辑会从成长变成修复，估值倍数应随之改变。

五年期评价的重点是公司是否具有持续自我更新能力。模型保留较高研发和销售支出，避免把成熟后费用率压到不现实水平；同时不因名义收入增加永久抬高 PE。长期持有价值需要每股利润与现金增长，回购、激励、资本开支和对外投资都要服从这个目标。若企业不断以新股支持无法回收的项目，或把核心现金用于长期低回报关联及战略投资，集团增长也可能不能形成股东回报。五年乐观值对海外规模要求很高，真正的证据是几年连续稳定现金和利润，而不是行业总市场空间。

十年经营展望可以正面看待卒中治疗需求、诊疗网络完善及器械创新，但很难对单家公司维持确定份额作承诺。现有产品可能被更安全、简便或价格更低的技术替代，支付制度可能继续推动标准化和降价，国外企业与本土新竞争者也会进入。可持续优势要表现为临床证据积累和下一代产品能力，公司曾经上市的器械不会天然提供十年护城河。脑机、神经内镜等方向可能开辟新的治疗领域，却属于更长技术和商业化周期。本章把十年用于检验经营耐久性，不填造十年目标股价，更不把早期合作的整个市场归公司所有。

## 脑机方向与治理条件

五月二十八日与OYMotion签订战略合作，涉及脑机和外骨骼等方向；StraitPass神经内镜及其他脑科学探索表明公司试图拓展介入之外的能力。合作可以共享技术、临床应用和产品开发资源，但已核公告没有量化订单、收入或利润承诺。未来价值需要明确产品定义、临床适用、监管路径、支付方式和商业分成。将脑机接口总市场乘一个随意份额，再把现有神经介入利润高倍估值相加，会形成巨大重复和投机输入。条件模型对脑机独立净现值设零，意为缺乏可估证据，不是宣称该技术或合作没有潜在价值。

微创体系的关联关系需要逐公司而非按同一集团名字判断。脑科学年报明确微创医疗于二零二五年十二月失去对脑科学的控制，后者成为其权益法投资。脑科学自己的合并收入不会仅因此消失；微创医疗集团后续不能继续把脑科学收入全额并表，再加持股市值。已披露关联采购、服务和往来余额需要核查商业目的、定价及回款，但不能仅凭有往来就认定核心资金被抽走。租赁事项说明当前核查有具体范围，治理评价应立足其真实结论，并要求对未来关联交易及控制变化作持续透明披露。

恢复推荐的证据门槛是连贯的：补发可靠中报并解释审查结果，清晰确认可能重述、赔偿和现金影响，获得交易所允许复牌并产生有效价格，核对最新股数及可用现金，再用真实销售和营运资本替换条件参数。任何一个步骤缺失，都可能使排序误导。若这些条件满足，不必永久因为一次延迟排除公司；研究应重新计算并允许事实改变结论。反之，如果复牌只靠技术安排而重大财务核查保留，不能因开市了就立即给高成长评分。进取型偏好应提高对机会的反应速度，同时要求机会建立在真实信息上。

## 外部目标与研究边界

本章公开核验未获得最近九十天或重大事件后、具有明确机构、日期、期限、币种及来源的有效外资个股目标价，机构目标栏留空。行情资讯中行业观点、历史目标或公司新闻不能替代当前可核个股报告；也不能拿同集团其他上市公司的目标换成本公司的目标。未来若取得机构十二个月价格，可以作为一年模型参照，并拆解其采用的利润、资本化和风险假设。年底条件价仍需依据年底信息集重算，

不能直接采用十二个月目标或按剩余月份线性缩放。研究缺失明确列示，比补上一个看似完整但无法查证的数字更有用。

本文约束集中在交易价格、当前财务和监管核查三个实际缺口。历史财报、已发注册公告、股数及股息日期仍有较高证据质量；未来经营、费用、税率、PE 和稀释均属低可信情景假设。条件价格不提供获利概率、统计置信区间或最大损失限制，亦不适用于尚未解决的重大经营失效。独立正文的充分程度不能把低可信输入提升为高可信结果。后续修订应保留本版参数与来源，以便比较哪里改变，任何新的现价、评分或回报必须在有效信息恢复后重新生成，不能只在旧表数字旁换上更新日期。

## 来源

- [二零二五年年报，2026-04-27 21:45 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0427/2026042703070.pdf)。物理页 9 历史；21 – 30 产品；173、175 – 176 财务；179 现金；204 – 208 收入与研发；225 – 230 联营、结构存款及应收；248 资本；256 承诺；258 – 259 关联。

- [中报延迟及停牌，2026-09-01 08:56](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0901/2026083103061.pdf)，文件署八月三十一日。

- [NuWismen 绿色通道及继续停牌，2026-09-24 08:00](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0924/2026092400057.pdf)。

- [九月股数月报，2026-10-05 17:23 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1005/2026100501484.pdf)。

- [NUMEN Helia 美国上市许可，2026-05-25 18:07 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0525/2026052500019.pdf)。

- [APOLLO Dream 突破认定，2026-03-18 17:16 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0318/2026031800902.pdf)。

- [Artemis Dream 绿色通道，2026-07-30 08:09](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0730/2026073000073.pdf)。

- [股息时间表，2026-07-22 17:44 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0722/2026072200706.pdf)；[以股代息，17:35](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/

2026/0722/2026072200666.pdf)；[实际新股，2026-08-21 20:23 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0821/2026082101397.pdf)。

- [回购计划，2026-06-02 22:40 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0602/2026060202886.pdf)；[期权，2026-04-01 22:19 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0401/2026040104264.pdf)。

- [OYMotion 合作，2026-05-28 16:34 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0528/2026052800543.pdf)；[董事会延期，2026-08-26 22:44 收盘后](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082602057.pdf)。

- 原件目录 data/neuro_sources.json、data/neuro_supplement.json；锁定 data/market_snapshot_locked.json；历史 data/history/S007.json；条件原子模型 data/neuro_model.json。截止日后的实质资料未纳入。

# 微创机器人 02252 HK

02252.HK 参考价 21.18 HKD

暂不排名。9 月 1 日起停牌；10 月 9 日没有有效可交易收盘，2026 中报租赁关系核实延迟，预告非正式财报。保留条件经营估值，不排名、不算正式涨跌幅/年底期望。

以下仅是融资、存续或复牌条件成立后的估值参考，不计算正式推荐分、涨跌幅、含息回报或判断加权期望价。

| 条件参考期限 | 目标日 | 悲观参考价 | 基准参考价 | 乐观参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年底 | 2026-12-31 | 0.00 | 13.08 | 32.13 |
| 半年 | 2027-04-09 | 0.00 | 13.60 | 35.00 |
| 一年 | 2027-10-07 | 0.00 | 14.43 | 36.54 |
| 三年 | 2029-10-09 | 0.00 | 20.74 | 51.71 |
| 五年 | 2031-10-09 | 0.00 | 23.92 | 55.20 |

2026 年底成立条件：财报租赁关系核实后仍能复牌但渠道回款与新安装受压；亏损经济 PE 路径为 0，非预计清算股价；可靠财报及复牌许可；2027 系统 275 台收入假设、耗材使用和真实回款兑现，完整费用形成持续利润；审查没有重大不可恢复问题，海外和终端使用显著兑现，2029 后产能扩张须新增预算，不能把现有 500 台能力当自动扩产

半年成立条件：财报租赁关系核实后仍能复牌但渠道回款与新安装受压；亏损经济 PE 路径为 0，非预计清算股价；可靠财报及复牌许可；2027 系统 275 台收入假设、耗材使用和真实回款兑现，完整费用形成持续利润；审查没有重大不可恢复问题，海外和终端使用显著兑现，2029 后产能扩张须新增预算，不能把现有 500 台能力当自动扩产

一年成立条件：财报租赁关系核实后仍能复牌但渠道回款与新安装受压；亏损经济 PE 路径为 0，非预计清算股价；可靠财报及复牌许可；2027 系统 275 台收入假设、耗材使用和真实回款兑现，完整费用形成持续利润；审查没有重大不可恢复问题，海外和终端使用显著兑现，2029 后产能扩张须新增预算，不能把现有 500 台能力当自动扩产

三年成立条件：财报租赁关系核实后仍能复牌但渠道回款与新安装受压；亏损经济 PE 路径为 0，非预计清算股价；可靠财报及复牌许可；2027 系统 275 台收入假设、耗材使用和真实回款兑现，完整费用形成持续利润；审查没有重大不可恢复问题，海外和终端使用显著兑现，2029 后产能扩张须新增预算，不能把现有 500 台能力当自动扩产

五年成立条件：财报租赁关系核实后仍能复牌但渠道回款与新安装受压；亏损经济 PE 路径为 0，非预计清算股价；可靠财报及复牌许可；2027 系统 275 台收入假设、耗材使用和真实回款兑现，完整费用形成持续利润；审查没有重大不可恢复问题，海外和终端使用显著兑现，2029 后产能扩张须新增预算，不能把现有 500 台能力当自动扩产




**日线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量单位尚未完成交叉核验，量图和量能指标暂不展示。来源及异常修复见行情锁版。停牌公司仅绘最后真实交易日以前历史，不把停牌填充值作为交易。**



**周线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量单位尚未完成交叉核验，量图和量能指标暂不展示。来源及异常修复见行情锁版。停牌公司仅绘最后真实交易日以前历史，不把停牌填充值作为交易。**

发行人 I009；证券 S010；02252.HK。研究截止 2026 年 10 月 9 日；行情锁定 market-v1.6。2026 年 8 月 31 日历史参考价 21.18 港元，9 月 1 日起停牌，10 月 9 日没有有效可交易收盘价。四期限得分、正式上涨空间、含息回报、年化回报和年底加权期望均不适用。历史财报证据可信度高，2026 经营预告与未来经营假设可信度较低。以下条件估值不参加四榜，也不代表复牌后可成交价格。

| 条件观察时点 | 悲观方法值 | 基准条件值 | 乐观条件值 | 币种与前提 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年年底 | 0 | 13.081 | 32.133 | 港元，可靠财报及复牌条件成立；采用 2027 前瞻盈利 |
| 2027 年 4 月 9 日 | 0 | 13.599 | 34.997 | 港元，2027 经营预测获得支持 |
| 2027 年 10 月 7 日 | 0 | 14.427 | 36.544 | 港元，原目标 10 月 9 日为周六 |
| 2029 年 10 月 9 日 | 0 | 20.739 | 51.713 | 港元，逐年资金与扩产条件仍待核 |
| 2031 年 10 月 9 日 | 0 | 23.916 | 55.197 | 港元，完整长期经营及资金路径条件仍待核 |

## 投资结论与推荐边界

微创机器人的核心吸引力是图迈腹腔镜手术机器人已经从早期产品验证进入海外销售扩展，2025 年收入增至 5.511 亿元，2026 年公司披露的累计订单和商业安装继续增加。其潜在价值来自设备销售形成安装基础，再由器械、耗材和维护服务逐年贡献收入；如果终端手术使用频率、现金回收和售后能力同步提高，商业模式可能从一次设备采购走向更连续的经营现金流。与只有研发故事的机器人企业相比，已完成商业安装和实际手术是实质进展，但这些进展尚不足以让当前证券获得正式推荐排名。

截至研究日，公司因一项租赁安排需要进一步确认交易对方与集团关系而延迟中报，并自 9 月 1 日上午九时起停牌。公告同时表示经营稳定，这是一项公司陈述，不能替代财务报告及核查结果。本章的判断顺序是先核实信息与交易资格，再核实收入质量、持续盈利和现金，最后决定合理估值。进取型标

准可以接受较高经营波动，却无法把没有可交易现价、没有正式中报的证券包装成确定的半年机会。当前结论为保留深度观察，暂不排名，等待可靠财报和复牌条件。

条件模型的基准路径并没有给予低估值。年底按 2027 年归母经济盈利约 3.066 亿元、法律全股约 10.313 亿股、四十倍前瞻市盈率及每人民币折合 1.1 港元的研究汇率，得到 13.081 港元的方法值。如此倍数已经要求海外持续增长和费用效率兑现；它明显低于停牌前 21.18 港元历史参考，意味着历史交易价格包含了比本章基准更积极的盈利期待。这里不计算两者的正式收益率，因为投资者无法在 10 月 9 日按历史参考价建立可执行的新仓位，复牌首日也可能出现无法预设的跳空。

基准逻辑成立至少需要四项公司层面的证据。租赁关系核实和正式中报应能支持历史收入、负债与费用的可靠性；已安装设备应能产生真实使用、耗材购买和现金回款；海外扩张不应依赖关联渠道不断增加库存或延长账期；增长期间完整研发、激励、售后和合规费用应保持足够预算。若其中任一项持续恶化，即使订单宣传仍然增长，也应重算经营模型。暂不排名不是认定公司必然失败，而是资料与交易状态尚不足以把条件经营价值转化为正式推荐。

## 公司业务的经济结构

微创机器人的上市公司主体为上海微创医疗机器人集团。产品覆盖腹腔镜、骨科和血管介入等方向，其中图迈是增长最重要的核心平台，鸿鹄对应骨科手术，另有血管介入及其他手术工具。年报在会计层面只呈现一个报告分部，2025 年 5.39267 亿元收入归为手术机器人系统、器械及配件合并项，服务收入 770 万元，其他客户收入 275.8 万元，以及其他来源 134.4 万元。没有可核的设备、耗材和单一产品历史收入拆分，所以本章未来拆分明确属于研究假设，不能据此倒推公司曾披露过的平均单价。

对这家公司，设备安装只是收入链的一个起点。医院或渠道从采购决策到场地准备、人员培训、验收、正式开展手术、重复购买器械，之间可能经历数月。设备端的价值取决于每年交付的系统数量和净售价，器械端的价值取决于已投入临床的设备基数、每台手术量、每例器械消费以及价格，服务端则取决于保修结束后的覆盖率和收费能力。将累计安装乘以固定终身价值，容易忽略医院使用不足、免费服务期、经销折扣和设备换代。本章分别观察这些经济变量，而不把所有机器人公告压缩成一个订单增速。

海外销售经常需要分销商协助获得注册、安排物流和工程师服务。集团体系可能提供渠道资源，使一家规模有限的机器人公司快速进入多个市场，这本身有商业意义。但上市机器人主体与微创医疗母集团的经济边界不同：对子公司而言关联销售可能符合收入确认条件；在母集团合并层面，内部交易需要抵销，最终价值仍然依靠外部客户的需求。因此投资者研究机器人与母公司时不能将同一批设备在两个层面重复计入外部收入或利润，不能把集团渠道关系等同终端医院已现金购买。

## 图迈的订单与安装证据

2025 年年报披露图迈全年新增安装八十台，其中海外超过六十台。2026 年 2 月公司自愿公告累计商业订单超过二百台，6 月 17 日公告累计图迈订单超过三百台，全部核心产品累计订单接近四百台，并表示上半年新订单已超过上年全年。6 月 26 日又披露图迈全球商业安装超过二百台，且所计商业安装均有终端验收报告。这些数字分别描述新增、累计、某一产品和全部产品，不能互换。三百台累计订单不是 2026 年新售三百台，二百台累计安装也不是全年确认收入二百台，更不代表设备款已全部到账。

终端验收报告比只有渠道订货更接近真实临床部署，是重要的验证升级。不过验收与医院常态使用之间仍有区别。验收可以确认设备配置和功能达到约定，持续手术量则反映科室是否把平台纳入日常流程，耗材复购才进一步证明设备形成稳定利用。公司目前没有在已核原件中提供逐国、逐医院、逐装机月份的使用率及回款桥，故不能宣称每台新增安装都具有相同收益。后续应同时追踪新安装、在用设备、每台手术频率、器械收入和账款周转，才能判断装机快速增长是否转化为可复现的利润。

订单提速并不自动消除执行风险。设备出口可能受医院预算审批、进口许可、汇款、培训和本地安装资源影响，合同交付日期也可能调整。若产能足够但安装团队不足，库存与应收可能先增长，收入和现金兑现不同步；若为了抢占市场提供较长信用期，销量改善可能增加资金占用。2026 年公司公告强调交付效率、供应链和规模化生产，证明管理层认识到这一环节，但尚无正式中报数据量化改善。本章基准模型对 2027 系统数量的假设应在正式财报发布后按终端交付和回款证据逐项替换。

## 产品许可 临床应用与技术叙事

图迈单孔腹腔镜机器人于 2025 年 2 月获国内注册批准，远程手术系统于 2025 年 4 月取得国内上市批准；年报还披露美国食品药品监管局允许远程人体试验的研究器械豁免。这三类事件具有不同意义。国内特定产品注册批准可以支持对应市场商业化，美国研究试验许可允许按研究规则开展试验，不能写成美国全面商业销售批准。未来美国经营假设须以具体产品、适应范围、正式注册和实际商业渠道为前提，本模型没有单独加入美国市场成功的确定价值，也未将不同司法管辖区的许可数量直接变成收入。

年报描述图迈完成接近八百例远程手术，公司披露的实施成功率为百分之百；6 月公告又提及覆盖多国和不同通信方式的远程应用。这里的实施成功率是公司所述统计口径，不能解读为所有患者结局百分之百良好，或任何情况下不存在连接延迟、网络中断、责任归属与应急接管风险。远程应用的长期商业潜力在于跨区域协作和培训，但常态收费、保险、医生执业、跨境数据及救援流程需要逐市场建立。投资模型应把演示成功与可重复运营区分，收入不能只根据距离纪录或新闻曝光估计。

自主手术大模型MicroGenius在年报及2026年公告中仍处于动物实验和仿真验证阶段。其研究价值可能体现在轨迹规划、操作辅助、视觉理解和培训效率，距离独立完成获准人体商业手术仍存在临床、责任与监管验证。本章没有为自主人体手术另加净现值，也没有把算法训练成果当作软件订阅收入。若未来取得严谨的人体证据并形成付费产品，再评估它是否扩大单台设备的收入和利润；在此之前，相关研发成本继续包含于完整研发费用，而不能只给潜在技术加值同时剔除开发支出。

## 鸿鹄及其他产品的定位

鸿鹄骨科机器人年报披露累计订单约六十五台，并描述国内、美国与欧洲许可进展，包括髋膝相关欧洲认证。它与腹腔镜平台的销售流程、使用场景和耗材生态有所差别，不能将图迈海外增速直接复制到骨科。骨科手术机器人需要适应医院现有植入物体系、医生规划习惯和临床路径，客户选择可能与植入物供应商关系绑定。年报没有给出可核的各产品独立损益，所以模型将其纳入全组合系统和其他收入假设，避免凭产品数量虚构多个独立盈利分部。

R-ONE血管介入机器人于2023年12月取得国内注册许可，2025年披露安装六家医院。相较图迈，它尚处更小的商业基础，真实使用、适用手术流程和团队训练对成长影响更大。其他呼吸介入等产品也有年报中的上市或技术进展，但在未获独立销售数字之前，只能视为产品组合选择权及研发资源分配对象。管理层应证明多产品扩展没有过度分散销售、售后和研发预算。投资者对新平台的关注宜落到首批医院持续使用、单例成本及付费意愿，不能只统计注册证或产品名称。

## 市场需求与竞争优势的边界

图迈海外增长主要面向手术机器人渗透率较低、价格敏感度较高的市场。当地医院可能希望以低于成熟国际平台的采购与使用成本建立机器人手术能力，这为具有完整设备、培训和服务支持的厂商提供机会。机会的实现取决于医院愿意为临床效率和患者价值支付多少，而不是人口规模本身。中等收入市场的预算、融资、汇款和医保覆盖可能限制采购速度，低渗透率同时意味着基础设施与人才体系不足。公司进入多个国家能够分散单一市场风险，却会增加注册维护、备件和工程师网络的固定成本。

成熟全球厂商通常具有庞大的安装基础、医生训练体系、器械组合和临床证据。新进入者可以从价格、远程操作、地区服务或特定技术改进获得机会，但设备性能达到可用并不代表能立刻获得同等黏性。医院更换平台涉及人员学习、维护、流程和既有器械投资，采购决策也受服务可靠性影响。图迈若要获得持续溢价，需要证明高频使用下的稳定性、维护响应和总拥有成本，而不是仅在一次演示中完成手术。本章四十倍基准前瞻市盈率要求竞争优势能够长期支撑完整费用后的现金盈利，已包含较高商业预期。

国内市场存在进口替代与医疗装备升级需求，同时也有医院预算约束和多家本土厂商竞争。2025 年公司国内收入 1.50839 亿元，略低于 2024 年的 1.53725 亿元，显示该年总增长主要由海外推动，不能概括成国内外同步高增长。若国内竞争要求降低设备净售价或提供更多免费培训，收入增长可能伴随利润率压力。支付制度和设备采购政策的改善可能帮助医院使用，但全国政策方向需要落实至地方收费、医保与医院决策。本章不把二手投行新闻所述政策标题直接当成已核监管事实，国内模型保持数量、价格和使用率分别可调。

## 产能 安装资源与规模效应

2025 年年报描述的生产能力为每年三百台；2026 年 6 月 17 日自愿公告更新为图迈等多种手术机器人年生产能力超过五百台。这是产能信息的时间变化，不能把六月份口径追溯成 2025 全年已有同样能力，也不能认定五百台都专供图迈。产能上限与实际合格交付之间还有零件质量、排产、型号结构和安装服务的差异。模型 2027 基准全组合系统销售二百七十五台，乐观四百一十台，仍低于公告所述组合能力；2029 和 2031 乐观系统数量超过现有五百台，明确需要后续扩产和相应资金，而非自动沿用当下能力。

规模效应最初可能通过采购议价、标准化装配和固定生产费用摊薄体现，但海外业务扩大同时增加本地服务与合规支出。2025 年毛利率约 48.38%，较上年显著改善；2026 年利润预告预计上半年毛利率同比提升超过十五个百分点，尚无正式中报确认完整计算。长期利润率不能简单延续每年大幅上升，成熟后设备价格竞争、保修、产品升级和耗材降价可能抵消成本改善。本章基准 2027 成本率 40%，以后约 38%至 38.5%，是规模兑现与竞争并存的假设，而非已经观察到的稳定净毛利。

## 财务增长与归母利润质量

2025 年收入 5.51069 亿元，同比增长约 114.2%，销售成本 2.84447 亿元，毛利 2.66622 亿元。销售费用 2.03608 亿元、行政费用 4563.7 万元、研发费用 2.15982 亿元，三项合计约 4.65227 亿元，仍显著高于毛利。其他净收入 1227 万元，公允价值损失 1761 万元，物业及商誉减值 3131.6 万元，经营亏损 2.35261 亿元。融资费用 1980.9 万元、联营亏损 104 万元及联营减值转回 199.5 万元后，集团净亏损 2.54115 亿元。营业增长和费用下降带来改善，但当年尚未出现持续全口径经营盈利。

归母净亏损为 2.49660 亿元，少数股东亏损 445.5 万元，两者合计回到集团亏损。2024 年集团亏损 6.47101 亿元，归母亏损 6.42406 亿元，其中联营投资减值 1.16467 亿元及联营亏损 2024.4 万元影响较大。同比亏损收窄既包含经营毛利增加和研发销售费用减少，也包含非经常减值变化。不能把收窄幅度全部解释为同样可持续的经营效率。长期估值需要完整费用后的归母利润，而不能对集团利润和归母利润随意取较高者，少数股东在未来可能从亏损转为分享盈利，模型已单独设置归属项。

公司 2025 年经调整集团亏损 1.64987 亿元，由法定集团亏损加回股权支付 4219.7 万元、公允价值损失 1761 万元、减值 3131.6 万元，再扣除减值转回 199.5 万元得到。这项指标帮助观察某些估计与资本项目的影响，但股权支付并不因为非现金就没有股东成本。研发和人员激励构成持续经营所需投入，长期模型不能永久加回。权益变动中的股权支付合计与利润表差异还包含联营层面的 4.9 万元，不能重复添加。本章使用经济盈利，完整计费用和激励，不把经调整亏损直接当成未来可分配现金利润。

## 2026 上半年预告可以支持什么

7 月 22 日晚间正面盈利预告预计 2026 上半年集团净利润 2800 万元至 4000 万元，而 2025 同期集团净亏损约 1.15 亿元；预计收入同比增加 200%至 230%，图迈海外收入同比增幅超过 450%，毛利率提高超过十五个百分点。公告说明资料来自未经审计管理账目，未经审计委员会确认，实际中报可能不同。这足以支持商业化加速和潜在扭亏的观察，却无法填造中期现金、应收、母公司归属利润、其他收益或租赁负债。报告保留预告范围与其不确定性，未来模型输入并不标成已披露实际。

扭亏预告需要拆解成持续部分和暂时部分。收入快速增加可能提高生产摊薄效率，费用预算下降也可改变盈亏平衡点，但产品结构、补助、汇兑、资产处理和应收减值都可能影响净利润。正式中报应至少提供收入确认政策的执行情况、关联销售占比、回款和合同负债、完整研发、股权支付与融资费用。假如最终净利润接近预告而经营现金流仍被长期应收吞噬，经济评价仍需降低；如果利润与现金同步且医院使用继续增长，才足以支持下一阶段估值。单独一个净利润范围不能完成这些验证。

## 关联交易与收入确认

2025 年关联方商品销售 3.88573 亿元，占集团收入约 70.51%，关联服务销售 294.8 万元；年报明确超过收入百分之十的主要客户均为关联方。这是分析本公司的关键事实。关联渠道可能提供进入市场与售后服务的效率，也可能使销售质量更依赖集团体系的资金和库存管理。本章既不把关联交易自动判为虚构，也不将其当成完全独立终端需求。应同时核验合同、发货、安装验收、渠道库存、应收与现金，并理解各主体在母集团内外的归属，才能判断销售是否形成稳健的外部经济价值。

收入政策说明，在由经销商负责安装的部分安排中，商品控制权可在发货时转移；由公司负责安装的安排则在客户接受后确认，服务按履约期间确认，器械按交付确认。因此单独看商业安装统计不足以还原所有会计收入，也不能用发货收入直接推定对应医院已运行。2025 年贸易债务财报细分关联客户 1.82775 亿元、第三方 2604.3 万元，合计 2.08818 亿元；关联余额披露中的 1.89873 亿元属于不同相关余额范围，不能强行同口径。模型与正文分别保留这些数值，避免以不一致的比较制造虚假的回款改善。

## 应收 预收与订单现金

2025 年贸易及其他应收流动部分 2.63762 亿元，非流动部分 2136.4 万元；贸易应收 2.08818 亿元的账龄包含一月以内 1.05053 亿元、一至二月 1172.2 万元、二至三月 2534.8 万元、三至六月 5586.9 万元、六至十二月 810.5 万元以及超过十二月 272.1 万元。多数贸易余额较新并不意味着全部无风险，增长快速时新应收自然占高比，相关渠道最终回款还需验证。若收入增速下降而账龄持续迁移到更长区间，坏账与现金压力可能滞后出现。医院预算、经销商资本和跨境结算都应进入信用分析。

合同负债流动 6550.8 万元、非流动 4393.5 万元，合计 1.09443 亿元，其中设备预收 5287 万元，服务剩余履约 5657.3 万元。期初 2124.5 万元，加新增预收 9479.9 万元，扣确认收入 660.1 万元，能够勾稽到期末。预收增长为经营现金改善提供支持，但服务部分将在未来数年履约，不能把所有预收当作当期利润。年报所列 5657.3 万元剩余履约义务只涉及服务，未来约五年确认，且短期设备合同适用了披露简化；它不是公司全部设备订单价值，也不能用它与三百台订单直接推算单价。

## 现金流改善及其持续性

2025 年经营现金净流出 2274.2 万元，较 2024 年的 2.98124 亿元明显改善；固定资产现金投入 259.8 万元，无当期无形资产购买现金支出，按经营现金减这些资本支出得到融资前自由现金流负 2534 万元。若进一步扣除融资分类租赁本金 3663 万元和租赁利息 178.2 万元，得到约负 6375.2 万元，与公司概括的净自由现金流出约 6300 万元接近。两种口径都可用于观察，但必须标明是否含租赁融资现金。短租 85.9 万元已经在经营现金中，不能在融资分类租赁支出之外再重复扣同一项。

经营现金改善不仅来自亏损减少。现金调节披露应收增加约 1.96486 亿元、应付与合同负债增加约 1.98008 亿元，库存释放 1979.4 万元以及折旧摊销 1.08974 亿元等因素。后者包含使用权资产折旧，若建现金流估值应与租赁支付匹配，不能一边加回全部折旧，一边遗漏租金。应付和预收资金可以帮助高速增长，但不能每年无限增长；随着交付和服务履约，资金来源可能变化。持续自由现金流需要盈利、回款、库存周转与资本开支的共同支持，2025 单年接近现金收支平衡尚不足以证明长期融资需求已经消失。

## 现金 债务与偿付约束

2025 年末现金及等价物 6.36317 亿元，借款合计 3.89050 亿元，其中银行 3.57713 亿元、相关方有抵押贷款 3133.7 万元；租赁负债 2152.9 万元。简单现金减借款和租赁约 2.25738 亿元，只是历史资产负债表截面，不能标成 2026 年 10 月现金。现金也需支持存货、备件、培训、研发和海外回款间隔。公允价值资产 4944.4 万元为非上市权益投资，不应直接当成随时可动用现金。停牌期间没有正式中报，无

法确定这些余额在上半年增长或核查中如何变化，条件模型因此不把历史净现金额外叠加到集团市盈率价值。

借款到期结构包括一年内 2879.2 万元、第二年 2475.8 万元、二至五年 3.355 亿元，显示压力并非只在最近十二月。部分授信附带约束，2025 年未违反不意味着 2026 以后仍无需复核。年报融资负债变动表 3.89406 亿元包含已在应付款中的 35.6 万元应计利息，与借款本金 3.89050 亿元不同；净债计算不能重复扣应计部分。关联方售后回租也应按其融资实质分析。集团若需要未来增股融资，必须把发行净款、价格、新增股数和现金使用联动，不能只加募集现金而保留旧股数；本条件盈利模型没有凭空增加未来融资款价值。

## 租赁安排 保证金和核查范围

年报披露 2021 年开始的一项五年上海租赁，年末租赁保证金账面 3579.2 万元，关联安排披露中折现前保证金 3666.4 万元，两者计量不同。2025 年另有与苏州骨科相关主体的三年租约，初始使用权和租赁负债 335.9 万元，年末该负债 225.9 万元。2024 年向相关主体出售样机六千万元并以六千六百万元回租的安排按融资处理，2025 年末相关借款 3133.7 万元，不能当作普通机器人销售收入。这些是已披露历史安排，帮助识别需核的资金关系，但原件没有确认它们就是 2026 延迟中报所涉及的唯一租约。

9 月 1 日公告只明确需要进一步确认报告期内租赁交易对方与集团的关系，未披露具体审查结论，也没有提供与另一家微创系上市公司相同的全面核查范围。本章不自动移植脑科学公告中的装修、保证金合理性等措辞，更不指控已经发现造假。核查结果可能影响关联方识别、披露、费用、现金可回收性或治理评价；也可能在澄清后解除不确定性。投资者应等到具体事实再重算，不能因同行公告或社交讨论就给本公司虚构整改金额。本模型中的核查额外费用是压力假设，明确非已确认损失或监管罚款。

## 股本 激励与分红

9 月底月报于 10 月 7 日十六时三十分披露，内资未上市股份 609745 股，H 股 1030720586 股，法律总股份 1031330331 股，库存股零。4 月 H 股全流通完成，将 5989798 股由非上市内资转为 H 股，总股数并未增加，也不产生新募集现金。流通结构变化可能影响可交易供给，但不能算作稀释或回购。月报列示已发行期权余额零，95199428 股为计划可授上限，不能全部认定已授予。本章年底分母采用法律总股；未来分母温和增长为激励及其他潜在稀释压力，非声称董事会已实施这些发行。

2025 年没有股息，研究截止日也没有可核的未来现金分配承诺，所以条件表不计算含息回报。盈利初期保留现金用于研发、海外服务和偿债通常有经营必要，但这不代表永远没有分红。日后若正式声明分配，应按除息日期和目标持有期计入，避免把已除净股息重复当成未来回报。长期股数增长同样需

要解释资金经济：为激励而增发与现金配售对股东影响不同，融资发行应当增加资金并调整股数。当前条件表不声称验证完整融资路径，暂不发布三年或五年的无条件年化收益。

## 估值模型的活动输入

本章采用分产品经济变量形成收入，再扣完整成本、销售、行政、研发、核查费用和融资项，经过税与少数股东归属得到经济归母盈利，乘目标时点合理前瞻市盈率。设备数量乘设备净售价形成系统收入；假设手术使用次数乘每例器械净收入形成器械收入；付费服务基数乘服务净价形成服务收入，并加有限其他收入。模型不是对历史单品账目进行重建。2027 基准国内四十五台、海外二百三十台，净售价假设四百万元和五百万元；这些单位清楚区分人民币百万元、十亿元和股数十亿，计算文件保留原子输入和每一步结果。

2027 基准器械使用十七万例、每例净收入一千五百元，得到 2.55 亿元器械收入；二百五十台付费服务基数、每台二十万元形成五千万元，其他收入一千五百万元，总收入 16.5 亿元。服务基数只是假定进入付费覆盖的设备，不是所有累计装机；使用次数不代表已披露历史手术量。完整研发占收入 15%，即 2.475 亿元，比 2025 实际研发绝对额更高；销售 15%、行政 6%、成本 40%形成可解释的费用桥。小额经常补助、现金利息和融资费用另列，税率 18%、少数股东五百万元后，归母经济盈利 3.066 亿元。

此基准预测要求公司 2027 收入达到 2025 约三倍，不能称为保守不需验证的路径。若海外新系统少于二百三十台，或者净售价下降、单台使用低于预期，收入与毛利会同时减少。相反，耗材毛利和服务效率较好可能提高盈利连续性，但模型只有合并成本率，尚无公司独立耗材毛利证据。对未知部分用明确假设比填造单品实际数字更可靠；后续正式中报和年报可以替换它们，也可能推翻目前模型结构。市盈率只是价值计算方法，不能代替经营输入的质量，尤其不应以高倍数掩盖低回款。

## 估值边界与现金重复计价

整集团经济利润包含现金利息、融资费用、全部经营费用和归属，因而市盈率估值已经覆盖该经济体系，不再加 6.36317 亿元历史现金或 4944.4 万元非上市投资，也不再次扣 3.89050 亿元借款。若改用纯经营现金流估值，则应重新定义现金债务、租赁、投资和少数股东，不能把两种方法任意叠加。当前模型没有足够当前财报和逐年资金预算来进行完整股东现金流估值，所以条件盈利桥只承担经营敏感性用途。它既不能证明未来扩产一定获得资金，也不能证明所有债务到期可持续续借，长期价格保持条件性质。

悲观路径在 2027 收入十亿元、毛利 45%、销售 20%、行政 9%、研发 21%和额外核查费用四千万元等假设下，归母经济亏损 1.14 亿元，经济市盈率法输出零。零并非预计公司复牌将以零港元成交，也不是清算净资产结论，只表示该亏损路径没有正盈利能够支持本方法价值。公司可能仍拥有现金、技术、产

品或重组价值，亦可能面临进一步损失；这些都需要另行资产或现金模型核验。把零条件方法值与两个正值加权会产生误导，故年底不套 25%、50%、25%权重，也不列期望价格或统计区间。

## 年底专项的条件信息集

2026 年底基准条件值 13.081 港元使用 2027 完整年度前瞻经济盈利，而不是将 2026 已预告半年利润机械乘二。由于研究日离年底较近，最重要的事件是正式中报、租赁关系澄清、交易资格以及下半年安装回款证据；这些可能改变市场对 2027 的认识，但尚无合理依据逐月缩放投行目标。基准四十倍、乐观五十倍前瞻市盈率分别给予增长一定溢价，后者还要求 2027 总收入 24.52 亿元和归母盈利约 6.02548 亿元。任何审查重大问题、订单推迟或外部融资紧张，都可能使条件经营假设失效。

年底乐观方法值 32.133 港元并非已核上行预测。它包含国内六十台、海外三百五十台系统销售，较高净售价和二十万例器械使用，成本率 36%、完整研发 14.5%等假设。乐观收入比 2025 增加数倍，需要交付、培训、使用和渠道回款同时达到更强水平。市盈率也受风险偏好和披露可信度影响，财报恢复只是基础条件，并不保证市场认可五十倍。本章不据历史 21.18 港元给出可交易上行百分比；正式复牌后应以真实交易价格和已公开的新信息重新建模，再决定是否发布年底目标及权重敏感性。

## 半年逻辑与反证

半年至 2027 年 4 月的经营关注是能否从预告扭亏走向正式全年度验证。若中报核查顺利完成、下半年终端安装增加、应收与合同负债桥清晰，并在年报中形成完整费用后的可持续利润，投资者可能更愿意按前瞻 2027 盈利估值。本模型半年基准仍使用 3.066 亿元归母经济盈利，分母约 10.416 亿股、四十二倍市盈率，条件值 13.599 港元。这里的倍数变化只是目标时点信心假设，半年盈利并未填成已实现。恢复交易、财报可信度和订单现金质量都比旧均线更重要。

半年失败路径包括核查结果不确定延续、无法及时复牌、最终中报与预告明显偏离，或安装快速增加但现金周转恶化。某一季度收入高增长可能来自集中发货和渠道补货，后续持续性需要独立终端需求验证。若正式财报显示关联客户账期显著拉长、退换货或坏账上升，应降低数量兑现和利润率假设；若合规、售后与研发投入比模型高，应调回完整费用而不是只保留原毛利。这些反证优先于股价短期反弹，不能因复牌后量大便解释为基本面风险已经消失。

## 一年逻辑与反证

一年目标原定 2027 年 10 月 9 日，为周六，港股观察日按此前交易日 10 月 8 日处理。到该时点，2027 中期收入、现金和装机应提供新的验证，市场可能判断公司是否从初次盈利进入稳定盈利。模型一年基准条件值 14.427 港元采用四十五倍前瞻市盈率和约 10.520 亿股分母，乐观 36.544 港元。合理一年

估值应在正式财报基础上重新评估订单、器械复购与服务占比；当前条件表不因投资时长延长就解除停牌和资金资料缺失限制，仍不参加正式一年排名。

一年最有力的正证不是利润增长一个数字，而是收入增长与应收周转、经营现金、完整研发及服务网络同步改善。若设备收入对渠道依赖下降、独立终端使用与器械复购上升，收入质量可能提高，费用率下降也更可信。反之，若医院使用未形成稳定复购，公司可能仍是一家波动较大的设备交付企业，难以获得连续现金流平台倍数。出现设备降价、维护成本超预期或关键渠道库存累积时，应降低市盈率与盈利，而不是用未来更大的地址市场解释当前差距。

## 三年逻辑与反证

2029 基准系统销售国内六十五台、海外三百三十台，器械使用四十万例、每例一千四百五十元，付费服务基数五百五十台，合计收入 26.3 亿元。完整研发仍 15%、销售 15%，成本率 38.5%，归母经济盈利约 5.3584 亿元；约 10.8 亿股及三十八倍市盈率得到 20.739 港元条件值。这个路径意在检验装机基础转向重复收入的可能性，绝非已确认的市场份额。三年需要积累多个报告期的医院使用与回款数据，还要评估 2025 末二至五年借款到期和产能追加，当前模型并未证明资金全路径。

三年乐观系统数量六百三十台超过现有公告所述五百台组合能力，必须新增制造、售后和合规投入。模型保留研发销售比例，但缺完整逐年资本开支与融资计划，所以 51.713 港元只能作为有条件经营敏感性结果。失败路径是扩张压低服务质量、应收占用过大、产品更新投入不足或竞争者压低使用成本。若服务和器械收入不能随在用设备扩大，长期倍数应向设备厂商而不是连续收入平台靠拢。公司整体增长空间与每股价值增长并非同义，资金需求和新增股份也会决定旧股东分享多少经营成果。

## 五年与十年经营持续性

2031 基准国内八十五台、海外四百三十台系统销售，器械使用七十三万例、付费服务八百五十台，总收入 36.705 亿元；成本 38%、销售 15%、行政 5.5%、研发 15%后，归母经济盈利约 7.67746 亿元。分母 11.3 亿股、三十二倍市盈率得到 23.916 港元条件值。五年收入扩大未伴随倍数持续上升，反映企业成熟后竞争与增长降速。乐观路径 61 亿元收入、约 14.552 亿元归母经济盈利需要更大系统销售和使用基础，同时要求投入与服务能力扩展，因此其 55.197 港元仍非无条件长期推荐。

十年展望应关注平台持续被医生和医院使用的能力，而不是给 2036 股价写单点目标。产品需要持续迭代、保持器械兼容与质量、积累证据、适应支付和监管，并在远程操作或智能辅助中形成可收费价值。若技术演进降低单台设备成本，却由竞争者获得主要利润，行业增长也可能不等于公司股东受益。若图迈建立低成本、可靠服务和高频使用的全球安装体系，则耗材和服务可能支持长期现金生

成。当前资料未能验证未来十年更新周期、资本需求或自主技术收费，本章不为这些未知分支额外加值。

## 半年日线形态的历史观察

锁定日线有七百一十一条真实交易历史，终点 2026 年 8 月 31 日，期间三根供应商开高低收逻辑异常已由同日另一来源完整价格栏修复并留记录。价格按锁定名义参考归一的复权方式分析，公司行动另核。停牌前 21.18 港元低于二十日均线 23.494、六十日 23.215、百二十日 25.374 和二百五十日 25.632，距离分别约负 9.85%、负 8.77%、负 16.53%和负 17.37%。这意味着旧交易趋势没有形成多周期均线支持，不能仅因基本面订单消息积极而断言技术上已经完成突破。

均线五交易日斜率中，二十日约正 1.66%，六十日负 0.97%、百二十日负 0.52%、二百五十日约正 0.08%。短均线局部回升与价格仍在其下并存，表示早前反弹留下的滞后效应，不能视作所有周期向上。停牌前二十日价格变化约负 0.38%，六十日约负 13.27%；后者提示较长短线窗口承压。复牌前不存在新增成交去更新均线，时间流逝不会自动把旧股价塑造成新上升趋势。重新观察时需用复牌后真实日线，不把停牌空白补成平价或零成交交易日。

## 支撑 阻力与失效条件

历史最近二十日区间最低 20.52 港元、最高 26.68 港元，离 21.18 参考约负 3.12%及正 25.97%；六十日区间低约 19.72、高 27.42，距离约负 6.89%及正 29.46%。这些是区间极值观察位，未经多次触碰或成交密度验证，不能称为精确支撑和压力。若恢复交易后价格能够在真实成交支持下站上 23.2 至 23.5 附近旧短中均线，并形成回踩不破，才可重新讨论趋势修复；若跌破 20.52 及 19.72，应观察是否伴随业务或核查变化，而不是机械认为历史低位必然托底。

五十二周日线高 35.34、低 18.76，停牌前距高约负 40.07%、距低约正 12.90%，窗口最大回撤约 43.25%。这体现旧交易波动很大，也说明上涨空间的视觉感觉可能来自此前高估值回落。历史高点不是合理价值目标，历史低点也不是最大损失边界。停牌后新信息可能让价格直接越过旧区间，限价和止损在跳空时未必按预想成交。条件经营模型应独立于这些点位，交易判断则要等可交易状态和新价格，二者不能互相循环论证。

## 周线与辅助动量

周线共一百五十二条，二十周均线 24.734、六十周 25.070、百二十周 18.840，二百五十周不足真实历史，留空。旧参考低于前两条、高于百二十周，显示较长上市成长行情与最近调整交织；二十周均线五周斜率约负 4.49%，六十周和百二十周仍分别约正 2.37%和正 1.95%。停牌前最后周不完整，不能拿

其成交与完整周直接判定缩量。周线图提供过去节奏的背景，无法用于预测中报核查结束日期，也不能把长期均线缺失补成推算线。

日线十四期相对强弱指数约 40.02，移动平均收敛发散指标差离值负 0.238、信号 0.054、按两倍差计算柱约负 0.585，辅助说明旧时点动量偏弱；十四日平均真实波幅约 1.418 港元，占参考约 6.69%。周线相对强弱约 43.63，平均真实波幅约 3.332 港元、约 15.73%，同样显示高波动。这些指标取自相近价格序列，不能分别多次加分，也不等于超卖必反弹。停牌情境中的新增信息风险通常大于旧统计波幅，平均真实波幅不是复牌最大跳空范围。

## 量能 换手与相对强弱限制

历史行情供应商的成交量单位仍未完成股与手的跨源核验，模型不发布精确日量比、五二十六十日均量、涨跌日绝对量、成交额或换手率。已有锁表原始计算只作内部保留，不用于声称吸筹、洗盘或主力方向。即使所有日量有一致比例误差，成交量比值可能相对稳定，也要先核交易单位与公司行动，再作结论。复牌首日放量可能来自信息重新定价、被动调整或风险退出，无法仅靠量价确认资金身份。真实逐笔数据未取得，报告不绘制看似精确的成本分布或量价密度。

相对市场比较必须把个股和指数窗口对齐。锁表原始相对强弱把停牌前个股与 10 月 9 日市场窗口相减，本章保留原记录而以锁定恒生指数历史截至 8 月 31 日重算：恒指二十日约负 1.70%、六十日约正 1.24%，机器人分别负 0.38%、负 13.27%，超额约正 1.32 及负 14.51 个百分点。较短窗口略优于市场不抵消较长窗口明显落后。行业细分同日可核基准不足，行业超额留空。这里没有新采行情，所有计算来自同一锁定数据版本，时间对齐比给出更多小数更重要。

## 外资目标价的证据整理

公开可核个股新闻转载中，瑞银 2026 年 4 月 13 日十一时十六分把评级改为买入，目标 35.9 港元，覆盖其 2025 年 8 月旧 21.4 港元；摩根大通 4 月 8 日十时十三分目标 42 港元、增持；花旗 1 月 22 日十一时三十三分目标 32 港元、买入；富瑞 2025 年 9 月 5 日十六时二十二分目标 35 港元、买入。同机构只保留最新合格个股记录，其余作为历史而不重复平均。所有这些是新闻转述而非已取得原始研报，公开页面未明确目标期限，本章不武断标为十二个月，也不据转载自动复制全部估值假设。

瑞银转载预测 2026 净利润 7400 万元、2027 年 3.35 亿元、2028 年 6.07 亿元，并对中等收入市场安装空间给出观点；这些属于投行预测，不是公司已实现结果。摩根大通转载说管理层 2026 收入预期约十一亿元，同时该行预测十四亿元，两个数字均为人民币亿元而非十亿规模混淆。历史目标高于本章基准条件值，一部分可能源于盈利路径、估值方式或资金假设差异，不能只挑最高 42 元作为年底乐观目标。本章未取得原研报模型，不对差异作虚假的精确归因。

研究截止日前九十天或停牌后的公开合格外资个股更新缺失，所以这些旧目标均标为陈旧、停牌前且不适合年底直接使用。停牌及租赁关系核实改变信息集，旧评级是否仍有效需要机构正式更新。目标价数量少且报告时间不同，即便取平均也不是市场一致预期，更不是概率期望。未来若取得新原始研报，应记录发布日期、证券、币种、评级、期限和估值方法，去除转载重复后与本章活动模型逐项比较。年底价必须依年底经营与交易条件重算，不按距年末月份线性缩放机构目标。

## 现金压力 宏观传导与经营反证

从 2025 年末现金 6.36317 亿元做一年压力示意，悲观经营现金流出 1.2 亿元、资本支出 5592.7 万元、融资分类租赁现金 3841.2 万元、示意借款偿还 5355 万元、融资分类利息两千万元，余约 3.48428 亿元；基准经营现金流入八千万元、资本支出两千五百万元时余约 5.79355 亿元。该预算是以旧财报做压力演示，不是 2026 期初或期末真实预测，更不是证明远期都不会缺钱。部分承诺付款、海外备件与未来扩产时间未知，应在中报核实后重新建立逐年资金表。短租已在经营现金，避免双扣。

利率上升对公司有两条渠道：公司融资费用及海外医院融资采购成本可能提高，长期增长价值的折现与合理倍数也可能下降；单看现金存款利息增加不足以抵消。人民币变化影响出口净收入、采购、结算和港元估值换算，但合同币种与成本地点未逐项核验，不能简单认定人民币贬值必利好。模型每人民币 1.1 港元仅估值换算假设，敏感性 0.99 和 1.21 会使同一人民币价值换成港元约相差百分之十；这并不包括经营汇率对售价与毛利的二次影响，更不能当作已核当天外汇现价。

海外经济放缓可能延后医院资本采购，政府预算与医保限制可能抑制机器人使用，跨境政治和监管变化可能增加注册、数据、物流与支付成本。公司多地区布局有分散作用，却也使小市场服务成本更难摊薄。本章没有套用共用宏观乐观结论，而是把影响落在具体系统数量、净售价、耗材使用、销售成本和应收周期。若医院宁愿采购较便宜传统设备，或者使用费无法被支付体系接受，即使机器人临床可用，订单也可能放慢。成功前景需在技术可用、经济可负担和运营可持续三层同时成立。

## 核验路线与最终条件判断

后续第一优先核验正式中报与租赁说明，比较预告与实际收入、毛利、集团和归母利润、经营现金、借款和关联余额；第二优先将订单、终端验收、会计收入与现金回款四条链对齐；第三优先核器械复购与付费服务，判断安装基础是否产生稳定使用；第四优先更新到期债务、扩产和激励融资假设。上述任务都需要真实公开资料，无法用文字长度替代。若事实优于本章基准，可以提高经营输入；若低于，则及时下调，不以保留原目标维护先前判断。研究状态和模型版本在每次正式更新后同步保存。

微创机器人值得持续研究，因为产品商业部署、海外增长和潜在重复收入均有原件支持；它目前不具备正式可执行排名条件，因为交易停牌、当前财报缺失及销售现金质量仍需澄清。最重要的反证已经

明确：可靠财报无法支持预告、关联渠道库存与长账期恶化、终端使用不能形成复购、完整费用和融资压过利润，或技术质量服务问题影响采用。最重要的正证是这些环节在多个正式报告期内共同改善。本章给出的条件数值用于观察经营预期门槛，任何正式收益表都应等新的可交易价格和完整资料再发布。

## 来源与可追溯记录 不计入独立正文字数

核心财务原件：2025 年年报，2026-04-30 16:33 收盘后，HKEX 原件 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0430/2026043000980.pdf。上述利润为物理第 175 页，资产负债第 177 至 178 页，现金流第 181 页，收入与地域第 204 至 205 页，租赁第 218 页，现金调节第 221 页，借款第 224 页，关联交易第 246 页。原文单位人民币千元，正文历史金额人民币百万元或亿元，未来模型十亿元。

2026 中报延迟及停牌公告：2026-09-01 08:56 发布，署期 8 月 31 日，https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0901/2026083103073.pdf。正面盈利预告：2026-07-22 22:31 收盘后，https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0722/2026072201359.pdf。订单公告：2026-06-17 06:06，署期 6 月 16 日，https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0617/2026061700013.pdf。安装公告：2026-06-26 22:38 收盘后，https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0626/2026062602905.pdf。

全流通完成公告：2026-04-23 22:00 收盘后，https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0423/2026042302928.pdf。9 月月报：2026-10-07 16:30 收盘后，https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1007/2026100700642.pdf。其他原件与逐条出版记录保存 data/robot_sources.json。行情及修复记录 data/history/S010.json；对齐恒指 data/history/benchmark_HK_MARKET.json；不重采价格。

外资目标全部为 AASTOCKS 公开二手新闻：瑞银 2026-04-13 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/02252/AAFN/NOW.1517151/research-report；摩根大通 2026-04-08 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/02252/AAFN/NOW.1516185/research-report；花旗 2026-01-22 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/02252/AAFN/NOW.1497932/

research-report；富瑞 2025-09-05 https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/02252/AAFN/NOW.1468456/research-report。均超过近 90 日，不用作年底目标，原研报缺失。

# 英矽智能 03696 HK

03696.HK 参考价 49.00 HKD

暂不排名。完整未融资研发计划2030起资金缺口；未来融资价格、项目退出成本与净权益代价未能自洽核定，压力输出不是2027资产清算或正式目标价。

以下是未融资完整计划的现金压力参考，展示现有资金与完整研发计划的资金缺口，不计算正式推荐分、涨跌幅、含息回报或判断加权期望价。远期资金缺口触发的0值不是近期期望价或清算价。

| 未融资计划期限 | 目标日 | 悲观现金压力参考 | 基准现金压力参考 | 乐观现金压力参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年底 | 2026-12-31 | 17.15 | 26.95 | 42.46 |
| 半年 | 2027-04-09 | 7.35 | 14.70 | 39.19 |
| 一年 | 2027-10-07 | 0.00 | 0.00 | 32.83 |
| 三年 | 2029-10-09 | 0.00 | 0.00 | 40.47 |
| 五年 | 2031-10-09 | 0.00 | 0.00 | 49.86 |

2026年底成立条件：新合作付款/履约慢、量价回落，市场修正对临床前权益估值；三期入组与已签伙伴履约推进，首付款依赖仍在；净权益部分反映；新交易与现有milestones超预期，趋势修复，但不提前确认III读出

半年成立条件：FY2026利润再弱、新交易不续、半年趋势破位，CB兑付保守预算；FY2026证明近端款和研发现金可控，项目预算按基准实现；高质量交易再签、IIa/I验证改善、资金宽裕而临床仍未注册成功

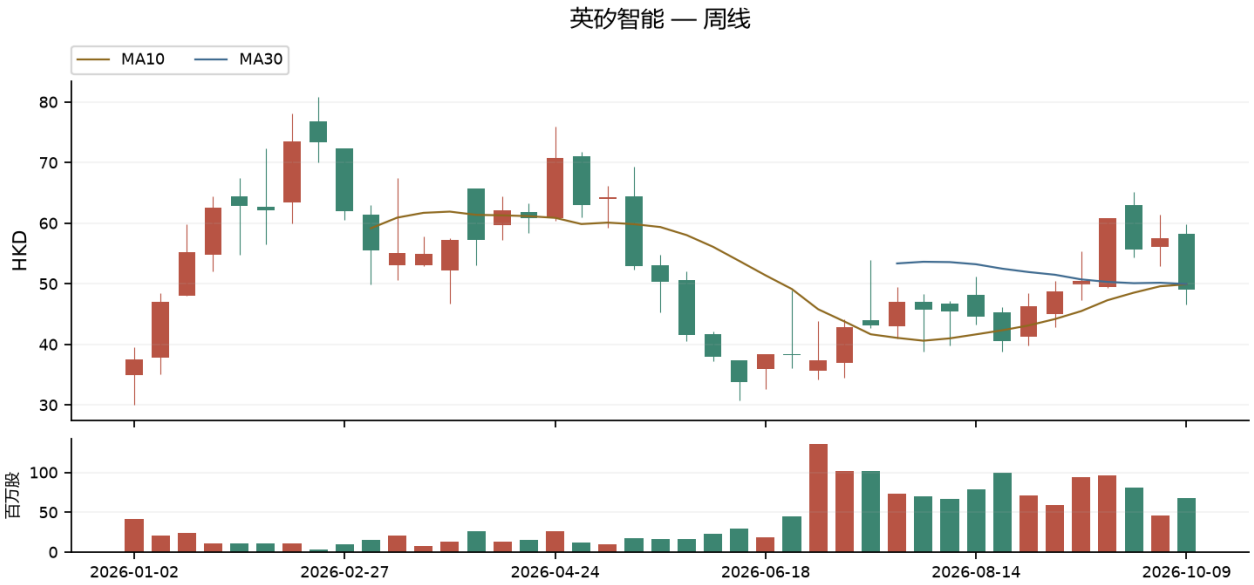
一年成立条件：305mUSD按本金现金偿还，研究现金储备下降，交易收入未形成组合；本金现金偿还后长期未融资预算2030转负；资金压力参考不作正式基准目标；价格及持有人支持全转41.175m新股，免现金赎回但股份稀释已计

三年成立条件：IPF/IBD临床弱，发现合作里程碑取消，有限新融资仍无法满足资金；中国IPF仍招募或临近2029-10-30预计完成，未提前确认读出；UC与TEAD临床证据积累；III有利执行与后续成功预期、其他具名资产证据改善及授权净权益；目标前不虚构III读出

五年成立条件：技术趋同与临床失败、首款间断、投入高形成现金计划失败；中国 IPF 可形成商业现金，早期资产分步转化，平台业务不设永久垄断；多资产商业化与服务规模增长，净收益覆盖研发、分红且员工稀释受控




**日线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量保留原股数。来源及异常修复见行情锁版。**




**周线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量保留原股数。来源及异常修复见行情锁版。**

研究基准为 2026 年 10 月 9 日收盘，发行人 I008、证券 S008、03696.HK，现价 49 港元。财务使用美元，模型金额单位为美元十亿，港元兑美元 7.8 为研究假设；CB 转换独用合同 7.8394。版本 insilico-v3-perIndicationDemand-ConditionalFunding-UnallocatedClinical。2026 中期业绩 8 月

26 日 17:00、完整中报 17:08、CB 定价 8 月 28 日 06:23、完成 9 月 3 日 22:01 及 9 月月报 10 月 7 日 17:00 均留发布时间。资料截止日之后的结果不使用。

正式状态：条件模型、暂不排名。四期限正式目标价、上涨空间、年底三情景和期望价均为空。 原完整研发预算在基准未融资路径 2030 年现金转负，不能据此宣称 2027 现有资产公允价为零。融资价格与未来临床证据、项目退出成本及保留权益还不能自洽核定。以下诊断得分只记录维度观察，资金压力价格只用于复算，不可进入四榜或正式收益预期。

| 期限及目标日 | 诊断分/100 | 正式目标与期望 | 研究状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半年 2027-04-09 | 53.0 | 暂缺 | 条件模型、暂不排名 |
| 一年 2027-10-07 | 57.9 | 暂缺 | 条件模型、暂不排名 |
| 三年 2029-10-09 | 62.4 | 暂缺 | 条件模型、暂不排名 |
| 五年 2031-10-09 | 66.2 | 暂缺 | 条件模型、暂不排名 |

下表为未融资完整计划的条件压力输出，保留原门控算法供核验；悲观/基准长期零值表示该计划资金链不成立，既不代表近期香港股票目标价，也不代表法定清算、现有管线消失或最大损失边界。短期识别系数混合该下界，亦不能被解读为可交易期望。

| 期限 | 压力悲观 HKD | 压力基准 HKD | 压力乐观 HKD | 压力基准数学回报 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半年 | 7.350000 | 14.700000 | 39.194326 | -70.000000% |
| 一年 | 0 | 0 | 32.825970 | -100.000000% |
| 三年 | 0 | 0 | 40.473778 | -100.000000% |
| 五年 | 0 | 0 | 49.860619 | -100.000000% |
| 年底 2026-12-31 | 17.150000 | 26.950000 | 42.455743 | -45.000000% |

原压力 25/50/25 加权年底值 28.376436 港元、数学回报-42.088907%，仅为算法诊断，正式年底期望价为空。三种年底压力分别数学回报-65.000000%、-45.000000%、-13.355626%。40/40/20 与 20/40/40 压力权重得到 26.131149 港元、-46.671125%；31.192297 港元、-36.342251%，不代表统计概率。半

年/一年/三年/五年压力加权分别 18.986081/8.206493/10.118445/12.465155 港元，不作推荐依据。未融资基准三年与五年股息 0，门控数学年化为-100%，此数失去正式估值解释；乐观五年无截止前股息、数学股价回报 1.756365%、年化 0.348879%，仍有成本和专利尾部限制。全部使用本币；人民币投资者另外考虑汇率及费用。

## 一 推荐结论及其成立条件

英矽最有价值的研究线索，是从计算设计走到实验验证、真实授权付款和人体临床。Rentosertib 进入中国三期，发现合作已经带来收入，说明公司拥有可核验的经营活动。股票投资却要求把这些成果转成保留给普通股的净现金，而不是把所有合作总额、所有患者和所有药物数量一并计价。49 港元对应约 36.76 亿美元当前市值，本研究在逐适应症需求和完整开发预算下发现长期资金路径缺口，所以暂缓正式四榜排序。诊断商业质量并不等于目标价完整，更不等于获利概率。

这次修订不再用九个聚合资产组平分峰值。证据登记 67 行，其中 32 个具名适应症或地区建立各自患者、价格、份额、成功率、首商时间和净权益研究输入，35 行真正缺乏指向或净权利映射的项目留零观察。可以研究的资产并非一律没有价值，未能融资的整套计划也不等于公司全部资产必须清算。问题在于，若同时保留当前费用、全部权益和低风险调整收入，公司在后续年度不能持续支付。这要求一个明确的融资或项目选择方案，才能把公司价值转换为普通股每股价值。

未经新增融资的中间预算，2027 收入 1.70 亿美元、归母正常亏损 5814.45 万美元，2029 收入 2.28 亿美元、亏损 1.64305 亿美元；2030 年现金转负。31 个其他适应症并不能在短期提供足额现金，因为大多仍早期，风险销售经过净率和概率调整而开发费用已经发生。将早期概率抬高来消除缺口，会混淆投入与成功。将费用乘成功率来降低现金消耗，则把必须支付的试验款变成事后成本。两种方法均不作为正式基准解决办法。

一笔 2029 年 9 亿美元、每股 30 港元的研究融资可以保全完整预算，但这个价格明显高于同一保守现金模型的内在值。它需要临床成功或市场选择权溢价支持，不能仅因现价 49 便认定三年后能执行。同样，主动外授可以减少后续费用，却通常同时让出未来版税、自销利润或地区权利。缩减 PCC 也会降低资产数量和远期收入。本报告展示这些动作的经济代价并保留未定项，使结论可以随公司新披露更新，而不把不自洽的条件当成推荐。

恢复排名需要的证据是：关键临床数据或合同净权利使需求和成功率可更可靠测算；公司给出能负担的项目优先顺序和研发费用路径；可转债处理与未来融资的价格、股数、费用及时间可以闭合；被转让或停止的资产收益同步移除。此前公司是高成长观察对象，但不拥有本报告可用的正式上涨空间和年底期望。保留暂不排名是模型完整性判断，不是对公司真实短期生存作否定结论。

## 二 发行人 上市历史与股票供给

上市主体 InSilico Medicine Cayman TopCo 为开曼公司，财务报告以美元呈现，股票在香港以港元交易。不同地区研发和商业合作使其具有全球组织特征，但客户地理收入不代表某地已售处方药。代码 3696 与 03696 在香港指同一证券，当前总股数 5.85120194 亿股应用于全公司市值，不能只用某个流通账户或 IPO 发售股数。现价乘总股数约为 286.71 亿港元，按研究汇率约 36.76 亿美元，明显大于当期软件订阅规模。

公司 2025 年 12 月 30 日上市，至截止日只有 192 根实际日线和 41 个周线样本。上市前一拆二十及优先股转换改变了资本结构，历史每股亏损与当前普通股不能直接比较。2025 年加权平均股数仍受上市前结构影响，用那一分母乘现价会严重低估市值。2026 年 6 月末普通股 5.75837982 亿，9 月末 5.85120194 亿，增量包括已经发生的期权行权和受限股发行，应与未来稀释分开。

2026 年 7 月新增期权股份 452.6093 万、受限股 207.2771 万，8 月新增期权 20 万、受限股 4.7264 万，9 月新增期权 238.8859 万、受限股 4.7225 万。六项合计 928.2212 万，恰好解释六月至九月股数增长。模型起点采用九月末股数，这些已发行股份不会在未来再加一遍。相应 7 月至 9 月已收行权款合计 4388.738622 万港元，也作为六月现金起点后的已知融资现金单独计入，不与未来行权收入混用。

9 月末尚余期权 1777.6905 万股。六月财务表期权 2531.4297 万，其中 2165.2345 万当时可行权，不能在九月起点继续全部视为未发行。剩余期权加权行权价未有九月完整分层表，本研究每股 0.92 美元是可修改假设，不能冒充合同新平均价。未来行权时模型同时增加现金与股份，若取消行权，则现金更少而稀释也更少。这个配对在现金紧张时可能改变可持续经营判断，不应只强调其一。

受限股方面，六月未归属上市前计划 263.2553 万股，与会计附注 2019、2021、2022 三组余额合计相同。扣 7 月 165.418 万、8 月 4.7264 万、9 月 4.7225 万实际发行后，剩 88.3884 万。上市后 4 月授予 370.6886 万，7 月已发行 41.8591 万，剩 328.8295 万。未来合计 417.2179 万受限股进入稀释预算。已批准但未授予的计划容量代表潜在授权，不等于当前已发行股票；新增员工权益预算另列，不能把计划上限一次加进现股。

两位 CEO 于 6 月公告延长锁定期至 2027 年 6 月 29 日，这有助于降低特定持股短期出售预期，但不冻结所有股东和激励股份。公告保留现金 less 行权或归属等例外，投资者仍应观察实际发行和交易供给。主席 9 月首批增持 11.35 万股可作为信心线索，相对总股数很小，不能据此推导价格支撑或公司回购规模。5 月对阿布扎比二次上市报道，公司明确尚无具体决定，该事项也没有确定融资收益可以计入。

## 三 商业模式 三种权益路径决定收入质量

公司的药物发现业务至少存在三种不同权益关系。完全自研的项目保留 IP，后续可自销或授权；联合开发可能只保留部分 IP 和经济权益；纯服务项目则由客户持有 IP，公司只获取服务费用。这种区别决定资产价值，而非技术名称决定价值。同一项计算或实验成果若已经收费完成且无保留权利，就不能再给它全球药物销售现值。相反，拥有可许可资产的项目，后续里程碑和版税可以形成持续权益，但研发、监管与销售失败会影响收款。

Pharma.AI 体系包含生物学、化学、临床及科学研究相关工具，平台的实用性在于筛选靶点、设计分子、提出实验和解读资料。发现时间缩短、候选化合物数量提升是公司陈述的效率指标。它们可能降低早期筛选成本，却不等同于人体治疗成功率增加到同样比例。靶点在细胞和动物中有效，仍可能因人体暴露、毒性、疾病异质性、终点选择或竞争药物失败。估值应把早期效率和后期临床成功分别处理。

2025 年药物发现收入 2495.2 万美元，管线开发 2388.5 万美元，软件 491.3 万美元，其他发现 248.9 万美元。2024 年管线开发 7658.9 万美元，显著高于 2025，说明授权收入会随大项目时间波动。2026 上半年发现与管线收入 1.03131 亿美元，软件 269.7 万美元、其他 47.5 万美元。结构显示商业验证已经出现，收入却仍主要来自项目交易，而非大量稳定软件账户。连续增长的论证需要观察多家客户重复合作与付款，不宜用上半年总收入作为订阅年化基数。

客户是否愿意续费和续签，是平台价值的重要证据。软件可以形成低资本的重复收入，但药企也可能采用自建工具或更便宜的基础模型；服务则要求人员、实验和项目管理，毛利较低；许可收入毛利高，但数量和时间不稳定。模型为软件、服务、已签近端和未来新交易分别设收入和毛利率，避免把所有项目按同一高软件毛利解释。不同类型应考察续约率、交付周期、合作成本、权益保留和应收回款，现披露未覆盖的指标明确为缺失。

2026 中报称当时累计产生 33 个 PCC，合作覆盖全球前二十大药企中的多家。PCC 是临床前候选化合物，不等于已批准新药，也不保证每个项目都归英矽。数量指标可以证明发现活跃度，不能直接把 33 乘一个标准药物估值。多个化合物可能共享靶点、适应症和市场，失败也可能具有相关性。本研究以 67 行证据和 32 个活动需求逐项区分，未知合作指向留观察；对应临床费用仍保留在集团未分配预算。

9 月 21 日公司公告与基础模型实验室共同开发生物学模型，合同价值上限为数千万美元，包含收入分享框架。对方名称、净分配比例和具体付款节奏未完整公开，这项业务可以增加长期模型变现路径，但不能被当作截止日已收取的固定大额现金。若未来披露分成，将按英矽净经济和履约费用调整服务或新交易预算，不会同时把合同总金额、全额服务收入及完整销售版税都加进去。

## 四 行业需求 竞争及经济前景

制药研发的困难不仅是设计分子，而是以可接受成本证明治疗获益。许多成熟药企面临专利到期、内部研发效率压力和新产品需求，因此愿意购买有差异化证据的资产。英矽可以通过缩短发现过程取得更多试错机会，并以跨国合作降低部分后续融资压力。行业周期上，授权活跃通常有利于首付款、服务预算和项目估值，但市场融资恢复也会吸引更多竞争者。客户会比较内部平台、学术机构、其他 AI 公司和传统发现团队的成本及最终临床质量。

利率影响两条路径：长期药物权益折现，以及药企和生物科技客户预算。英矽的净现金在利率较高时产生利息，但这不能抵消远期资产价值下降。若融资窗口收窄，早期合作客户可能缩减项目，交易谈判也可能改为低首款、高条件里程碑。若全球资金偏好风险，新增交易和市场识别可能更快，股票可先涨于利润。量价信号与净经济假设应同时观察，不能把宽松市场自动理解成临床成功。

美国客户地域收入占上半年约 90%，其含义是客户分类和合作集中度，而不是美国市场处方药销售。在跨境数据、药物许可、安全审查或知识产权规则改变时，公司可能面临交付和合同限制。花旗 9 月行业转述对常规治疗授权政策较乐观，但那是专家观点和待出台规则，不能作为已经生效的免责条件。英矽还涉及人工智能、生物信息学及实验数据，所受政策可能与普通成品药交易不同。研究将政策视为风险和催化，不假定任何法案或规则一定通过。

人民币工资、实验费用与美元收入形成一定自然汇率错配。人民币贬值可能降低美元计价研发成本，但中国临床、国内药价和基金出资也受人民币变化影响。港元与美元联系汇率使证券币种转换相对稳定，人民币投资者最终回报仍有汇率变化。基本估值使用固定 7.8 港元兑美元，CB 转换股份却用合同 7.8394，二者不能互换。国内 IPF 销售金额虽在美元模型中呈现，仍源于人民币支付与医保价格假设，应通过敏感性而非精确汇率预测解释。

人工智能竞争可能使基础模型能力在三至五年趋同。富瑞公开观点也强调药物资产的重要性超过永久专有模型优势，这与本研究有限平台终值一致。护城河应来自专有实验数据、失败信息、验证体系、药企流程整合和临床资产权益。若先进第三方工具可低成本复制设计过程，纯软件议价权可能下降；若英矽的数据和反馈闭环能显著减少无效实验，平台仍可保持合作吸引力。投资者需检验项目转化和单位经济，而不能用参数规模替代竞争优势。

临床外包、实验自动化与人才成本同样影响行业利润。发现效率上升可能使药企选择更多项目，反而增加后续试验总预算。企业以规模扩张吸收研发人员时，早期合作盈利可能全部投入未来资产。基金投资和国际布局有望获得数据、项目和市场渠道，也会增加资本配置难度。英矽的长线回报取决于能否保留高质量资产净份额、让伙伴承担适当开发费用，以及在资本市场周期低点仍有资金选择权。

## 五 Rentosertib 的临床证据与注册路径

Rentosertib 为口服 TNIK 抑制剂，主要开发方向是特发性肺纤维化。IPF 具有严重、持续进展的疾病负担，现有治疗仍有疗效、耐受性和适用患者限制。新机制若能改善肺功能并保持长期安全性，商业价值可能较大。疾病需求只能证明试验值得进行，不能替代有效性证据。公司获得中国突破性治疗相关资格和美国孤儿药资格，有助于沟通开发路径，均不能解释为上市批准、临床疗效认证或不需要完整注册试验。

2025 年 6 月 3 日 Nature Medicine 原论文的随机 IIa 摘要可直接核验。四组人数分别 18、18、18、17，总 71 人，治疗 12 周。主要终点是至少一次治疗期间不良事件的患者比例，各组 72.2%、83.3%、83.3%、70.6%。60 毫克每日一次组平均 FVC 变化为增加 98.4 毫升，95%区间 10.9 至 185.9；安慰剂减少 20.3 毫升，区间负 116.1 至 75.6。这一 FVC 结果属于次要终点，小样本和短随访使其足以支持更大试验，却不足以确定 52 周注册效果。

对安全性的判断必须包含不利证据。原摘要提到与治疗相关的严重不良事件较低，但导致停药的主要事件包括肝毒性和腹泻。不能只摘取“安全耐受”字样而忽略具体停药因素。三期需要在更多患者、较长用药和复杂合并症环境下验证肝功能、暴露及停药率。如果有效剂量带来更高停药、患者难以持续治疗，即使肺功能平均值有信号，商业使用范围和净价格也可能下降。模型成功率因此低于已获批产品，乐观值也不采用确定性成功。

Nature 完整论文解释 128 为筛选人数，71 被随机分组，55 完成 12 周治疗，16 退出、占随机者 22.5%。新闻 128 不能当作随机疗效分母，原件口径已经澄清。42 名患者的衰老蛋白探索属于更小亚组，可能存在选样、多重分析和疾病改善混杂。生物年龄时钟变化不能证明延长寿命、逆转衰老或支持健康人使用。本模型没有加入独立“长寿药”收入，相关研究仅视为后续可检验假设和合作机会。

2026 年 7 月公司公告启动中国 III 期 GENESIS-IPF-3，9 月 10 日公告首批患者入组并给药。研究计划 320 名患者、47 个登记地点（并非全部已招募）、52 周、随机双盲安慰剂对照，主要终点为 52 周 FVC 年下降率，关键次要终点包括首次疾病进展时间。首例给药是执行进度的证据，不能说明已完成全部招募、剂量优于对照或有中期疗效。半年投资期限更适合观察中心启动、招募、预算和安全性更新，不适合期待一年随访终点已经成熟。

富瑞 9 月会议转述预计 2029 顶线及试验、CMC 约 2 亿元人民币，可作参考而非确定合同预算。直接登记 NCT07687459 的 actualStart 为 2026-09-09，预计主要与整体完成 2029-10-30，晚于三年目标 2029-10-09。注册完成尚非提交、批准和准入，本研究中国口服首商年悲观 2033、中间 2031、乐观

2030。若招募延迟一年或需补充试验，现金消耗和商业现值会同时恶化。成功率不能保持不变而只把上市日期往后挪。

美国口服 IND 在中报明确为公司因研发策略调整主动置为 inactive。富瑞转述美国 II 期招募慢，二者均不足以证明已核监管临床 hold 或确切安全问题。未来海外授权仍需要合作方评估数据是否能支撑当地路径，可能需要新的 IIb 或 III 期。模型的境外口服权益成功率低于中国晚期项目，并延后商业时间，避免中国试验成功立即转换为全世界注册。潜在境外 license 首款和版税属于净权益，不与全自销额同时累计。

吸入 Rentosertib 于 4 月取得 CDEIND，存在局部暴露和耐受性优化的探索价值。该剂型仍早期，不能用动物纤维化数据认定临床优势。吸入与口服覆盖可能重叠，二者不是两个完全独立的全球 IPF 市场。新模型分别列口服中国、美国、其他地区及吸入中国、其他地区；吸入只采用口服不耐受或增量可支付人群，排除口服地址池，不叠两个完整全球 IPF 市场。后续若能证明不同患者群或联合使用，可修订市场拆分；在此之前，新增剂型名称不自动增加完整峰值销售。

临床终点还需区分三个口径。注册 IIa 的 overall study completion 为 59，四组 16/14/13/16；12 周末次 FVC 观测分母合计 49、四组 13/12/10/14，均不同于 Nature55 个治疗完成者。文章 FVC 模型包含 ANCOVA 和在缺失随机假设下的多重插补，不能说所有分析只有 49，也不能把完整随机 71 都当作有有效末次测量。退出若与疗效或不良反应相关，缺失随机的统计假设可能较弱，需要原分析、敏感性及三期证据共同检验。

治疗相关 AE 在安慰剂为 29.4%，60mg 每日一次为 77.8%；60mg 每日一次和 30mg 每日两次各有 6/18 退出。总体 TEAE 与治疗相关 AE、治疗相关严重事件与 CTCAE 三级以上不是同一指标。把“治疗相关严重事件低”写成完全没有严重事件会掩盖风险。短期肺功能信号支持扩大研究，但每日药物的停药、肝功能与腹泻影响长期坚持和净商业人群，故中国晚期项目中间概率 45%仍是研究判断而非注册保证。

三期登记 47 地点中 12 标 RECRUITING、35 标 NOT_YET_RECRUITING，不能说 47 地点全部已经招募。320 为预计人数，52 周为计划随访，登记 2026-09-17 最新公开版本符合截止信息集；读取记录发生于 10 月 11 日，使用的是已于截止前公开版本。公司 7 月称启动与登记实际 9 月 9 日首例需区分。三年投资不能提前纳入 10 月 30 日预计完成后的阳性结果，且预计日期本身可能延迟。美国口服 IND 主动 inactive 也不等于中国试验失效或监管 hold，两地路径独立评估。

原文治疗相关严重 AE 四组为 0/17、1/18、2/18、2/18，不能把相对较低写成全部无严重事件。12 人因 AE 停药，其中 7 人肝损伤或肝功能异常，4/7 伴 nintedanib，提示背景用药和耐受性需进一步评估。文章没有用正式 power 计算确定样本量，次要肺功能即使使用 ITT 和缺失插补仍是探索。98.4 与负

20.3 毫升相减的 118.7 毫升不能写成已充分统计检验的净疗效，各组 95%区间也不是组间差异的区间；更大、更长三期才可能确认治疗获益与风险平衡。

## 六 其他自研临床资产的经济含义

Garutadustat 即 ISM5411，肠道限制 PHD1/2 抑制机制用于 IBD，可能降低全身暴露，却仍面临 JAK、IL23、生物制剂与低价传统药竞争。中报中国 IIa 约 80 名 UC 患者是疾病证据的下一步，未读到有效性结果，也没有把 CD 复制成 UC 同阶段。UC 中国中间可支付人群 30 万、年产品价格 3000 美元、份额 10%，gross 峰值 0.9 亿美元；乘 18%概率、84%净率和 82%毛利才进入风险利润。海外 UC 有单独 55 万人研究需求，13%概率、2036 首商；CD 中间概率 9%、2037 首商，不能仅凭机制给同样注册成功率。

UC 与 CD 是不同疾病诊断，治疗终点、受试人群和维持时间不完全相同。UC 健康人 I 期不能证明内镜缓解、CD 瘘管获益或长期安全，早期患者试验也不支持全部医保人群替代。如果只能作为狭窄辅助治疗，份额和净价格均需下调。反过来，如果公司以清楚对照证明临床、内镜双重缓解和长期耐受，可以提高概率并改善授权选择。失败条件包含无临床益处、剂量安全窗口不足、较多停药与竞争产品压价，不能靠其他候选数量抵消同机制风险。

ISM3412 是 MAT2A 抑制剂，针对 MTAP 缺失的生物标记选择肿瘤人群。I 期首例真实发生，不等于成熟反应率和注册剂量已经确定。中间 2.8 万人、每年 6.5 万美元产品价格、10%份额，gross1.82 亿美元，以 8%概率、40%净率和 2036 首商进入研究。这个池明确排除 GBM，GBM 留给 ISM0387，防止同一 MTAP 缺失患者被两药重复销售。生物标记检测率、可治疗线数、联合用药和既往耐药缩窄市场，范围扩展需要独立人体数据，不给泛癌无限市场。

ISM6331 的 pan-TEAD 方向聚焦不可切除、既往治疗间皮瘤。Fast Track 和孤儿药资格改善监管沟通，但不是客观缓解或长期获益认证。7 月公告 I 期资料被 ESMO2026 接受，10 月 23 日起正式大会在截止后，不使用后来结果。中间 1.3 万人、7.5 万美元年产品价格、18%份额对应 gross1.755 亿美元，11%概率、40%净率、2035 首商。其他实体瘤未有单适应症映射，留零观察。每一临床更新需检查可评价人数、确认反应、持续时间、剂量限制和既往治疗，个案最佳反应不能代替整体试验。

NLRP3 ISM8969 与 Hygtia 各 50%经济权益，脑穿透和健康受试者 I 期不证明帕金森疾病修饰。中间 PD 可支付人群 20 万、1.3 万美元、8%份额得到 gross2.08 亿美元，4.5%概率、65%净率再乘 50%权益；首商 2039 体现 CNS 开发漫长。其他炎症疾病没有明确映射，保留观察。PD 患者异质性、症状安慰剂效应、进展终点和脑暴露均可能使动物机制不能转成疾病获益，共享 50%收益也不能消除现金成本。后续披露应同时给伙伴费用责任与利润分配。

十四个早期活动需求来自具名 PCC 和明确疾病，而非所有 PCC 都估成一款已批准药。两个 GIPR 分子 ISM0676 和 ISM1354 分开，肥胖模型只取假想不同组合细分池；非肥胖 T2D 条目是原公告肥胖相关 T2D 语境外的研究延伸，尚未人体验证。若不能确认非重叠疾病定位，两条 T2D 收益应归零。小鼠减重和灵长类生物标记不能等同人类体重维持、心血管获益或优于现有治疗。多个代谢候选相关性高，不是四个独立成功事件。

ISM0387 以 MTAP 缺失 GBM 池研究，脑暴露与抗瘤动物结果仍远离人体获益，中间成功率 3%并 2030 年代末才预期开发。ISM6200 把 Cushing、特定高皮质醇肥胖和难治青光眼分开，高皮质醇肥胖排除一般 GLP1 池。长期 NR3C1 干预需要评估代谢、内分泌与免疫安全，不能把一种机制在多个疾病的动物作用累加成彼此独立大市场。患者不足和药价竞争会限制早期项目收入，研发路径不明确时应延后或取消相关需求，而不是自动加适应症。

ISM9528 术后疼痛用短疗程每患者价格，不按全年慢性服药计价；神经病理疼痛是独立慢病研究池，排除急性疗程重复。同类镇痛药需要验证患者报告终点、安全、依赖性及医保支付，动物痛觉实验不能证明临床替代。ISM9077 干性 AMD、葡萄膜炎和干眼分别估窄患者池，眼内暴露不等于视力改善；干眼巨大患病率不全是高价处方地址市场。ISM0900 高 Lp(a)风险池需要事件获益证据，灵长类指标下降不证明十年心血管终点。

这些活动的患者数都只是中国及潜在海外可支付细分合计，除明确 CN/US/OTHER 外尚未逐地区建立报销、注册、价格与专利路径。首商年 2039 至 2045 并不自动产生新 20 年保护期，晚启动会损失现有专利余期。平台同时持有若干潜力分子可以提高谈判选择，但资本配置应集中在有证据、高净权益与可负担投入的资产。未来停止哪项、外授哪区、让伙伴承担哪些费用都必须同步削减收益和概率，不用降低费用同时保留全部管线的方法提高目标。

## 七 许可资产与合作合同的去重

Exelixis 获得 ISM3091 及相关 USP1 化合物全球独家许可，原招股书有中个位数至低十几百分比分层版税与历史付款。新研究对 HRD/BRCA 选择耐药池使用 5.5%/8.5%/12%研究费率，既不称确切合同每级费率，也不把合作方全球销售当英矽营收。历史收到的首款和里程碑已在历史现金，不再次进入未来资产。剩余未知开发、监管付款在逐药模型为零，不从 headline 总额任意拆分。

KAT6 ISM5043 是 Stemline 许可，明确聚焦 ER 阳性、HER2 阴性难治市场。1200 万美元历史首款、分阶段费用责任和中个位数至低双位数版税范围在原件，精确 tier 仍缺。本研究 5.5%/9%/12.5%仅为范围内研究输入。ISM9682 即 MEN2501、KIF18A，是另一药和另一许可路径，2026 年首次人体相关 3900 万

港元里程碑不属于KAT6。临床首次给药不能直接提高注册概率到晚期水平，两个靶点的风险和时间分别处理。

QPCTL ISM8207由复星共同开发，原件一期费用以及全部利润损失各50%，II期之后另议，不能写成普通5%至12%版税。模型用收益乘50%并保留集团完整未分配临床预算，是透明保守代理而非完整项目joint-profit净成本桥。ISM5939的ENPP1为自研，IND后择时启动，未见许可；指向或适应症不明条目留观察，不塞进已许可净版税组。伙伴名称与靶点不能替代权利文件。

Lilly2026年3月首付款1.15亿美元、总潜在约27.5亿美元和分层版税，体现真实技术输出与潜在长期价值。首款与H1收入确认并非同一时点，合同履约递延会影响利润和现金。模型从六月真实现金起步，全年经济预算减H1已发生8525.5万美元，不在H2再加完整1.15亿美元。大额首款提高一期现金，而未来是否持续取得此规模交易依然不确定，不能以一单乘未来每年当稳定订阅收入。

Servier首款与近端最高3200万美元、SK最高1800万美元、Takeda约6000万美元分别包含不同履约和条件里程碑。潜在8.88亿、25亿、6亿美元不是确定应收。未名目标和地区尚不明的合同登记为零观察，SignedNear只给条件近端预算，不另加完整未来药物销售。NewDeals是尚未签约的新发现项目收费研究，排除已有具名管线销售和版税；未来发现了明确同一项目，就要替换预算并删除已售权益，防止首款、管线现金和未来交易三重计价。

大中华ISM4808由TaiGen独占，境外自留，故分为GC版税与exGC净权益；不能把大中华自销利润留在公司。Qilu、CMS、Tenacia等多疾病合作分别留证据，但精确分子或适应症不足不强行分摊。Bora7月15日为框架安排，正式协议待签，不能把潜在超过25亿美元当已签付款权利。9月基础模型实验室合同有数千万美元上限和分享框架，未名伙伴、净份额与付款节奏仍未完备，不等于当期固定应收。

对许可价值的复核还包括地域、产品和期限。USP1版税期取首商10年、有效compound claim、监管独占三者较晚，不是统一到2042停止。KAT6期满可royalty-free，但原页未给可完整映射的term长度，本研究把尾部到期列敏感性，不编确切日期。后续仲裁、专利无效、销售审计和费用抵扣均可能改变净收款。许可资产更轻资本的优势真实存在，只有把净权利、费用和期限制约同时保留才能解释普通股收益。

## 八 财务表现 利润质量与现金结构

公司2022至2025年收入分别3014.7万、5118.0万、8583.4万、5623.9万美元，2025下降34.5%。高毛利授权收入随签约和履约阶段大幅波动，较低收入年份并不自动证明平台失效，较高年份也不证明稳定盈利。2025研发8137.9万美元，仍高于总收入，经营现金流负7676.6万美元。2024经营现金流负5740.1万美元，说明现金消耗持续，不能只用会计净亏损判断资金跑道。

2025 净亏损 3.52316 亿美元，其中优先股公允价值损失 2.96701 亿美元为主要非现金项，IPO 时优先股转换为普通股。研究不能把这部分非现金重估认作每年现金研发支出，也不能因此忽略真实经营亏损。经调整亏损 4383.4 万美元，加回股权薪酬和上市费用，但这是补充财务指标，不是股东可拿走的现金。2024 相应调整亏损 2266.5 万美元，2025 经营表现并未因会计结构改善而自动变强。

2026 上半年收入 1.06303 亿美元、毛利 9596.5 万美元，毛利率约 90.3%，归母利润 3553.7 万美元，调整利润 5122.7 万美元。研发 4932.8 万美元、销售 636.5 万美元、行政 1257.7 万美元，其他收入 886.2 万美元中银行利息 778.1 万美元。利润转正的重要来源是高毛利交易和利息，不是处方药组合稳定商业销售。完整分析应把未来交易间断、研发扩张和利率下降同时纳入，避免以上半年盈利乘二再套成熟药企 PE。

H1 股权薪酬总 1569 万美元，费用明细销售 227 万、研发 845.3 万、行政 496.7 万相加可核。某附注“其他员工”1427.3 万美元未含全部董事部分，不能用它替代集团总股权薪酬。现金模型将 SBC 加回，与未来已授和新授股份稀释配对，持续员工激励不是没有成本。若实际激励费用和股份更高，则每股药物价值会下降，即使损益调整利润看起来更高。发行股数和股票报酬应形成一套互相核对的记录。

六月现金 3.57617 亿美元，三个月以上定存 1.0895 亿美元，货币基金 1.08338 亿美元，另有当期上市股 991.3 万美元、非当期上市股 69.3 万美元和未上市股 440.4 万美元。公司宣传现金及短投 5.84818 亿美元包含当期股权投资，不能全部视为保本、随时可用的现金。研究资金桥分现金、定存和 MMF，金融股权 1501 万美元仅按终末折价回收，不把它当确定研发支付来源。MMF 可短期赎回仍有净值风险，定存提前动用也可能损失利息。

六月银行本金 1468.2 万美元、租赁负债 497.4 万美元，应收净 446.6 万美元，合同负债 2918.4 万美元。合同负债代表已收款但未完成服务，不能再当未来可收现金。营运资金预算必须包含后续收入确认和履约支出，否则首付款先增加现金，收入随后确认时又增加一次现金。模型通过全年经济现金预算减 H1 实际经济现金 8525.5 万美元，避免把上半年交易收款再计入后半年，NWC 单列作为未来递延和回款时间差研究。

H1 经营现金流 7898.5 万美元，另有投资分类银行利息现金 575.2 万美元、MMF 收益 68.4 万美元，融资分类支付利息 16.6 万美元，形成经济现金 8525.5 万美元。全年预算扣这一已发生额，使用现金付出的 PPE93.2 万美元作为资本支出锚，会计资产新增 75.2 万美元不替代实际现金。租赁本金已付 79.6 万美元从全年预算扣除，ROU 折旧加回、租息保留在利润、现金租赁本金另扣，避免租赁费用少算或重复。

## 九 可转债和基金投资的现金影响

公司 9 月完成发行 3.05 亿美元零息可转债，净款 3.016 亿美元，期限约至 2027 年 9 月 1 日。零息不等于免费资本，340 万美元发行费用降低净所得，还可能出现稀释、赎回和价格调整。债券本金现金与负债同时入表，本模型以六月现金为起点，在 H2 加净款且加本金负债，费用已反映净款，不再单扣一次。若用债券现金改善跑道却不记录偿还或转股，股东价值会被严重高估。

初始转换价 58.07 港元，合同固定换算 7.8394 港元兑美元，全部转换可产生约 4117.4737 万股。合同按整股处理，模型用十亿股连续数近似与公告仅有不足一股差异。可转股由持有人选择，现价 49 低于初价，不能假定到期必然转换。发行人特定提前赎回还涉及经过六个月、连续交易日价格阈值等条件，普通股上涨超过转换价并不自动证明全部条件满足。本研究悲观和基准现金偿还本金，乐观假设全部转换并计新股。

未经新增融资的中间预算 2026 年末现金 7.16002015 亿美元，2027 年末 4.46025555 亿美元，2028 年末 2.97400947 亿美元，2029 年末 1.27895971 亿美元，2030 年末负 5985.66302 万美元，2031 年末负 2.35890974 亿美元。负现金只是计划缺口，不是银行账户真实余额；实际企业在用尽现金前会寻求融资、缩减或出售项目，若做不到才可能发生持续经营风险。模型不能跨越负现金年度仍把后期现金视为已实现。

9 月 1 日偿债事件另按年度非债现金均匀代理插值，而非用年末最小替代。中间事件现金约 4.34319057 亿美元；26 年最小却为负 8.95074151 亿美元，来自更远期研发，二者不能混成 2027 到期已无钱偿还。悲观/中间本金偿还，乐观全部转股并计 4117 万新股。所有事件都以研究年度现金代理，未有逐月支出和合同收款，所以即使事件代理为正，也不等于逐日流动性或法律 solvency 测试通过。

乐观转股免去本金支付却带来股份，不能保留无稀释分母。中间全转敏感性最低现金仍负 5.57425747 亿美元，说明当前 CB 处理不能独自解决全部远期预算。取消基金出资、平台研发减 20%或新交易增 50%也各有缺口，不能只挑一项改善就宣布长期路径安全。保全所有权益的融资需要更多现金和更多股份；项目授权则必须让出权益。对资金问题的解决方案必须从经营动作建立，不能把任意融资价格作为模型自动补丁。

8 月 18 日基金公告提出合计约 3.055 亿元人民币出资安排，包括 300 万元合资公司和 3.025 亿元基金，基金目标规模 10.1 亿元。截止日尚无确定协议，不能把全部基金规模视为英矽持有资产或全部现金义务。基准模型约 4300 万美元分两年投入，作为可修改研究预算并终末 65%回收，不当当前已签资本承诺。若基金不成立，现金裕度改善；若实际出资更大或投资流动性差，现金储备和资本配置风险增大。

## 逐资产证据登记摘要 不计正文有效汉字

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM001055_IPF_ORAL_CN | ISM001-055 / Rentosertib | 特发性肺纤维化（IPF） | 中国 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19,20 |
| ISM001055_IPF_ORAL_US | ISM001-055 / Rentosertib | IPF | 美国 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 17 |
| ISM001055_IPF_ORAL_OTHER | ISM001-055 / Rentosertib | IPF | 美国及中国以外 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19,20 |
| ISM001055_IPF_INH_CN | ISM001-055 / Rentosertib | IPF | 中国 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 276 |
| ISM001055_IPF_INH_OTHER | ISM001-055 / Rentosertib | IPF | 中国以外 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20,21 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM001055_KIDNEY_EXPLORATORY | ISM001-055 / Rentosertib | 肾纤维化探索 | 未明确 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 17 |
| ISM5411_UC_CN | ISM5411 / Garutadustat | 溃疡性结肠炎（UC） | 中国 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 21 |
| ISM5411_UC_OTHER | ISM5411 / Garutadustat | UC | 中国以外 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 21 |
| ISM5411_CD | ISM5411 / Garutadustat | 克罗恩病（CD） | Global 定性；逐地区未明 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 277 |
| ISM3412_MTAP | ISM3412 | MTAP 缺失癌症 | 全球多中心；FDA IND | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19,21 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM6331_MESO | ISM6331 | 晚期或转移性恶性间皮瘤 | 中美全球多中心 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19,22 |
| ISM6331_SOLID | ISM6331 | 其他晚期或转移性实体瘤 | 中美全球多中心 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19,22 |
| ISM8969_PD | ISM8969 / HT-001 | 帕金森病 | 全球 50%rights；澳 I、FDA/CDE IND | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 22,23 |
| ISM8969_OBESE_CVD | ISM8969 / HT-001 | 肥胖且有心血管疾病风险成人试验人群 | 全球 50%rights；澳 I、FDA/CDE IND | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 22,23 |
| ISM8969_NEURO_OTHER | ISM8969 / HT-001 | 其他神经退行性疾病未分配 | 全球 50%rights；澳 I、FDA/CDE IND | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 22,23 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM8969_METAB_OTHER | ISM8969 / HT-001 | 其他代谢疾病未分配 | 全球 50%rights；澳 I、FDA/CDE IND | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 22,23 |
| ISM8969_ACUTE_INFLAM | ISM8969 / HT-001 | 急性炎症疾病未分配 | 全球 50%rights；澳 I、FDA/CDE IND | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 22,23 |
| ISM3091_HRD | ISM3091 | 同源重组 DNA 修复缺陷/BRCA 突变癌症 | Exelixis 全球独占许可 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 15,16,279,281 |
| ISM5043_ERPOS_HER2NEG | ISM5043 | ER+/HER2−乳腺癌 | Stemline 全球独占许可 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 16,285,286 |
| ISM9682_CIN_SOLID | ISM9682 / MEN2501 | 染色体不稳定实体瘤 | Stemline 全球独占许可 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 17 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM8207_SOLID | ISM8207 | 晚期/转移性实体瘤 | 中国 I；50/50 全球管线 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 18,284,293 |
| ISM8207_BCELL | ISM8207 | 复发/难治 B 细胞淋巴恶性肿瘤 | 中国 I；50/50 全球管线 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 18,284,293 |
| ISM5939_CANCER | ISM5939 | 癌症（具体癌种未分配） | 美国 FDA IND；Global 定性 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 288 |
| ISM4808_CKD_GC | ISM4808 | 慢性肾病相关贫血 | 大中华；TaiGen 独占 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0306/2026030600082.pdf) 页 1 |
| ISM4808_CKD_EXGC | ISM4808 | CKD 相关贫血 | 大中华以外 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,21 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM0676_OBESITY | ISM0676 | 肥胖 | Global 定性；具体地区待核 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM0676_T2D | ISM0676 | 2 型糖尿病 | Global 定性；具体地区待核 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM0676_CV_HF | ISM0676 | 肥胖相关心血管疾病（包括心衰）探索 | Global 定性；具体地区待核 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM1354_OBESITY | ISM1354 | 肥胖 | 未明确具体地域 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0930/2026093000283.pdf) 页 1 |
| ISM1354_T2D | ISM1354 | 2 型糖尿病 | 未明确具体地域 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0930/2026093000283.pdf) 页 1 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM1354_CV | ISM1354 | 心血管疾病扩展探索 | 未明确具体地域 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0930/2026093000283.pdf) 页 1 |
| ISM0387_MTAP_OTHER | ISM0387 | MTAP 缺失癌症（其他癌种未分配） | 未逐地区核实；UAE 发现 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM0387_GBM | ISM0387 | MTAP 缺失胶质母细胞瘤 | 未逐地区核实；UAE 发现 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM6200_CUSHING | ISM6200 | 库欣综合征 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM6200_HYPERCORT_OBESITY | ISM6200 | 高皮质醇相关肥胖 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM6200_GLAUCOMA | ISM6200 | 青光眼 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM6200_ONCO_COMBO | ISM6200 | 肿瘤联合治疗（具体癌种未分配） | 未逐地区核实 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM6166_KRAS | ISM6166 | KRAS 异常实体瘤 | 未逐地区核实 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM5059_AUTO_INFLAM | ISM5059 | 自身免疫及炎症疾病（具体病未分配） | 未逐地区核实 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| ISM5059_METAB | ISM5059 | 代谢疾病（具体病未分配） | 未逐地区核实 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM5059_CV | ISM5059 | 心血管疾病（具体病未分配） | 未逐地区核实 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| ISM5059_OPHTH | ISM5059 | 眼科疾病（具体病未分配） | 未逐地区核实 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| ISM9528_POSTSURGICAL | ISM9528 | 急性术后疼痛 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| ISM9528_NEUROPATHIC | ISM9528 | 神经病理性疼痛 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| ISM9077_DRY_AMD | ISM9077 | 干性年龄相关黄斑变性 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM9077_UVEITIS | ISM9077 | 葡萄膜炎 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| ISM9077_DRYEYE | ISM9077 | 干眼病 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| ISM0900_LPA_CV RISK | ISM0900 | Lp(a)升高相关心血管风险 | 未逐地区核实 | research-rNPV | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| NAV18_ACUTE_G C | UNDISCLOSED_N AV1_8 | 急性疼痛 | 大中华 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| NAV18_ACUTE_E XGC | UNDISCLOSED_N AV1_8 | 急性疼痛 | 大中华以外 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV18_CHRONIC_GC | UNDISCLOSED_NAV1_8 | 慢性疼痛 | 大中华 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| NAV18_CHRONIC_EXGC | UNDISCLOSED_NAV1_8 | 慢性疼痛 | 大中华以外 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,20 |
| UN_GLP1R_OBS | UNDISCLOSED_GLP1R | 代谢疾病（具体病未分配） | 未逐行视觉核实；不得推 Global 完整权益 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| ISM3830_OBS | ISM3830 | 免疫肿瘤（具体癌种未分配） | 未逐行视觉核实；不得推 Global 完整权益 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| UN_VAV1_OBS | UNDISCLOSED_VAV1 | 炎症疾病（具体病未分配） | 未逐行视觉核实；不得推 Global 完整权益 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| UN_APJ_OBS | UNDISCLOSED_APJ | 肥胖及代谢疾病（具体病未分配） | 未逐行视觉核实；不得推 Global 完整权益 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf) 页 18,19 |
| LILLY_2026_LICENSED_UNNAMED | UNDISCLOSED_LILLY_LICENSED_2026 | 未公开特定适应症；潜在新口服药 | Lilly 全球独占 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0329/2026032900717.pdf) 页 1 |
| LILLY_2026_DISCOVERY_UNALLOCATED | UNDISCLOSED_LILLY_DISCOVERY_2026 | 多个 R&D 项目，Lilly 选择靶点，适应症未公开 | 协议全球范围；个体地域未分配 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0329/2026032900717.pdf) 页 1 |
| SERVIER_2026_ONCOLOGY_UNALLOCATED | UNDISCLOSED_SERVIER_ONCOLOGY | 挑战性肿瘤靶点，新疗法（具体癌种未公开） | Servier 后续全球商业化 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0105/2026010500029.pdf) 页 1,2 |
| SK_2026_NEUROIMMUNE_UNALLOCATED | UNDISCLOSED_SK_NEUROIMMUNE | CNS 神经免疫疾病（具体病未公开） | 未明确独占地域；后续伙伴商业化 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0622/2026062200389.pdf) 页 1 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAKEDA_2026_DISCOVERY_UNALLOCATED | UNDISCLOSED_TAKEDA_DISCOVERY | Takeda 治疗领域内目标；未给具体适应症 | 入选候选给予 Takeda 全球 exclusive | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0702/2026070200115.pdf) 页 1 |
| QILU_2026_CARDIOMETAB_UNALLOCATED | UNDISCLOSED_QILU_CARDIOMETABOLIC | 心血管及代谢病管理；具体靶点/疾病未公开 | 未公开确切地域 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0127/2026012700069.pdf) 页 1 |
| CMS_2026FEB_CNS_AUTOIMMUNE_UNALLOCATED | UNDISCLOSED_CMS_FEB_MULTIPROJECT | CNS 及自身免疫病（至少 2 研发项目，未具名） | 未公开 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0210/2026021000075.pdf) 页 1 |
| CMS_2026JUL_CNS_ADDITIONAL | UNDISCLOSED_CMS_JUL_ADDITIONAL | CNS 疾病（新增合作，具体病未公开） | 未公开 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0713/2026071300017.pdf) 页 1 |
| TENACIA_2026_ADDITIONAL_CNS | UNDISCLOSED_TENACIA_ADDITIONAL | 挑战性神经系统疾病（新增候选） | 未公开 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0326/2026032600101.pdf) 页 1 |

| 独立 ID | 药物/合同 | 适应症 | 地区 | 模型处理 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| BORA_2026_FRAMEWORK_ONLY | UNDISCLOSED_BORA_FRAMEWORK | 多靶点联盟，具体药物与疾病未公开 | 待正式合同 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0715/2026071500065.pdf) 页 1 |
| FOSUN_LEGACY_DISCOVERY_UNALLOCATED | UNDISCLOSED_FOSUN_DISCOVERY_LEGACY | 至多四个选择靶点发现项目；非 QPCTL 药本体 | 合同发现合作；区域未逐项目核 | zero-observation | [原件](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800031.pdf) 页 18,293 |

## 32 活动需求中间假设 研究值 非公司指引

| ID | 可支付患者 | 产品 USD 价 | 份额 | gross USD 十亿 | 概率 | 净率 | 权益 | 毛利 | 首商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM001055_IPF_ORAL_CN | 120000 | 5500 | 0.25 | 0.165000 | 0.45 | 0.88 | 1 | 0.82 | 2031 |
| ISM001055_IPF_ORAL_US | 110000 | 38000 | 0.16 | 0.668800 | 0.18 | 0.32 | 1 | 0.88 | 2035 |
| ISM001055_IPF_ORAL_OTHER | 140000 | 27000 | 0.12 | 0.453600 | 0.16 | 0.32 | 1 | 0.88 | 2036 |
| ISM001055_IPF_INH_CN | 25000 | 7500 | 0.17 | 0.031875 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.76 | 2035 |

| ID | 可支付患者 | 产品 USD 价 | 份额 | gross USD 十亿 | 概率 | 净率 | 权益 | 毛利 | 首商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM001055_IPF_INH_OTHER | 50000 | 33000 | 0.14 | 0.231000 | 0.08 | 0.28 | 1 | 0.84 | 2037 |
| ISM5411_UC_CN | 300000 | 3000 | 0.1 | 0.090000 | 0.18 | 0.84 | 1 | 0.82 | 2034 |
| ISM5411_UC_OTHER | 550000 | 22000 | 0.08 | 0.968000 | 0.13 | 0.34 | 1 | 0.88 | 2036 |
| ISM5411_CD | 300000 | 18000 | 0.065 | 0.351000 | 0.09 | 0.34 | 1 | 0.87 | 2037 |
| ISM3412_MTAP | 28000 | 65000 | 0.1 | 0.182000 | 0.08 | 0.4 | 1 | 0.87 | 2036 |
| ISM6331_MESO | 13000 | 75000 | 0.18 | 0.175500 | 0.11 | 0.4 | 1 | 0.87 | 2035 |
| ISM8969_PD | 200000 | 13000 | 0.08 | 0.208000 | 0.045 | 0.65 | 0.5 | 0.83 | 2039 |
| ISM3091_HRD | 38000 | 80000 | 0.1 | 0.304000 | 0.075 | 0.085 | 1 | 0.94 | 2036 |
| ISM5043_ERPOS_HER2NEG | 65000 | 65000 | 0.07 | 0.295750 | 0.075 | 0.09 | 1 | 0.93 | 2036 |
| ISM9682_CIN_SOLID | 40000 | 70000 | 0.09 | 0.252000 | 0.065 | 0.08 | 1 | 0.94 | 2037 |
| ISM8207_SOLID | 45000 | 65000 | 0.07 | 0.204750 | 0.065 | 0.6 | 0.5 | 0.82 | 2037 |
| ISM8207_BCELL | 17000 | 65000 | 0.09 | 0.099450 | 0.05 | 0.6 | 0.5 | 0.82 | 2038 |
| ISM4808_CKD_GC | 250000 | 1100 | 0.07 | 0.019250 | 0.1 | 0.08 | 1 | 0.94 | 2036 |

| ID | 可支付患者 | 产品 USD 价 | 份额 | gross USD 十亿 | 概率 | 净率 | 权益 | 毛利 | 首商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM4808_CKD_EXGC | 250000 | 4500 | 0.05 | 0.056250 | 0.065 | 0.33 | 1 | 0.87 | 2039 |
| ISM0676_OBESITY | 220000 | 3500 | 0.06 | 0.046200 | 0.06 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2039 |
| ISM1354_OBESITY | 280000 | 4000 | 0.06 | 0.067200 | 0.06 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2040 |
| ISM0676_T2D | 150000 | 2800 | 0.05 | 0.021000 | 0.05 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2040 |
| ISM1354_T2D | 180000 | 3000 | 0.05 | 0.027000 | 0.05 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2041 |
| ISM0387_GBM | 10000 | 60000 | 0.09 | 0.054000 | 0.03 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2040 |
| ISM6200_CUSHING | 6500 | 45000 | 0.12 | 0.035100 | 0.06 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2040 |
| ISM6200_HYPERCORT_OBESITY | 55000 | 3500 | 0.06 | 0.011550 | 0.045 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2041 |
| ISM6200_GLAUCOMA | 55000 | 1800 | 0.06 | 0.005940 | 0.045 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2041 |
| ISM9528_POSTSURGICAL | 900000 | 140 | 0.07 | 0.008820 | 0.06 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2040 |
| ISM9528_NEUROPATHIC | 350000 | 2800 | 0.07 | 0.068600 | 0.05 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2041 |

| ID | 可支付患者 | 产品 USD 价 | 份额 | gross USD 十亿 | 概率 | 净率 | 权益 | 毛利 | 首商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM9077_DRY_AMD | 90000 | 6500 | 0.07 | 0.040950 | 0.04 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2041 |
| ISM9077_UVEITIS | 45000 | 5000 | 0.07 | 0.015750 | 0.045 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2041 |
| ISM9077_DRYEYE | 450000 | 900 | 0.06 | 0.024300 | 0.045 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2041 |
| ISM0900_LPA_CVRISK | 230000 | 4200 | 0.06 | 0.057960 | 0.045 | 0.33 | 1 | 0.85 | 2042 |

## 十 估值模型 参数和合理范围

活动模型联结四类收入、67 行证据、32 活动需求、临床和平台研发、营运资本、现金债务、融资激励及分配。2026 至 2051 为有限 26 年研究，2036 后核心新交易与对应费用退坡，不给永久平台终值。2051 现金回收只含已形成现金、未赎回存款和 MMF、折价金融权益与基金净值，扣余债；不加目标时点现金第二次。自销与版税分别用净率、毛利和权益，股息按各年稀释股份折算。这个桥的优势是每项输入都能追到最终现金，限制是实际经营管理尚未完整模拟。

独立峰销公式为患者数乘产品价格乘份额再除十亿。患者不是核验患病率，价格是可支付渠道的研究实现价，份额含竞争及可用人群限制。风险净收入再乘临床概率、净收入率和公司权益，自留产品毛利扣生产成本，许可版税毛利仅反映有限服务费用而非全额制造；增量销售费用另扣。自有 ownership1 依据自研或全资关系，是研究假设而非无负担商业权利证明。Hygtia 和 Fosun50%有原件，但公司共同开发费用未能逐药拆净，集团全成本保留。所有数值与证据身份分开，不能把模型推导写成公司披露。

BIO2011 至 2020 总体一期至批准 7.9%只作阶段统计参考。本研究概率不是逐资产实证获批率，也不把小鼠疗效映成一期概率。晚期中国 IPF 中间 45%含安全主要 IIa、退出和缺失惩罚；美国口服 18%、其他口服 16%、吸入中国 10%、境外 8%体现独立路径。早期 CNS、肿瘤和 PCC 更低。相同分子共享安全、CMC 和机制失败风险；各地区概率是边际研究权重，未作为独立联合成功事件。各药的 0.04 至 1.0 爬坡曲线同样只是商业执行研究，不是处方预测保证。

原九组全部临床费用总额移入未分配 clinicalUnallocated，没有删减。2026 至 2032 悲观 0.038/0.070/0.090/0.083/0.069/0.045/0.029，中间 0.043/0.088/0.141/0.172/0.186/0.166/0.125，乐观 0.052/0.120/0.210/0.288/0.352/0.364/0.299 美元十亿，后续按增长及退坡。单药 clinical0 仅避免捏造分配，不代表零成本；活动 32 项也不证明该预算足够开发。2027 起费用+30%和+100%必须保持药物收益不变做压力，不只改全为零的单药费用空表。

原完整预算的 26 年临床总额悲/中/乐 0.585243/2.422369/6.985759 美元十亿。2027 起增加 30%为 0.749416/3.136180/9.065887，增加 100%为 1.132487/4.801739/13.919518。+30%连乐观最低现金也降至负 0.262528 美元十亿，+100%为负 1.646809，三个路径都触发资金失败。这里不把失败后价格 0 当正式目标，但该实验说明当前乐观财务支撑依赖成本。如果实际预算更高，必须重新选择项目、追加融资或扩大净权益，不能仍沿用原乐观上涨空间。

原未融资压力最低现金悲观负 0.701660、中间负 0.895074、乐观 0.204234 美元十亿。资金门控在任何年度低于 2500 万美元就把整计划内在下界置 0，此算法可检测一个预定计划不闭合，却不足以给现有公司公允价值。公司有缩开发、授权、出售平台、额外融资和清算等不同选择，价值与股数会变。本版本官方 scenarios 和 scores 为空，raw 条件输出保存独立字段，避免父总表把 0 和短期混合值误当可用推荐价格。没有自洽动作桥之前，也不人为提高失败概率或换模型来得到正价。

条件融资实验一为 2029 一次毛 9 亿美元、每股 30 港元，3%发行费用后净 8.73 亿美元、新股 2.34 亿，约当前股数 40%。保留原费用和全部权益，最低现金 0.083503 美元十亿，一年/三年/五年内在 0.431243/0.556020/0.716155 港元。发行价 30 远高于这些现金值，必须由未来临床证据或市场对选择权的额外估值支撑，不能由本保守模型证明可执行。因此此方案明确不作正式中间情景，亦不据它生成正式年底期望。

条件融资实验二为 2029 毛 4 亿美元以 25 港元及 2032 毛 5 亿美元以 20 港元，净款同为 8.73 亿美元，新股 3.198 亿、约现股 54.7%。分期减少提前持有资金，却较低价格增加稀释，最低现金 0.040256 美元十亿，一年/三年/五年内在 0.344229/0.443829/0.571652。每一发行价格仍需对应当期证据和市场窗口，年末正现金也不证明款在低现金日前到账。额外费用、限价、股东批准和持股上限都会改变可行性。本模型不对尚未公布融资给成功概率，也不把潜在融资所得作为无成本股东收益。

保持全成本的净权益敏感性，让 retained 和 licensedRoyalty 原收益分别乘 0、50%、100%。这指原权益收益乘数，Fosun 和 Hygtia 原 50%乘 100%仍为 50%，不是公司绝对全持股。乐观一年 retained 三档 0/17.707383/32.825970，五年 0/26.896420/49.860619 港元；许可档一年 31.742197/32.284084/32.825970。自研净权益是主要价值来源，许可费率小变化相对较小，费用预算

却不因让权自动消失。实际授权若同时转移开发费用，可另建真实双方净现金桥，不能单独调整收入乘数代替。

专利原件可核范围有限：美国 Rentosertib kinase/method2040-02-20、analog2042-02-23，台湾 method2040-02-24；QPCTL 美国 compound2042-06-23、USP1 美国及欧亚 2042-11-11、PHD5411 美国 2042-10-28、MAT2A 美国 2042-10-19。其他 20 活动未在 material 表列明不等于无专利，申请中也没有可自动编的到期。美国日期不能当全球期限，剂型或新用途申请不等于已授新保护。晚商业开始不能按上市年再享 20 年固定收益，USP1 合同至少首商十年等较晚条件也不能机械截 2042。

活动 cashEnd2051 只代表有限经济测试上限，不宣称专利、监管独占或版税延至该年。尾部实验全部药物至 2042 硬截是保守日历压力，非法律到期统一事实；乐观一年从 32.825970 降 24.725966、五年从 49.860619 降 37.557213。每项只计首商起五年现金的压力，乐观一年 9.641254、五年 14.644468；全部原费用保留。KAT6 期满 royalty-free 而确切期限未取到，需再研究地区 term。该差距揭示长尾保护和支付持续性影响远期值，不能把尾部成长当无条件资产。

软件中间 2027 收入 800 万美元、2031 为 2900 万，服务分别 3500 万、9000 万；已签近端 2027 为 5700 万，新交易 7000 万、2031 为 1.6 亿美元。未来新交易是条件预测，不是已经签妥合同。折现率 17%/13.5%/11%也为经营风险研究，不能把精确小数当市场要求。短期识别比例年底 65/45/35%、半年 85/70/55%保留供条件压力复算，既不保证收敛也不代替公司年度估值。全面深研发现正式融资桥缺失后，短期算法期望应暂停使用，避免数学正确但经济解释错误。

## 十一 半年日线 周线与关键价位

49 港元位于 20 日均线 55.4745 下方约 11.67%，略高 60 日 48.7143 与 120 日 48.6925 约 0.59%和 0.63%。20 日和 60 日近五日斜率为正，120 日略向下，显示前期反弹尚未形成统一长周期上升。均线位置不是独立三项买入理由，20 日与 60 日重叠信息不能重复加分。由于样本不足 250 日，本报告不补 250 日均线，也不把没有真实历史的长期趋势描述为已确认。

过去 20 日股价回报约负 9.09%，60 日约负 0.04%，120 日约负 19.41%。这说明近期高位回落显著，60 日整体更接近震荡。全上市真实历史高 80.90、低 29.98，最大回撤约 57.22%，并不是完整 52 周区间。现价距历史高仍很远，不能以“回落很多”证明便宜，历史高可能反映过度溢价。较短历史的低点也不是稳定估值地板，IPO 供给、交易热度与融资都改变价格结构。

近期 20 日低点 46.60 港元，距现价下方约 4.90%；60 日低点 38.76，距离约 20.90%；20 至 60 日关键高点 65.20，距现价上方约 33.06%。这些是观察水平，不是精确支撑或阻力的承诺。若在 46.60 附近缩量

稳定并重新站上 55.47，短线修复判断增强；若放量跌破 46.60 且随后反弹无力，则 48 至 49 均线拥挤区失效，需重新观察 38.76 一带而不是机械抄底。

65.20 向上突破需要量能、收盘保持和相对强弱共同支持。单日盘中穿越可能源于高波动，不能被当作持续突破。若成交量显著超过 20 日均量且连续收于关键位上方，同时 20 日相对行业强弱转正，可提高半年技术分。若突破后很快回落 55 附近且下跌成交强，则应撤销突破判断。技术条件与基本面条件同时满足才可提高推荐，不以某个形态名称替代计算和可见价位。

周线 20 周均线 45.2675，现价高约 8.25%，但近段斜率仍下降约 2.99%，说明日线反弹与周线趋势尚有分歧。周 ATR 约 9.9276 港元、相对现价 20.26%，单周波动可以覆盖多个所谓支撑。只有 41 周历史，60 周及 120 周均线不可得。技术分析应承认新股供应和资金变化造成的不稳定性，而不能从不足一年资料推导多年周期底部或精确长期趋势。

半年观察可分为三个证据状态：46.60 至 55.47 内为回踩与震荡候选，需要成交和收盘确认；55.47 上方恢复且相对强弱改善，才有向 65.20 挑战的依据；46.60 下方持续，则技术风险提高。价位应随新数据滚动更新，报告的固定截止日不能自动成为半年实时交易信号。若公司公告临床或合作重大变化，应先更新经济价值，再判断技术失效，不用固定止损线覆盖所有事件风险。

## 十二 成交量 相对强弱与辅助指标

截止日成交 1625.4644 万股，成交额约 7.8319 亿港元。成交量单位为股，不是手，香港交易批量不能直接代替股数。5、20、60 日均量分别 1358.6194 万、1573.9755 万、1542.2761 万股，当日对 20 日量比约 1.03，属于接近常态的成交。没有明显超常量支持强突破，亦不能因单日量比稍高就认定资金长期增仓。股数稀释和流通结构变化还会改变同量对应的交易压力。

近 20 日上涨日累计成交 1.49697 亿股，下跌日 1.65098 亿，8 个上涨日和 12 个下跌日，二者量比约 0.907。这个对照显示回落并非完全无量，但没有逐笔成交、账户持仓和主动方向数据，不能声称“主力吸筹”或“出货已结束”。价格上涨日也可能有卖盘，下跌日也可能有承接。这里把成交作为趋势强度的辅助证据，不把日 K 成交柱解释成特定机构行为。

20 日相对恒生指数约落后 6.11 个百分点，60 日约领先 3.15 个百分点。近期表现弱于市场而中期稍强，支持震荡回落判断。对创新药 987018 基准的 20 日相对约负 9.97 个百分点，60 日正 3.18 个百分点，但该行业指数只有官方单源、成交量不适用，不能用于精确交易量比。它是较粗医药参照，AIDD 公司的风险与指数成分不同，行业比较只用于识别资金环境，不证明同等估值。

RSI 约 43.61，处于中性偏弱而非极端超卖。MACD 线 0.8096、信号 2.1586、柱差负 2.6979，显示前期上行动能减弱。ATR4.1861 港元、8.54%，说明一天常见价格范围已较大。三个指标都依赖相同价格序列，不能作为三份独立利好或利空证据。半年评分把趋势、量能和相对表现综合为 2.5 分，不因加入更多相近技术参数提高可信度。

若采用仓位预算，应以可承受的金额波动和流动性计算，而非仅看上涨目标百分比。8.54%日 ATR 意味着较小技术止损可能在正常震荡中被触发，事件缺口也可能超过止损线。用户本计划未指定资金规模和交易执行，本报告提供观察与失效条件，不预设杠杆仓位。进取型研究可以接受高波动，但前提是上涨空间有净经济依据，而现阶段正式资金与目标模型尚未闭合是主要限制。

行情已用腾讯与新浪现价、Yahoo 日线及腾讯复权日线核对，来源和抓取时间留档。股票上市期间的公司行动、股份增长与价格复权须区别：新增激励股不会按拆股规则补造历史价格，上市前一拆二十属于资本结构变化。日线与周线以全部真实样本计算，支撑阻力使用实际高低，缺失换手率或逐笔量不凭空填入。以后输入修改，应重新算技术表并保存版本，不能把旧图与新现价混用。

## 十三 外资投行目标价与本研究的差异

富瑞 9 月 24 日公开转述维持买入、目标 100 港元；JPM9 月 21 日维持增持、71 港元；花旗 9 月 9 日维持买入高风险、85 港元；汇丰 9 月 9 日买入、84.5 港元。均为可核验新闻转述，未取得原始完整机构研报。相对 49 分别隐含较大上涨，但不能据此估计市场获利概率。同机构旧报道已经去重，领域讨论没有专属价的文章不会凑目标。原报告未来期限不明的项目保留缺失，不统一称 12 个月。

JPM71 明确基于 2027 年 12 月 SOTP，发现业务与软件其他分别采用 17.5 和 8.9 倍 EV/S，公开文字称隐含 2027 约 19 倍 PS。它的目标时点晚于本计划一年实际 2027 年 10 月 7 日，也晚于 2026 年底。本研究不按剩余月份线性缩放 71。不同 EV/S 框架可能给予平台持续交易和管线选择权较大溢价，本有限现金分配框架则要求研发、权益、临床和资金在净现金中兑现，两者存在方法差异，不能把一个目标机械作为另一个模型校准值。

富瑞强调药物资产重要性超过永久模型优势，仍给 100 港元。花旗 DCF 维持 85，探索衰老蛋白证据被视为额外合作可能，但公开转述同样指出小型数据和非注册终点。汇丰 84.5 来自行业管理层交流，并强调管线与 TNIK 进度。三者所需全套峰值、成功率、开发费用、税和未来融资假设未公开，无法完整复算。这里逐条保存原日期、币种、评级和来源，让读者看到方向而非伪造一致预期模型。

研究与投行公开目标差异明显，应同时展示方法和缺失。机构 71 至 100 港元代表各自平台倍数、管线及现金选择权判断，本报告未融资压力门控不能与这些正常持续经营目标直接当同口径价差。已核原件支持临床身份和付款，不提供全套机构成功率、逐药峰值、费用与融资模型，因此不能声称投行全

采用本研究乐观路径，也不能用其高价校准现金值。当前正式目标为空，机构目标作为独立可核新闻参照保留，等待经济自洽的资金动作桥。

若后续真实授权把临床成本转移给伙伴，或主要注册数据显著改善成功率，现金模型可能提高；若平台具备独立可出售的持续服务价值，也要依据交易和利润验证，而非永久软件倍数。外部投行更高目标显示不同风险承受和选择权估值，但不证明哪边一定交易正确。本版本把未融资下界与自洽目标区分，就是为了避免读者将很低压力数值解释成做空目标，或将机构高目标解释成确定上涨。

## 十四 四期限投资逻辑 催化和失败路径

半年的核心是FY2026真实收入和现金、现有合作履约、临床执行、可转债市场预期，以及日线能否恢复20日均线。不是III期注册性结果提前公布。若持续首付款和近端收入足以覆盖新增研发，市场可保持平台溢价并改善趋势；若年报利润低、递延履约支出高、量价破位，股价可能较快回归低净值。53.0诊断分反映行业与催化较好，但估值和近期技术条件不足，不能只因AI题材热门提高半年推荐。

一年的重要差异是债券在目标日前到期。现金还本与转股会直接影响流动性和总股数，持续发现收入则决定研发计划是否需要另融资。目标时点基准亏损仍存在，成熟PE没有意义。可核验催化包括多伙伴milestone、IBDIIa与肿瘤I期数据、国内IPF三期招募，以及真实订单和收入净份额。若只是签更多巨大潜在交易而实际收款不增，推荐不会上调；若成本与合作分担比模型更好，则应重算基准。

三年接近Rentosertib中国注册预计主要完成前，资产风险可能发生离散变化。明确阳性数据可提高成功率、降低后续风险并改善授权条款，但监管申报、生产、准入仍需时间。阴性或安全性问题会冲击中国与境外TNIK权益，并可能影响平台品牌。其他IBD、MAT2A、TEAD和NLRP3项目能否提供独立人体证据，将决定公司是否依赖一个核心项目。62.4诊断分允许成长观察，却不因资产数量就认为失败风险已经充分分散。

五年基准中国IPF形成初步商业经济，其他项目仍分阶段推进。净版税可比自销更节省商业资本，软件和服务可以缓冲药物周期，持续新交易则可能填研发资金。失败路径包括旧平台优势减弱、疗效不足、适应症竞争、支付价格低、全球合作权利净比低于假设、激励稀释和融资价格差。66.2诊断分代表较好的经营选择权，现价购买仍需要较乐观结果。本研究把业务质量与收益预期分别评分，评分不是赚钱概率。

10年展望到2036，应检验英矽能否成为有多项产品净收益的研发组织。未经融资中间预算此时收入约4.239260亿美元、正常亏损约7271.527万美元，仍是研究假设，要求多个项目按阶段成功并持续扩大服务。真正持续性来自药企认可、高质量数据、人才和资本配置，而不是一直保有最先进基础模型。

若公司只有短期首款而没有后续 milestone 或产品净收益，十年商业质量判断应大幅下调，长期持有也不自动平滑亏损。

一年诊断 57.9 分不是在全部公司中的名次。技术和已核临床可独立打分，估值与融资缺失却使最终排序无法合理比较。半年重点 FY2026 真实净款、年末负债、47 中心实际启动与量价修复；一年重点 2027-09-01 兑债后的可用现金、权利交易和预算调整；三年重点在 2029-10-09 尚未注册预计完成的试验执行及融资；五年重点批准、准入、续费和净版税。这四种观察避免把同一临床催化复制成四期确定收益。

长期经营仍有积极路线：提高数据闭环质量、从单次发现变成重复合作，保留少数高净权益项目并让伙伴承担可承担的后续风险。失败路线则包括早期工具议价权下降、项目投入分散、症状或生物标记不能变成患者获益、政策限制跨境合作、融资在低价发行稀释或不得不出售高价值地区。十年持有不能自动解决这些资本配置问题，也不因周期长就给高确定性评分。若有三至五个项目不断净收款及稳健投入比例，长期质量可以重新评价；若只是偶发首款，长期研发组织现金仍可能紧张。

## 十五 反证清单 研究限制与更新规则

推荐的正面反证是现金预算被真实数据显著改善：现有合作方承担临床费用高于模型、全年新增交易净款超出预算且没有重复保留 IP、软件续约和规模增长、注册终点显示明确获益，以及债券转换或可承受再融资后每股净价值提升。负面反证包括合作终止、收款延后、关键安全性信号、临床招募明显慢、商业竞争压价、全球权利不完整和持续激励超预算。所有证据需直接进入对应参数，不能只改变文字评级。

模型资金失败状态是有限研究计划低于 2500 万美元储备的结果，不是法定破产测试。开曼母公司与研发、商业实体的可分配储备、债务限制及资金转移未逐一审计，2030 开始 50%利润分配和 1.5 亿美元储备是保守研究代理。公司可通过项目出售、缩减研发、合作融资或股权融资改变路径，这些措施也改变未来权益和稀释。若实施，必须先建立可核验新的资金与项目组合，再给相应价格，不能设置无限免费救助。

估值最不确定的输入是后续临床成本、成功率、峰值净销售和持续新交易质量。它们之间存在相关性，三情景并不是统计独立样本。技术指标在短期可观测，却不能决定多年资产现金。资料缺失包括九月剩余期权逐份行权价、全部合作净费率与付款节奏、服务续约、逐项目研发预算和完整机构研报；缺失没有用市场目标价回填。研究截止严格限制到 10 月 9，正式 ESMO 结果及后来公告只能在未来版本更新。

Excel 使用单套活动模型，依次选择悲观、基准、乐观重算并保存快照。金融资产、债券和股份输入改变后，旧快照需要刷新，正文亦应同步。条件压力价格按输出除 49 减一算数学回报，正式目标缺失时不填上涨空间，研究股息单列，三与五年含分红年化按真实目标日计算。主体 I008 与证券 S008 保持分开，便于以后新增市场上市时共享基本面、分别比较股价和股份权利，不把同公司当两家不同长期资产。

最终结论是公司拥有可核验临床和授权业务，值得完整保留研究，但现价 49 港元下正式资金与逐项目调整路径仍未闭合，因此暂不排名。未来更新先修复经营动作、费用、权利及股数，再刷新三种情景、正式目标和得分，不依据表格要求填入看似精确价格。年度资料、临床证据与融资条款能支持时，可恢复可比估值；此前年底正式期望为空，原条件压力保留供审阅和复算，不作为交易结论。

## 来源与核验附录

- HKEX 英矽 2026 中报，2026-08-26 17:08：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0826/2026082600542.pdf

- HKEX2025 年报，2026-04-28 20:00：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0428/2026042803625.pdf

- HKEX2026 年 9 月月报，2026-10-07 17:00：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1007/2026100701100.pdf

- HKEX 可转债定价与完成，2026-08-28 与 09-03：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0828/2026082800033.pdf；https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0903/2026090302431.pdf

- Nature Medicine 原 IIa 随机试验，2025-06-03：https://www.nature.com/articles/s41591-025-03743-2

- JPM71 目标 2027 年 12 月的公开转述：https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/03696/AAFN/NOW.1545526/research-report

- Jefferies100 公开转述：https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/03696/AAFN/NOW.1546233/research-report

- Citi85 公开转述：https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/03696/AAFN/NOW.1543625/research-report

- HSBC84.5公开转述：https://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/03696/AAFN/NOW.1543616/research-report

公司公告、IPO及合作原文目录保留62项来源。正文不含长引用；目录、表格、图注和来源不纳入有效汉字验收。日线、周线和相对指数源存档于统一行情库，模型、敏感性与核验记录按版本保存。

# 开拓药业 B 09939 HK

09939.HK 参考价 1.64 HKD

暂不排名。2025 年度审计无法表示意见；2026 中报明确持续经营重大不确定性未消，融资、欠款与临床/商业化成败互相影响，无法形成与正常公司可比的正式推荐分或期望价

以下仅是融资、存续或复牌条件成立后的估值参考，不计算正式推荐分、涨跌幅、含息回报或判断加权期望价。

| 条件参考期限 | 目标日 | 悲观参考价 | 基准参考价 | 乐观参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年底 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.44 | 4.60 |
| 半年 | 2027-04-09 | 0.00 | 0.54 | 4.96 |
| 一年 | 2027-10-07 | 0.00 | 0.86 | 5.32 |
| 三年 | 2029-10-09 | 0.00 | 1.31 | 5.79 |
| 五年 | 2031-10-09 | 0.00 | 1.37 | 5.16 |

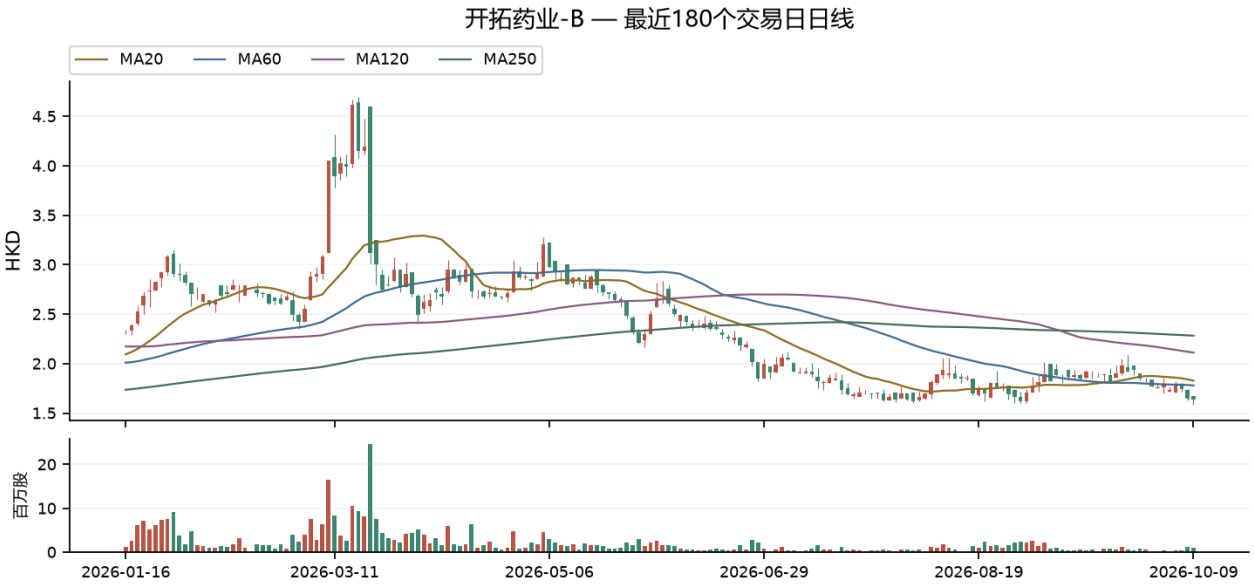
2026 年底成立条件：融资困难/延迟审批/营销现金亏损，未必能实现存续假设；成功及时融资、股数稀释如表且中国核心数据通过审评，其他适应症按阶段折价；充分资金和 CMC/审批/商业执行改善，仍非所有管线成功，不能假定无需新股

半年成立条件：融资困难/延迟审批/营销现金亏损，未必能实现存续假设；成功及时融资、股数稀释如表且中国核心数据通过审评，其他适应症按阶段折价；充分资金和 CMC/审批/商业执行改善，仍非所有管线成功，不能假定无需新股

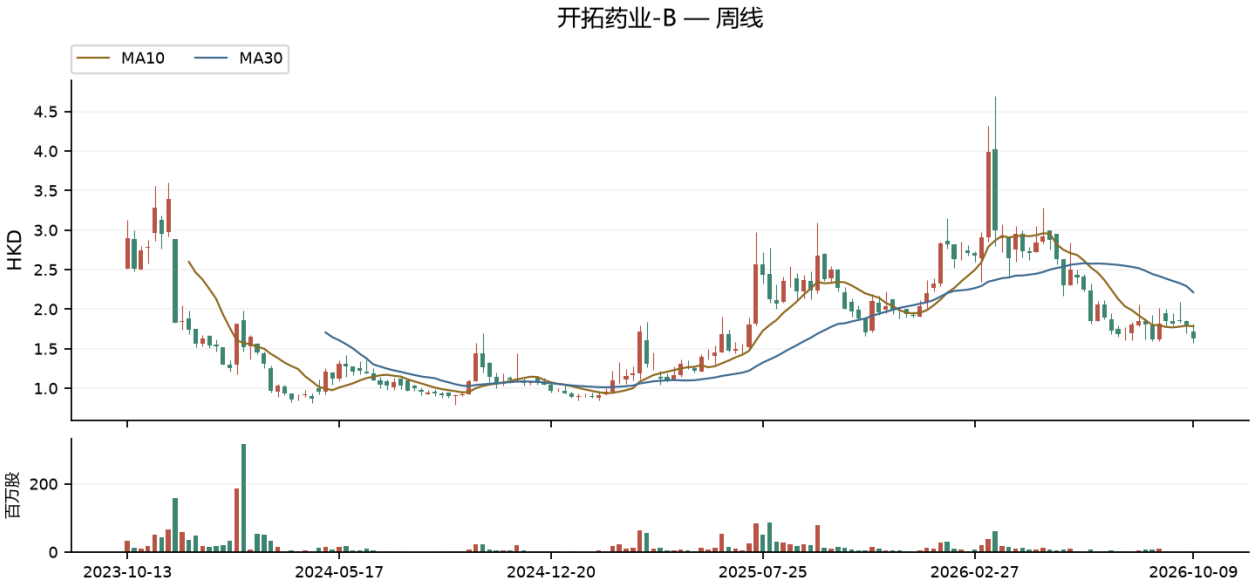
一年成立条件：融资困难/延迟审批/营销现金亏损，未必能实现存续假设；成功及时融资、股数稀释如表且中国核心数据通过审评，其他适应症按阶段折价；充分资金和 CMC/审批/商业执行改善，仍非所有管线成功，不能假定无需新股

三年成立条件：融资困难/延迟审批/营销现金亏损，未必能实现存续假设；成功及时融资、股数稀释如表且中国核心数据通过审评，其他适应症按阶段折价；充分资金和 CMC/审批/商业执行改善，仍非所有管线成功，不能假定无需新股

五年成立条件：融资困难/延迟审批/营销现金亏损，未必能实现存续假设；成功及时融资、股数稀释如表且中国核心数据通过审评，其他适应症按阶段折价；充分资金和 CMC/审批/商业执行改善，仍非所有管线成功，不能假定无需新股




**日线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量保留原股数。来源及异常修复见行情锁版。**




**周线：真实 OHLC 按基准日尺度复权。成交量保留原股数。来源及异常修复见行情锁版。**

发行人 I038；证券 S045；09939.HK；锁定 2026 年 10 月 9 日收盘 1.635 港元，market-v1.6。财务 CNY；条件模型 kintor-conditional-finite-risk-FCFF-v1.0。暂不排名，四期限没有正式分数、正式目标或年底期望价，原因是持续经营重大不确定性未消。下表仅表示融资和后续开发条件成立的研究敏感值，不是交易推荐，不能纳入正常排名或期望收益。无已宣布股息。

| 期限 | 悲观/基准/乐观融资条件参考值，HKD |
| --- | --- |
| 2026 年底 | 0 /0.437 /4.603 |
| 半年 2027-04-09 | 0 /0.539 /4.965 |
| 一年 2027-10-07 | 0 /0.865 /5.324 |
| 三年 2029-10-09 | 0 /1.311 /5.789 |
| 五年 2031-10-09 | 0 /1.373 /5.162 |

## 投资结论

开拓药业应保留在研究覆盖中，但目前不适合放入与成熟盈利公司同口径的推荐排名。二〇二六年三月 KX-826 中国男性脱发III期达到主要终点，是需要认真评价的临床进展；与此同时，二〇二五年审计无法表示意见，二〇二六年中报仍明确持续经营重大不确定性，现金、债务、逾期应付款和融资依赖未解决。这两条证据不能互相抵消。进取型研究可以承认药物未来潜力，同时要求上市股东能够在资金链不中断和可接受稀释下分享潜力。临床数据漂亮不等股票已经可按无融资约束估值，公司继续经营也不等每股价值必然增长。

本章不填零分来代表暂不排名，也不把财务风险藏在一个略低风险分里。正式评分为空，正式情景与年底期望为空，条件价值另列，原因和重启条件明确可追溯。条件基准年底约零点四四港元、乐观约四点六〇，幅度很大，正说明售价、审批、现金和稀释的联合作用。悲观原始股权值为负后按普通股经济价值下限零显示，不表示预测一定归零，更不是给出可在该价格成交的目标。为了维持研究完整性，业务、财务、量价、各期限和十年持续性仍逐项分析，不以停留在风险提示替代研究工作。

恢复正常推荐评估需要融资实际到账、到期债务续期或偿还可核、供应商逾期款得到合理安排，以及新药申报和审评证据更成熟。若这些条件未满足，任何多年现金流模型都可能在开始兑现之前失效。董事认为持续经营编制恰当，是基于一组措施及现金预测，附注同时指出措施存在重大不确定性；不能只摘第一句话。审计师更替也不能自动解除原审计问题。研究在此刻最有价值的任务，是将可核进展和未兑现假设分开，并展示普通股在融资后的实际经济权益如何变化。

## 业务转向与两套商业模式

公司传统定位是临床阶段创新药开发商，现时重点转向皮科及功能性化妆品。核心 KX-826 是外用雄激素受体拮抗剂，GT20029 是外用 AR-PROTAC 化合物；KT-939 则是酪氨酸酶抑制型化妆品新原料，不能写

成已获批创新药。其他临床分子包括 GT1708F、GT0486 和 ALK-1 抗体 GT90001。不同分子对应的科学风险、注册路径、研发时间和商业渠道均不同，不能统一乘同一个“创新药成功率”。公司称具有潜在同类首创或最佳属性，属于开发定位，只有适当的临床和商业证据才能确认竞争优势。

现有收入主要来自 KOSHINÉ 化妆品和原料销售，半年五千二百零四万元，比去年同期五百九十八万四千大幅增长。收入已经超过二〇二五全年三千二百六十八万二千，但这一增长起点很低，不能用百分之七百多的速度外推多年。药物尚未获批成为成熟销售来源，现阶段电商化妆品收入和未来药物收入应分开模型。化妆品可帮助建立渠道和消费者认知，亦可带来现金；它不能替代药品注册、处方规则、适用人群、医保和质量体系要求，更不能让所有药物研究费用自动被现有商业规模覆盖。

外包化妆品制造降低了自建产能的前期负担，却使采购质量、供应商稳定和退货管理重要。公司以抖音为主、多平台协同，另包括天猫、京东、小红书、美国亚马逊及自营渠道。直播销售能迅速放大流量，也可能通过投放和折扣买来销量。对普通股股东，需要看商品毛利之后扣平台、推广、退货和团队费用是否仍产生现金。本期销售费用超过全部收入，说明热销榜单还不能证明盈利商业模式。排名第一属于特定平台、品类与时段，不等整体市场份额第一或品牌能永久获得低获客成本。

公司称复购率提升且高于行业平均，但没有在取得的公开原件中找到完整口径、具体数值、客户队列和比较样本。它可以作为管理解释保留，不能写成已独立核验的客户黏性数据。长期复购需要持续有效的产品体验、合理定价和合规宣传；单次大促成交可能包含折扣、首购补贴或重复下单，不能全部视为新长期消费者。若后续能披露自然流量比例、不同获客批次复购及净收款，这些将比单日销售榜更能检验产品质量。本章既不否认商业起步，也不将未取得的数据补造成稳定品牌护城河。

## KX 826 中国Ⅲ期的具体证据

三月十八日公告的中国成年男性 AGA 研究为多中心、随机、双盲、赋形剂对照，采用Ⅱ/Ⅲ期操作无缝设计。Ⅲ期阶段二十六个中心、六百六十六名患者、二十四周治疗和十四日安全观察，比较百分之一和百分之零点五每日两次剂量与对照。设计比单臂用户体验有更强比较能力，随机与盲法有助降低偏差；投资者仍需注意完整统计方案、主要终点定义、缺失数据处理和多重比较调整。公司公布顶线及会议展示，不等取得全部患者级数据，本章以公告数字作为证据，不冒充独立重新分析。

百分之一组非毳毛目标区域毛发数较基线增加每平方厘米十五点三三根，百分之零点五组十四点四六，赋形剂组四点六八。因此对照调整后的增量为十点六五和九点七八，均报告显著性小于万分之一。将十五点三三全部称作药物相对安慰剂作用会夸大疗效，必须同时展示对照组改善。两个剂量差距不大，提示后续剂量选择不能只看名义浓度，需综合有效性、耐受、暴露和长期依从性。统计显著说明试验内差异可信度提高，不自动等同所有患者拥有肉眼可见的相同改善。

毛发计数是一项客观指标，但患者关心外观、密度、满意度以及持续使用后的效果。二十四周结果对初始疗效有意义，对多年使用的维持、停药后变化和真实世界依从性仍需证据。每日两次外用可能避免系统治疗的一部分负担，却需要规律执行；若患者因麻烦、费用或效果预期而中止，商业复购就会低于临床完成者所提示的水平。价格模型必须反映实际支付和维持治疗人群，而不是把所有脱发人数都视为长期付费用户。临床结果加强潜力，并没有完成从试验到可持续收入的所有步骤。

公告称未观察到与药物相关严重不良事件，各组不良事件无临床显著差异，这对申请有利。未观察到并不证明所有长期、罕见或更广泛人群风险为零，尤其试验样本和随访长度有限。公司披露低经皮吸收和低活性代谢产物是降低系统暴露的设计逻辑，实际人体安全性仍须用数据和监管评估确认。其他长期安全研究可增加证据，但不应把没有死亡病例当作适合所有人和无限期使用的保证。估值成功率必须保留审评、CMC 及后续风险，不能因一项III期显著就直接设百分之百。

中报计划二〇二六下半年正式提交 NDA、预期二〇二七下半年获批，截至截止日取得资料没有核到已经正式提交、受理或批准的完整公告。管理计划必须明确标为计划，不能将未来年份自动写成已确定收入起点。本章基准将中国男性药物商业收入放在二〇二八，乐观二〇二七，悲观二〇二九，显示不同审评与启动节奏。提交后仍可能被要求补充临床、生产、稳定性或质量材料，批准后也需供应和营销执行。若资金不足导致申报准备或商业化延误，积极数据不能单独挽救现金时间表。

## KX 其他适应症与组合 不要跨试验抬高效果

美国男性脱发和中国女性脱发已完成 II 期，科学方向与中国男性相近，但地区注册和人群不同，不能共享中国男性III期成功率。美国临床中的基线比较也不能未经核验视为与安慰剂相同的效果比较。女性 AGA 的病理、治疗选择、安全关注和用药习惯可能不同，需适当人群和终点支持。模型分列美国男性、中国女性及中国痤疮现金流，给较低阶段折价；这些分支如果因资金限制无法推进，其价值应再减，而不是因为主药已经有一项成功就自然全部上市。

KX-826 痤疮 II 期约一百六十患者、多个剂量和每日一次或两次组，披露在第十二周取得 IGA 治疗成功者来自实验组。它还报告基线非炎性病变较多亚组的事后分析改善。事后亚组可提出后续研究假设，不能与预设主要终点成功等同，尤其多个剂量、不同病变和小样本会增加探索性解释空间。本章对这一适应症保留低于中国男性脱发的条件成功率，未给它成熟药物估值。痤疮既有治疗众多，新药需证明有效、安全、合适定位和支付价值，而非仅因同一受体在疾病中有作用即可获得市场。

与米诺地尔联合的临床观察研究可探索不同机制叠加，但观察研究不等随机、盲法对照的确证证据。联合后若总效果改善，需要区分基础药贡献、患者选择和治疗依从性，不能把全部疗效归给 KX-826。公司计划后续 Ib/III 期，未核其已完成，本章没有单独给联合疗法再加一份完整脱发患者市场，以免

同一个患者同时被算为单药和联用两次。联用可能提高产品价值，也可能增加成本、用药复杂度和监管工作，只有合适研究与实际使用能决定净商业影响。

## GT20029 与 PROTAC 平台

GT20029 采用蛋白降解方式干预 AR，和占据受体的拮抗药不同，有潜力形成不同给药频率和作用特征。平台科学前沿性有意义，但前沿不等更高确定性或直接商业溢价。中国 I 期九十二名健康受试者、美国 I 期一百二十三名健康及患者受试者，低系统暴露和耐受结果支持后续研究。健康人安全与短期患者暴露不能替代长期有效性；外用药也可能有局部反应、处方稳定和制造问题。模型保留研发支出，未将平台冠以无限可复制的资产价值。

中国男性脱发 II a 期一百八十名、十二中心、十二周，含每日一次及每周两次队列。百分之零点五每日组毛发计数较基线增加十六点八，较安慰剂增加六点六九；百分之一每周两次较基线十一点九四、较安慰剂七点三六，报告显著性小于百分之五。给药频率差异值得关注，较低频率若能维持疗效或提高依从性有商业意义。但这些数字来自不同分组和较短随访，不能直接与 KX-826 二十四周III期对比排名，更不能得出一定更强。后续 II b/III 期的剂量和持续效果是关键验证。

试验未观察到性功能相关不良事件属于样本内披露，不等全球长期患者零风险。AR 是重要生物通路，低暴露设计可降低系统影响，但研究仍须核本地组织及更长时间的安全。GT20029 痤疮 II 期达到主要终点、推荐后续百分之零点五剂量，是另一独立进展，不能当作脱发III期已经完成。模型中国 AGA 和痤疮分别设置开发成本与折价，没有使用同一高成功率；美国仍需后续 II 期及确证阶段，本章未因中国结果直接赋予美国成熟销售。

公司计划二〇二六下半年开展中国男性 II b/III 期并制定美国研究策略，启动和完成都依赖资金、研究者、患者和供应链。研发人员减少让近期费用下降，可能提高现金节约，却也可能限制同时推进多个项目的能力。若必须优先主药，GT20029 的长期时间表可能后移；即使科学数据未变，延期折现和额外融资也会降低当前每股价值。估值将平台研发和各适应症失败前仍需支付的开发费用保留，没有按成功率削减这些支出到一半，从而避免“失败了就不用付研发”的乐观假设。

## KT 939 与化妆品原料注册

KT-939 定位美白祛斑新原料，需要适当注册批准，不应与普通已使用成分混淆。九月七日公告确认九月四日完成五十二周人体长期安全研究，一百一十四名受试者连续使用百分之零点二，初步未见不良皮肤反应。研究为开放标签、单臂、单中心，主要评价长期局部安全，不能凭它推出与所有竞品相比的美白疗效优越性。它是注册资料的重要组成，而不是全部批准条件；公司表示积极推进并尽快完成提交，未核到截止日监管批准。本章把它列为原料条件现金流而非获批药物。

三月与孚诺医药合作开发含 KT-939 化妆品，与上美签附带化妆品领域排他条款的框架，八月还有康美合作。原料技术和成熟品牌渠道可以互补，但框架通常不同于有确定金额的不可撤销采购订单。取得文件没有支持立即确认大额保证收入或授权首付款，故模型授权现金为零、原料销售按审批及推广折价。排他条款也可能限制与其他客户合作，需要理解覆盖领域和实际权利，而不是只把大品牌名称视为销售保障。未来若出现最低采购、预付款或具体分成，需按条款和履约重新建模。

一月泡沫产品独家代理公告曾提及一亿元销售目标，二月补充明确它是长期累计目标，不是近期预期销售。不能将原公告数字直接作为年度收入指引，也不能将累计目标当新签订单。这一纠正提醒研究保留后续补充而非只搜最乐观标题。产品含 KX-826 的化妆品已经销售，不代表含同成分的药物可不经注册宣传药效；不同国家对成分、功效声称和跨境电商要求可能不同。合规销售及消费者反馈有助渠道验证，但不会将临床和注册剩余步骤取消。

KT-939 长周期潜力还取决于原料供应的质量一致性、制造成本、配方兼容、品牌采购集中和同类竞争。即使有独特机制，品牌也会比较功效、稳定性、价格和宣传证据。若原料卖给客户，其收入只包括原料经济份额，不能将客户终端全部商品零售价计入开拓收入。模型基准未风险峰值一亿八千万元原料收入属于研究假设，非市场测算确认，不把全美白消费总额乘任意份额来制造精确性。批准后若销售转化慢，应下调峰值及延后现金流，而不是只保持目标并等时间。

## 其他管线与被暂停项目

GT1708F 为 Hedgehog/SMO 抑制剂，恶性血液疾病 I 期十八名、含十五名 AML 和三名 MDS，显示安全及初步活动；部分髓系原始细胞下降不是与标准疗法相比的存活获益证明。不同剂量人数很少，不能把最高下降幅度作为全体患者效果。IPF 方面获得有条件 II 期研究许可，不等药品商业批准。资金紧张情况下其他管线可能寻求合作，潜在科学价值可以保留讨论，却缺乏可靠商业现金与开发安排。本章未将这些早期数据高额加入条件 rNPV，只保留平台费用和零额外正估值。

GT0486 为 mTOR 相关抑制剂，已取得临床许可并完成早期研究；肿瘤适应症的竞争激烈，联合方案、耐受和治疗线别会决定定位。GT90001 从辉瑞获得肿瘤领域全球独家许可，联合 Nivolumab 的早期二十可评估患者中八名部分缓解，有后续论文披露。小样本活动值得后续研究，不能把百分之四十缓解率机械视为未来注册成功概率或全市场占有率。授权来源也不等无需里程碑或经济负担，完整未来条款未在本条件模型用于正估值，避免忽视引进产品真实成本。

MYC/GSPT1 降解剂、分子胶、KT-215 外用 MPC 抑制剂等处于更早阶段。学术发表支持机制讨论，不能以期刊影响因子大小给股票定价。临床前 PCC 有机会进入人体，也可能因毒理、制造、暴露或患者效果而停止。公司研究平台有积累，但人员、资金与同时开展项目数量必须匹配。对十年展望，早期项目

提供更新产品组合的选择权；对当前股东估值，缺融资与临床路线时不适合将所有名称加成同额价值。本章将科学叙述和可计量现金流分开，不用管线数量代替质量。

GTO918 相关项目已经暂停，仍有过去合同下未清的应付款，说明项目结束不等费用义务全部消失。研发失败或战略转向会留下供应商合同、员工安排、资本化资产和研究资料处置问题。中报明确正与供应商协商延迟支付过期余额，不能把它们当永久无息免费资金。若欠款协调失败，可能影响声誉、未来试验合作或现金要求；若成功展期，也只是改变时间，不自动增加公司内在价值。模型风险储备和资金压力单列，未将暂停项目历史费用全加回为正常可盈利。

## 行业 经济和政策的真实传导

脱发和痤疮有广泛患者，但需求人数不等支付人数或长期用药人数。患者会比较现有成熟疗法、医生建议、使用便利、安全顾虑与价格，部分人接受外观变化、部分选择移植或其他产品。经济和就业信心偏弱会影响可选消费，即便健康需求存在；医药端若真实临床获益明确，也可能有更稳定需求。模型分化妆品、原料和药物，避免同一人口被三次计为独立市场。没有取得完整患者分层、年消费和停药率证据时，只给可编辑峰值假设并明示低可信度。

价格竞争对现有电商业务最直接。平台流量费用可能上升，竞争者可通过广告和折扣影响转换，毛利必须覆盖这些开支。本期商品毛利约百分之四十九点三，却销售费用率超过百分之一百一十，说明仅提高销售额不一定改善现金。若公司降低投放，短期收入可能放慢，但净现金可能改善；若投放带来高复购和自然传播，未来费用率才有下降基础。合理投资判断要求比较不同推广强度下的留存及净毛利，而非用宏观消费恢复作为费用改善的全部原因。

新药政策鼓励创新和审评效率有利行业，但监管不会因公司现金紧张而放弃有效性、质量和安全要求。药物与化妆品监管不同，美白新原料注册与 NDA 不能用同一进度表表达。创新药集采及医保新闻也不能全部套用可选消费皮科产品，真正影响取决于是否进入相关支付体系、上市价格及覆盖范围。海外授权规则的新闻说明行业风险偏好可能改变，却不能当开拓已经签约或美国市场批准。政策因素进入折现和情景条件，而不填造一个统一降价或统一批准概率。

融资环境与行业周期对公司特别重要。生物科技行情上涨可能提高配售价格、减轻新股稀释；行情低迷则有科学进展也可能难以筹资。较高利率和银行审慎会增加续期门槛，较低利率可能帮助利息但不会自动解决现金流入不足。上市公司股价低使相同融资额需要发行更多股票，而发行更多股票又可能压低每股价值，形成反馈。进取型标准应强调回报潜力，也必须展示这种融资路径；在它未确定时给精确多年度期望值，会把资金生存问题假装已经解决。

## 历史财务与利润质量

二〇二四年收入五百万元、毛损四百七十三万、归母亏损一亿五千五百二十九万二千。二〇二五年收入三千二百六十八万二千、毛利八百零三万九千、归母亏损二亿零十万七千。收入明显增但亏损扩大，反映商业投入、行政研发和其他项影响；二〇二六半年收入又扩大、毛利改善，亏损仍七千五百七十八万二千。这个历史不支持用成熟PE，也不支持仅凭收入增长认定已接近稳定盈利。必须看完整毛利扣费用后的经营亏损与经营现金，且年度无意见必须和所有数值一起呈现。

半年毛利二千五百六十六万五千，销售五千七百五十二万、行政二千二百三十万八千、研发二千七百三十六万三千，其他净项之后经营亏损八千一百三十二万二千。销售推广中的五千二百四十五万元是最大部分，几乎等于总收入。与去年同期比，研发减少约百分之四十三点七，原因包含上一年度已确认大部分Ⅲ期费用和研发人员下降；这不是研发能力突然零成本。净亏损减少约百分之九主要来自费用变化，不等化妆品已经完整自我融资。将全部亏损称作一次性投入并删除，会忽略持续服务和获客支出。

联营及合营收益四百六十万使税前亏损从经营亏损加财务后有所收窄，税项贷记三百零二万三千又使净亏损较低。投资应区分经营商业化收入与权益法收益，后者可能不同时产生母公司现金。税务贷项也不等亏损期间得到同额现金补贴；递延负债变化和确认方式会影响损益。条件现金流采用营业税后资本现金，不用本期税贷项提高未来销售利润。没有取得全部非经常投资变动细节，不将其永久化；既有联营投资也未以账面值在药物现金流上额外叠加一遍。

年度二〇二五经营现金流出一亿六千九百七十三万七千，年末现金三千二百七十三万七千，比二〇二四年末一亿四千七百四十一万九千大幅下降，期间还有发行股份取得八千二百六十四万九千人民币资金。二〇二四经营现金流出一亿九千九百零八万。可见现金减少不是仅一个临床季度的偶然，融资和资产处置已参与支撑。二〇二六半年现金接近年初并不表示经营平衡，它靠新借款六千七百九十万抵销经营流出及偿债。这种资金来源变化会影响未来普通股风险。

## 现金跑道 债务与继续经营

六月底现金三千一百二十九万七千，限制现金五十万一千，存货一千一百万八千，不可把库存误看现金。半年经营流出五千零六十九万四千，简单按平均月消耗、不计债务得到三点七〇个月现金跑道。这个数字只是机械压力指标，实际支出有时间差、收入增长和信用额度变化，不能预测某一日必然资金耗尽；但它明确说明不能拿小额现现金支撑无限期研发。未动用银行额度七千零一十万是潜在融资来源而非已经到账，自由使用还可能受条件和银行决策影响。

流动资产四千八百二十九万四千、流动负债一亿八千二百九十二万六千，流动净负债一亿三千四百六十三万二千。借款一亿三千二百九十万均一年以内或可随时要求，租赁负债六十八万三千另列，现金减这些约负一亿零二百二十八万六千。净债说明义务规模，却不等全部立即同日付现金，需要具体到期及续期安排。财报附注已有九月、十月、十一月、十二月和后续季度的不同借款；截至日最新逐笔续期全表未取得，不能假定所有九月到期款都已自动延期。

有抵押六千五百万元主要由物業和土地使用权支持，董事担保和无抵押银行借款另有结构，关联小额贷款公司两笔合计二千万元。相关贷款六月附注列十月十三及十二月八日到期，是很近的资金观察节点；个人担保有助贷款，但不保证无条件额外资本投入或股东无风险。关联融资应看定价、期限、是否续期和其他债权约束，不能仅因董事担保就理解为无限资金。中报管理讨论还提到续期金额在报告期后变化，需要区分六月附注与报告日更新，不重复计同一笔额度。

贸易应付款三千一百八十五万三千、其他薪资和应计一千七百五十四万五千，共四千九百三十九万八千。其中部分逾期与暂停项目有关，欠款展期讨论尚不能当作已豁免。当前资产以固定资产、无形和使用权等非流动为主，资产总额三亿一千八百九十三万九千、净资产一亿零九百二十二万四千。卖出资产可能改善现金，却也可能削弱后续制造或需要成本；账面无形和土地值不保证清算可全收。条件 NPV 包含经营资产作用，没有将这些账面值再加成独立可兑现现金。

董事编制继续经营的措施包括新药商业化、化妆品毛利和销量、投资出售、供应商延期、新额度、再融资和股权筹资。每一项都有不同成败条件，且可能互相关联：股价弱会妨碍配售，未筹资会延缓临床，临床延迟又影响潜在合作。附注明确如果无法实现措施，可能需资产减值、增加负债准备及重新分类，这些未反映在目前持续经营报表。研究不能将董事十二月预测看作独立保证，也不能把无法表示意见简化为财报已经被认定造假。准确描述是审计无法形成意见，资金不确定需要解决。

五月公告称 PwC 在届满后退任、新容诚香港拟接任，公司董事及审计委员会称不存在分歧，PwC 未按当地法律被要求提供特定退任确认。研究保留这些原始说法，既不推断审计师必因争议退出，也不推断换人让原问题消失。九月 CFO 更替亦是治理跟踪事件，不应无证据归为财务造假或正常化成功。真正支持上调可信度的是新年度审计意见、融资及现金实证和既有措施兑现。当前中报未经审计，不能因为公司公告书写完整就赋予无风险鉴证标签。

## 股数 融资和普通股价值

九月月报全法律股份四亿九千八百六十六万零一百、零库存、授权七亿。授权股数不等已发行，也不等可在任何时点无手续发行全部。六月股东会一般授权可发行九千九百七十三万二千零二十，与现股数约百分之二十相关；条件模型部分未来发行超过当前授权，需要后续股东批准、授权更新或其他合

法安排，不能写成公司已决定发行。模型分母全部法律股，不只自由流通和不扣未授信托。未来增股既带资金，也改变原股东权益，需要同时计算。

半年激励授予及信托转移不一定新增法律股数。约四百六十七万八千八百七十六股归属转给承授人，期末待归属六十八万二千三百、尚未授出四百三十四万三千三百六十四。信托中已发行股份不当库存股再次扣掉，也不将所有尚未授出计划池未来再加一次。股权费用三十九万七千目前不大，却仍是利润及人才成本，模型平台和行政预算保留费用。经营困境中奖励安排需看是否支持人才留存和每股价值，而非只因为金额较小就完全忽略稀释和治理。

融资的数学很直接：同样一亿元净资金，配售价越低需要越多股；有折价和费用时毛融资还要更高。融资现金不能在价值模型加一次，同时继续用融资前股份作分母。条件基准年底股数六亿、后续六点四、七、八、九亿，悲观更高，乐观较低；目标现金、债务和累计融资额一起保存。它们是可编辑研究假设，未证明已获投资者承诺。若融资金额不足、折价更大或附带优先权，普通股对应价值需另核，不能使用只表现股份面值而不体现证券条款的简单模型。

## 量价 弱趋势没有自动反弹含义

锁定收盘一点六三五港元，当日成交九十七万一千五百股、成交额一百五十六万八千三百一十五港元。单位是股，量价数据有两根 OHLC 逻辑修复并留痕，不能乘成手数。成交额有限，实际买卖可能有价差和冲击，尤其新药、融资或偿债消息时。低股价不等低市值风险更小，也不代表买入数量多就利润空间大。量价分析可帮助识别当前市场接受度，却无法证明资金链或药物审批，财务约束在推荐判断中优先于技术形态。

二十、六十、一百二十、二百五十日均线约一点八二八、一点七七九、二点一一一、二点二八二，现价均在下方，距约负百分之十点五五、八点一二、二十二点五五、二十八点三六。近五日斜率四线皆负，短中长均线均未给出明确趋势反转支持。近二十日负百分之十三点〇三、六十日负十一点六二、一百二十日负四十点一一，弱势延续而非单一天回调。即使核心临床曾有好消息，市场仍在考虑融资、竞争和兑现时间，不能把均线下方简单叫低估买点。

五十二周高四点七、低一点五八，现价离高约负百分之六十五点二一、离低约正三点四八，样本最大回撤约百分之六十四点九四。接近年度低点只说明过去价格区间，不能证明下方必有买盘或最大损失已经发生。临床公司在稀释、资金和审批变化时可以不断刷新低点。局部二十及六十日支持同为一点五八，距现价负百分之三点三六，上方阻力二点〇九距正百分之二十七点八三；这些为窗口极值观察位，未经触碰次数确认，不当精确止损或目标指令。

五、二十、六十日均量约六十六万六千八百、五十九万三千七百、八十六万九千四百五十八股，当日量比一点七二，以前二十日均量五十六万四千五百五十作分母。放量发生在弱趋势低位，可表示换手增加，却不知道新资金目的，也不能断言机构开始吸筹。过去二十日上涨八、下跌十一，上涨量四百七十万二千、下跌六百九十三万九千五百，上下比零点六七八，对反弹确认不利。要看后续上涨日持续收盘、成交和市场强弱是否变化，而不是一次量比高就预测半年上涨。

RSI 约三十七点一六，MACD 快慢差负零点〇三七、信号负零点〇一一、柱负零点〇五三，动能仍偏弱。ATR 零点一〇九港元，占价格约百分之六点六六，日常波幅已经大于近端支持距离；过于精细几分钱观察容易被普通波动打断。RSI、MACD 和均线来自同一价格信息，不当三项独立证据重复加权。本章暂不评分，仍说明指标辅助含义，不把偏低 RSI 解释成必涨，也不将模型条件乐观价格作为量价图已经验证的目标。

周线二十、六十、一百二十周均线一点九一一、二点二八一、一点七六一，现价都在下，短中周均线下降，二百五十周缺数据不补造。周 RSI 约三十八点八三，MACD 负柱，ATR 约零点二九五占百分之十八点〇六，较高波动显示消息和流动性影响明显。最近二十周上/下量约零点七二九，没有稳定强周趋势证据。若未来连续回到一点七五至一点八五区域并形成正斜率，再伴融资落地和临床事件，可提高技术判断；若跌破一点五八且反抽失败，当前弱势条件强化，不能只靠跌深了维持看涨。

相对恒指二十日落后约十点〇五、六十日八点四三个百分点，对粗粒度港股通创新药基准落后二十日十三点九一、六十日八点四〇。该指数是官方单来源、价格回报、行业混合，成交量禁用，不是专门皮科公司基准。两组相对表现说明近期弱势超出一般市场，仍不能识别具体卖方或资金身份。条件改善需公司证据与相对强弱共同变化；若全市场上涨而公司持续弱，重新检验融资及产品预期。无逐笔和真实自由流通分母，本章不画精确筹码图和“主力出货”推断。

## 条件估值 有限现金流而非 PE

开拓当前亏损，负每股利润不适合成熟 PE，本章采用分分子、适应症及地区的阶段折价现金流。七块为 KX 中国男性 AGA、美国男性 AGA、中国女性、中国痤疮，GT20029 中国 AGA 与痤疮，以及 KT-939 原料；既有化妆品另算实际商业延伸。每块保存未风险收入、毛利、销售费、成功率、开发支出和上市时间。开发未成功仍可能消耗资金，所以失败前支出不按成功率削减；集团行政和平台研发也完整保留。没有把每个管线名称统一加一个固定 NPV。

基准中国男性 KX 初始条件成功率百分之六十五，相比其他 II 期和原料不同，依据中国III期对照结果积极、未核 NDA/批准及 CMC 和资金风险。美国男性百分之二十三、中国女性三十、KX 痤疮二十七，GT20029 两适应症二十八和二十六，原料五十五，全部属于研究判断而非数据库统计预测。后面目标时

点略提高成功折价仅在融资及后续验证成功条件下，不是时间过去自然提高成功率。若失败或无资金，应重建而非留着原值等待；没有给公司资金生存概率一个伪精确数字。

基准中国男性未风险峰值八点五亿元、美国六点五、女性二点五、痤疮二亿，GT 两个五点五和三点五亿，原料一点八亿。这些不是独立市场份额研究得出的精确指引，必须明确输入低可信度。上市前为零，上市后逐步爬坡，地区和适应症不重复算同一病例；海外以完整自营经济权益为条件，没有加首付款、里程碑或再添一个授权估值。未来若签合作，需把销售净分成、研发负担、许可支出和资金影响一起替换，不能同时保留全自营利润与授权大额首款。

核心专利在中报明确到二〇三〇年九月八日，长期模型不能假设所有 KX 收入都有二〇四〇年前独占保护。本章二〇三一年开始给每年额外百分之十五收入侵蚀，已把基准年底价值从约零点九六下修至零点四四，显示专利期限的重要性。这是竞争侵蚀研究参数，不等法律上到期当日全部销售为零，也不假定剂型、用途或补偿延长已获。若后续有更完整保护范围，应按国家、用途、权利和竞争重核；在证据缺时不能用“专利布局”一句话忽略核心日期。

年度经营原子先加化妆品及风险折价产品收入，扣相应销售成本和推广，再扣行政、平台研发及独立开发费用，得到经营利润；正利润按税率扣税，加折旧、扣资本开支和营运资金增量，形成 FCFF。所有现金流仅到二〇四〇，不设永续终值，目标后已过年份不再计入。企业价值加目标现金、扣目标借款和额外风险储备，再除融资后全部股数并按人民币港元一点一换算。这套现金流不包括借款利息，债务在股权桥扣一次，不能又扣利息又把净债重复扣两遍。

土地、固定资产、资本化无形和平台已支持经营现金，不再按账面加一份 NAV。集团投资可能变现改善融资，但未来确定售价缺，本章不在条件 NPV 额外加入全账面联营；已存现金和未来融资现金只通过目标现金桥影响，不把发行额一次性全部加上而忽略研发烧钱。偿债、展期及到期现金与目标债务存量要一致，负压力模型说明如无新股仍可能现金不足。条件模型是结构化敏感性，没有完成每年全法人三张表，也不宣称能证明实际现金安全。

## 四期限的逻辑与失效路径

半年观察最关键是融资、近到期贷款、KT-939 注册和 KX 申报，尚非成熟药物销售利润兑现。条件基准零点五四、乐观四点九六代表成功筹资与审评潜力不同，不能用它算正式半年期望涨幅。若年底或半年融资未落地，即便临床科学未发生负面变化，现金时间表也可推翻估值前提。技术回稳可改善交易观察，却不能代替资金文件。短期估值需要实际配售价格、净资金、债务安排及股数，缺这些决定性输入时保留正式评分空白比假定融资价格更诚实。

一年到二〇二七十月可能接近管理预期审批节点，基准仍谨慎将商业收入延至二〇二八，参考零点八六、乐观五点三二，差别包含收入、费用、折价和融资。审批成功不等终端销售直接达到峰值，渠道和患者仍需转化；审批延迟若不危及资金尚可后移，但新增研发和新股会影响每股价值。反证包括未完成申报、CMC 补充过多、药物真实产品依从性不支持定价、化妆品净现金持续亏损。未发生这些条件也不意味着乐观已实现，需要逐条公开证据。

三年主要看 KX 商业化能否接近稳定净毛利、GT20029 有无确证进展和原料合作真正收入，同时已经接近核心专利后半段。条件基准一点三一、乐观五点七九，资金后仍有大的价值差异。股数基准八亿，体现多轮开发和商业化的资本需求，不能坚持现四点九九亿而享受同样多资金。若主药获批但低价竞争、渠道推广和复购使净现金很少，药物研发成功仍可能让原股东回报失望。研究长期看每股剩余现金流，不只看药品上市清单。

五年条件基准一点三七、乐观五点一六，乐观相对三年反而低一些，原因包括剩余有限现金流缩短、专利侵蚀和股数增加。这说明目标价不需要随着时间机械上升。新药组合和品牌若能替代核心保护减弱，长期价值可改善；若 GT 研究停滞、原料竞争和现金支出持续，五年仍可能没有普通股正价值。没有股息假设，不给累计息或年化收益来伪装正式推荐；条件表只帮助理解业务与资金参数，不参与四榜的同分比较。

## 外资目标缺失与反证框架

公开新闻池未取得截止日前可核个股近期外资目标价。有行业授权、集采和医疗风险偏好报道，但它们不是开拓目标，不能把行业乐观看法改写成机构买入。若网页返回导航或无日期正文，亦不能从标题碎片补造评级、币种和报告期限。既然原研报和有效目标缺，本章记录缺失，未以分析师旧峰值价制造上行空间。未来取得报告，应按机构最新有效一次去重，保持十二个月期限参考，不复制为年底目标或按月缩放。

上调研究判断应由可核事件推动：新资金到账且融资条件合理、续期覆盖近期债务、供应商协议明确、申报受理和质量进度、报告销售毛利后净现金转好、真实复购和自然渠道贡献提高。仅一条管理乐观声明、一次会议奖项或股东增持都不能同时满足这些条件。董事增持可以显示自身选择，既不提供公司经营现金，也不保证个人判断正确；需要和融资及业务证据分开。反过来，重大安全或监管问题、无法筹资、提款条件受限、销售退货和投放失效，可立刻降低条件 NPV，不需等年度亏损全部体现。

## 十年持续性与研究可信度

十年潜在成功路径是皮科临床积累转成合规有效产品，产品收入资助新分子，渠道能够低成本服务真正留存消费者，资本配置使研发组合随专利变化更新。失败路径则是核心保护期消耗于筹资和延期、营销不断买收入、研发人才缩减、新分子无法推进而仍有合同债务。十年科学平台价值不能脱离可持续资本，普通股也不是不受稀释的所有项目所有权。早期分子可以提供选择权，本章没有为它们虚构十年价格，也不把严肃科学研发贬为没有价值；只是要求价值兑现条件明确。

公司转向消费原料需要新增能力：品牌和消费者沟通、退货、供应商及电商渠道，与药物注册和临床管理不同。成功协同能利用渠道洞察和原料技术，失败协同会分散有限人员和资金。十年必须检查资源分配是否服务每股价值，而非在热点领域之间不断切换叙事。研发费用下降可以减少近期消耗，但如果导致更新管线停滞，长期保护变弱；营销提高可打开渠道，但没有复购经济会增加现金风险。合理长期判断是两类投入的净回报，而不是每次业务转型都自动再加估值。

来源层面，原件披露的财务、试验及股数可以追溯，但财务未经中期审计、年度无法意见要同时说明；科学顶线数字由发行人披露，完整统计和比较数据并未全部取得。锁定技术可计算、行业指数仅粗粒度单源，未来价格和资金概率低可信度。条件成功率、峰值、融资、现金债务和折现全为研究假设，不能改称“预计一定”或“共识”。暂不排名正是证据限制的明确结果，完整研究与空白正式数字并不矛盾。待核心资金和审评问题解决，再建立可比较评分、正式情景和期望价。

## 来源

- 2026H1 结果，8 月 19 日 22:32 收盘后：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0819/2026081901703.pdf

- 完整中报，9 月 29 日 19:53 收盘后：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0929/2026092901641.pdf

- 2025 年报及 PwC 无意见，4 月 29 日 22:48 收盘后：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906228.pdf

- 9 月月报，10 月 2 日 13:05：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1002/2026100200891.pdf

- KX-826 中国III期，3 月 18 日 20:53：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0318/2026031801532.pdf

- KT-939 长期安全完成，9 月 7 日 06:07：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0907/2026090700007.pdf

- 销售目标补充，2 月 12 日 16:49：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0212/2026021200514.pdf

- 审计师退任与更替，5 月 26 日 22:20：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0526/2026052602018.pdf

- 完整来源、行情修复、条件原子与独立核验

见 data/kintor_sources.json、data/kintor_supplement.json、data/market_snapshot_locked.json、data/kintor_model.pending.json 和 qa/kintor_qa.json。